

Buku Ajar

KEBIDANAN KOMUNITAS

POSYANDU, KIA, DAN PELAYANAN BERBASIS KELUARGA

Susilia Idyawati • Maria Florentina Nining Kosad • Humaediah Lestari
Vepti Triana Mutmainah • Rizky Febriyanti Supriadi • Priscilla Jessica Pihahy

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



BUKU AJAR: KEBIDANAN KOMUNITAS: POSYANDU, KIA, DAN PELAYANAN BERBASIS KELUARGA

Penulis:

Susilia Idyawati, S.ST., M.Kes.
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes
Bdn. Humaediah Lestari, SST., M.Kes
Bdn. Vepti Triana Mutmainah., M.Kes.
Rizky Febriyanti Supriadi, S.ST., M.Keb.
Priscilla Jessica Pihahay SKM., M.K.M

Editor:

Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Buku Ajar: Kebidanan Komunitas: Posyandu, KIA, dan Pelayanan Berbasis Keluarga

Penulis:

Susilia Idyawati, S.ST., M.Kes.
Maria Florentina Nining Kosad, SST., M.Kes
Bdn. Humaediah Lestari, SST., M.Kes
Bdn. Vepti Triana Mutmainah., M.Kes.
Rizky Febriyanti Supriadi, S.ST., M.Keb.
Priscilla Jessica Pihahay SKM., M.K.M.

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-81-7

Cetakan Pertama: Agustus, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar “Kebidanan Komunitas: Posyandu, KIA, dan Pelayanan Berbasis Keluarga” ini dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan derajat kesehatan ibu, anak, keluarga, dan masyarakat.

Kebidanan komunitas merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan primer karena berfokus pada upaya promotif, preventif, kuratif dasar, dan rehabilitatif sederhana yang dilakukan secara berkesinambungan di tengah masyarakat. Peran bidan tidak hanya terbatas pada pelayanan klinis, tetapi juga mencakup pemberdayaan keluarga, pembinaan kader, penguatan Posyandu dan UKBM, pengelolaan data kesehatan, serta pelaksanaan pelayanan KIA yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai konsep dasar kebidanan komunitas dan peran bidan di pelayanan primer. Pembahasan dalam buku ini mencakup pemetaan masalah kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja melalui data, surveilans, dan penetapan prioritas; tata kelola Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; alur pelayanan serta pembinaan kader; pelayanan KIA terpadu di Puskesmas dan desa yang meliputi antenatal care, persalinan, masa nifas, dan neonatus; kunjungan rumah serta continuity of care; hingga promosi kesehatan dan komunikasi, informasi, edukasi KIA melalui metode, media, dan strategi perubahan perilaku.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat membantu peserta didik memahami keterkaitan antara teori dan praktik kebidanan komunitas. Melalui materi yang disajikan, pembaca diharapkan mampu menganalisis masalah KIA di masyarakat, menyusun prioritas intervensi, melaksanakan pelayanan berbasis keluarga, melakukan pencatatan dan dokumentasi secara tepat, serta membangun komunikasi yang efektif dalam mendukung perubahan perilaku sehat.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu kebidanan, peningkatan kompetensi calon bidan, serta penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan buku ajar ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan komunitas dan kesehatan keluarga di Indonesia.

Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v

BAB 1 KONSEP DASAR KEBIDANAN KOMUNITAS DAN PERAN BIDAN DI PELAYANAN PRIMER

1	1
A. Konsep Kebidanan Komunitas.....	2
B. Ruang Lingkup Kebidanan Komunitas	3
C. Ruang Lingkup Kebidanan Komunitas	5
D. Prinsip-prinsip Pelayanan Primer.....	5
E. Posisi Kebidanan komunitas dalam Pelayanan Primer	6
F. Peran Bidan dalam Pelayanan Kebidanan	7
G. Prinsip-prinsip Etika Kebidanan di Komunitas.....	8
H. <i>Patient Safety</i> dalam Kebidanan Komunitas	9
I. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	10
J. Soal OSCE Kebidanan	12
K. Portofolio.....	18
L. Ringkasan Materi.....	23
M. Alur asuhan singkat	24
N. Form Checklist “Saya sudah bisa...”	25
O. Referensi	26

BAB 2. PEMETAAN MASALAH KIA DI WILAYAH KERJA: DATA, SURVEILANS, DAN PENETAPAN PRIORITAS

28	28
A. Pemetaan Masalah KIA di wilayah Kerja: Data, Suveilnas, dan Penetapan Prioritas	29
B. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	30
C. Soal Osce Kebidanan	31
D. Ringkasan Materi.....	46
E. Alur asuhan singkat	46
F. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	47
G. Form Checklist “Saya sudah bisa...”	48
H. Referensi	49

BAB 3 POSYANDU DAN UKBM :TATA KELOLA, ALUR PELAYANAN, DAN PEMBINAAN KADER.....51

A. Teori Dasar.....	60
B. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	62
C. Soal Osce Kebidanan	63
D. Portofolio.....	71
E. Ringkasan Materi.....	75
F. Alur asuhan singkat.....	76
G. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	76
H. Form Checklist “Saya sudah bisa...”	78
I. Referensi	79

BAB 4 PELAYANAN KIA TERPADU DI PUSKESMAS/ DESA INTEGRASI ANC, PERSALINAN, NIFAS DAN NEONATUS80

A. Pelayanan kesehatan Ibu dan anak Terpadu.....	81
B. Komponen Layanan terintegrasi.....	83
C. Aktivitas belajar mahasiswa	92
D. Soal OSCE Kebidanan	92
E. DOPS (<i>Direct Observation of Procedural Skills</i>).....	94
F. Portofolio.....	94
G. Case Report	94
H. Refleksi Patient Safety	94
I. Rangkuman Materi	95
J. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	96
K. Daftar Pustaka	97

BAB 5 KUNJUNGAN RUMAH DAN CONTINUITY OF CARE: PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN DOKUMENTASI..... 100

A. Kunjungan Rumah.....	102
B. Continuity of Care (CoC).....	102
C. Tujuan.....	104
D. Efektivitas CoC Berdasarkan Riset Terbaru.....	105
E. Indikasi dan Kotraindikasi Kunjungan Rumah	106
F. Alat dan Bahan (Midwifery Home Visit Kit).....	108
G. Tahap Perencanaan Kunjungan Rumah	111
H. Tahap Pelaksanaan Kunjungan Rumah	113
I. Tahap Evaluasi Kunjungan Rumah.....	117
J. Dokumentasi Asuhan Kunjungan Rumah.....	118
K. Aktivitas 1: <i>Knows How</i>	121
L. Soal OSCE Kebidanan	123
M. Penerapan DOPS pada Kunjungan Rumah dan <i>Continuity of Care (CoC)</i>	133

N. Portofolio: Bukti Kompetensi <i>Continuity of Care</i> (CoC)	137
O. Ringkasan Materi.....	144
P. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	147
Q. Form Checklist "Saya sudah bisa..."	150
R. Referensi	154

BAB 6 PROMOSI KESEHATAN DAN KIE KIA: METODE, MEDIA, DAN STRATEGI PERUBAHAN PERILAKU 158

A. Konsep Promosi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas.....	162
B. Teori Perubahan Perilaku dalam Praktik KIE.....	167
C. Media Promosi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas.....	170
D. Metode Promosi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas.....	172
E. Strategi Perubahan Perilaku dalam Pelayanan KIA.....	175
F. Tahapan Strategi Perubahan Perilaku.....	175
G. Prinsip Strategi yang Efektif dalam Kebidanan Komunitas.....	177
H. Aktivitas Belajar	177
I. Latihan Reflektif	179
J. Penugasan Kelompok	179
K. Evaluasi Kompetensi: Rubrik OSCE dan DOPS dalam Promosi Kesehatan dan KIE KIA.....	180
L. Rangkuman Materi	182
M. Glosarium	183
N. Referensi	185

PROFIL PENULIS..... 187

BAB 1

KONSEP DASAR KEBIDANAN KOMUNITAS DAN PERAN BIDAN DI PELAYANAN PRIMER

Capaian Pembelajaran

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Mampu menguasai konsep, kebijakan dan prinsip pelayanan kebidanan komunitas serta pelayanan KIA primer berbasis bukti

CPMK

CPMK 1 : Menguasai konsep kebijakan dasar dan peran profesi dalam kebidanan komunitas serta prinsip etika keselamatan di pelayanan primer

Sub-CPMK

Sub CPMK 1.1 : Menjelaskan ruang lingkup, prinsip, dan posisi kebidanan komunitas dalam pelayanan primer

Sub CPMK 1.2 : Menguraikan peran bidan, etika profesi, dan keselamatan pelayanan pada konteks komunitas.

Uraian Materi

Kebidanan komunitas merupakan salah satu pilar penting dalam system pelayanan Kesehatan yang berfokus pada Upaya promotive dan preventif dengan pendekatan keluarga dan Masyarakat. Pada pelayanan primer, bidan memiliki posisi strategis sebagai tenaga Kesehatan terdepan yang berinteraksi langsung dengan individu, keluarga dan komunitas/Masyarakat.

Transformasi sistem Kesehatan saat ini menekankan penguatan pelayanan primer sebagai upaya strategis dalam menempatkan fasilitas kesehatan Tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik Pratama atau Dokter Keluarga sebagai pintu utama dan pengatur alur pelayanan kesehatan Masyarakat.

Selain aspek teknis, bidan juga dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi dan menjamin keselamatan pasien (*patienty safety*), terutama dalam konteks komunitas yang memiliki kompleksitas sosial, budaya dan keterbatasan sumber daya.

A. Konsep Kebidanan Komunitas

Kebidanan komunitas merupakan pengembangan dari praktik kebidanan klinis yang diperluas ke dalam konteks Masyarakat. Pendekatan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga mencakup keluarga dan Masyarakat dengan mempertimbangkan determinan sosial, budaya ekonomi dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.

Dalam paradigma kesehatan modern, kebidanan komunitas menjadi bagian integral dari pendekatan public health midwifery, dan lebih menekankan pada pencegahan penyakit. Promosi kesehatan serta pemberdayaan Masyarakat.

Kebidanan komunitas merupakan praktik kebidanan yang berfokus pada pemberian pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara berkesinambungan di Masyarakat, dengan menekankan pada peningkatan kualitas hidup melalui pendekatan promotive, preventif dan berbasis kebutuhan komunitas (WHO, 2016)

Kebidanan komunitas merupakan praktik kebidanan yang dilakukan diluar fasilitas kesehatan, yang berorientasi pada keluarga dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan reproduksi melalui asuhan yang komprehensif, berkesinambungan dan berbasis kebutuhan individu serta Komunitas (Varney's Midwifery, 2007)

Kebidanan komunitas Adalah pelayanan kebidanan yang dilaksanakan di wilayah kerja tertentu dengan pendekatan keluarga dan Masyarakat, mencakup upaya promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative sederhana dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak (Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebidanan komunitas Adalah praktek kebidanan yang berorientasi pada individu,

keluarga dan Masyarakat dalam suatu wilayah kerja dan dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan melalui pendekatan promotive. Preventif, kuratif dasar dan rehabilitasi sederhana, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak berbasis kebutuhan di komunitas.

B. Ruang Lingkup Kebidanan Komunitas

Ruang lingkup kebidanan komunitas mencerminkan keluasan peran bidan dalam system pelayanan primer yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga keluarga dan Masyarakat. Ruang lingkup ini mencakup seluruh siklus kehidupan Perempuan dan anak serta melibatkan pendekatan promotive, preventif, kuratif dasar dan rehabilitasi sederhana.

Pendekatan dalam kebidanan komunitas menggunakan kerangka berpikir yang komprehensif, terdapat tiga pendekatan utama yang menjadi landasan dalam kebidanan komunitas yang saling berkaitan dan menentukan kualitas pelayanan kebidanan di Tingkat komunitas yaitu: Holistik, kontinyu dan terintegrasi.

Pendekatan Holistik

Pendekatan holistic dalam kebidanan komunitas merupakan pendekatan yang memandang individu (Ibu, bayi dan keluarga) sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari berbagai dimensi yang saling mempengaruhi yang terdiri dari dimensi biologis, psikologis, sosial dan kultural.

Dimensi biologis: meliputi kondisi fisik dan medis dari individu itu sendiri, seperti status kehamilan, tanda vital, status gizi dan penyakit penyerta.

Dimensi psikologis: meliputi kondisi emosional dan mental yang mempengaruhi kesehatan, seperti: kecemasan ibu hamil, depresi postpartum serta kesiapan menjadi ibu.

Dimensi Sosial: meliputi hubungan sosial dan lingkungan. Seperti: dukungan keluarga, status ekonomi dan akses layanan kesehatan.

Dimensi kultural: meliputi dimensi nilai, norma dan kepercayaan yang dapat mempengaruhi status kesehatan individu seperti: praktik tradisional, pantangan makanan serta kepercayaan terhadap tenaga kesehatan.

Contoh kasus: Seorang ibu hamil G1 UK 20 minggu, di Desa T, menolak konsumsi tablet Fe karena kepercayaan tradisional. Maka sebagai seorang bidan dapat menggunakan pendekatan holistic dalam menyelesaikan kasus tersebut, dengan menjelaskan risiko anemia (dimensi biologis), mengurangi ketakutan ibu (dimensi psikologis), mengikutsertakan/melibatkan keluarga (dimensi sosial) serta memahami dan menyesuaikan pendekatan edukasi sesuai dengan budaya setempat (dimensi kultural)

Pendekatan Continuity of Care (kontinu)

Pendekatan *Continuity of Care* (CoC) Adalah pemberian asuhan kebidanan secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan Perempuan, dimulai dari remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas dan bayi dan anak.

Prinsip utama CoC adalah:

Keterhubungan antar tahap kehidupan, dimana masalah kesehatan pada satu tahap kehidupan akan mempengaruhi tahap kehidupan selanjutnya

- a. Konsistensi tenaga pelayanan, dimana idelanya pasien ditangani oleh tenaga kesehatanyang sama atau tim yang terkoordinasi.
- b. Pelayanan berkelanjutan tanpa terputus, tidak hanya saat sakit tetapi juga sepanjang siklus kehidupan.

Manfaat pendekatan CoC adalah dapat mendeteksi dini risiko secara berkelanjutan, pencegahan terjadinya komplikasi, meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat meningkatkan kepercayaan pasien.

Pendekatan Terintegrasi

Pendekatan terintegrasi merupakan penyelenggaraan pelayanan kebidanan yang menggabungkan berbagai program kesehatan dan melibatkan berbagai sektor untuk mencapai hasil yang optimal (lintas program dan lintas sektor)

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa masalah kesehatan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional.

Integrasi Lintas Program (ILP) di komunitas merupakan penataan ulang layanan primer yang berfokus pada siklus hidup (ibu hamil hingga lansia), bukan lagi berdasarkan penyakit. ILP ini mengintegrasikan berbagai program kesehatan ke dalam 5 kluster yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi dan kesinambungan pelayanan. Lima kluster tersebut terdiri dari kluster manajemen, kluster ibu-anak, kluster dewasa-lansia, kluster penyakit menular dan lintas kluster).

Integrasi lintas sektor merupakan kolaborasi rutin antara petugas puskesmas dengan pemangku kepentingan terkait (kecamatan, desa, sekolah, tokoh Masyarakat) untuk menyinkronkan perencanaan, memantau pelayanan dan memecahkan masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas tersebut. Peran bidan dalam integrasi ini adalah sebagai coordinator pelayanan kesehatan, penghubung antar sektor dan atau fasilitator kolaborasi.

Manfaat dari pendekatan integrasi ini adalah pelayanan lebih efisien, mengurangi duplikasi program dan meningkatkan outcome kesehatan serta menyelesaikan masalah kesehatan secara komprehensif.

C. Ruang Lingkup Kebidanan Komunitas

Ruang lingkup kebidanan komunitas meliputi pelayanan komprehensif bagi individu, keluarga dan Masyarakat dengan focus pada kesehatan ibu dan anak (KIA). Fokus Kegiatan kebidanan komunitas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak di Masyarakat, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, kemitraan dengan Masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan setempat.

D. Prinsip-prinsip Pelayanan Primer

Prinsip pelayanan kesehatan primer berfokus pada pendekatan komprehensif, terintegrasi dan berpusat pada individu/keluarga untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat. Prinsip utamanya mencakup Aksesibilitas, pelayanan berkesinambungan (CoC), komprehensif (promotive sampai rehabilitasi), koordinasi, partisipasi Masyarakat, berbasis bukti (*Evidence-Based Practice*).

1. Aksesibilitas (accessibility)

Pelayanan kesehatan harus mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara geografis (jarak, transportasi), ekonomi (biaya terjangkau), sosial (tanpa diskriminasi). Contoh, pelayanan ANC di posyandu atau kunjungan rumah, pelayanan gratis/subsidi bagi ibu hamil risiko tinggi dan atau penyesuaian jadwal pelayanan dengan kondisi Masyarakat.

Pelayanan berkesinambungan (CoC)

Pelayanan diberikan secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan Perempuan. Seperti pemantauan ibu hamil secara rutin (K1 dan K4), Kunjungan Nifas (KF1 sampai KF3), Kunjungan Neonatus (KN 1 sampai KN4) serta dokumentasi berkelanjutan.

Komprehensif (Comprehensiveness)

Pelayanan komprehensif dan terintegrasi yang diberikan mencakup promotive (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif dasar (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) secara berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan intervensi.

Koordinasi (*Coordination*)

Pelayanan dilakukan secara terintegrasi dengan sistem rujukan, tenaga kesehatan lainnya dan program-program kesehatan lainnya.

Partisipasi Masyarakat (*Community Participation*)

Keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Seperti keterlibatan kader posyandu, kelas ibu hamil, penyuluhan/edukasi pada keluarga

Berbasis bukti (Evidence-Based Practice)

Evidence-Based Practice dalam kebidanan komunitas merupakan penggunaan bukti ilmiah terkini dan preferensi pasien untuk memberikan asuhan yang aman dan efektif, sehingga setiap Tindakan pelayanan didasarkan pada: bukti ilmiah, standar profesi dan pedoman nasional/internasional.

E. Posisi Kebidanan komunitas dalam Pelayanan Primer

Dalam system pelayanan kesehatan primer, bidan menempati posisi strategis sebagai ujung tombak (*frontline provider*) karena memiliki akses langsung dan berkelanjutan dengan Masyarakat, khususnya Perempuan, ibu dan anak. Posisi ini memungkinkan bidan berperan dalam upaya promotive, preventif hingga deteksi dini risiko secara efektif.

Posisi bidan dalam berbagai pelayanan primer:

1. Puskesmas: Bidan di puskesmas berperan sebagai pelaksana utama program Kesehatan Ibu dan Anak, seperti pelayanan ANC, PNC dan KB, skrining risiko kehamilan, koordinasi rujukan, pelaporan program (PWS-KIA)

Posyandu: Bidan berperan sebagai Pembina dan supervisor kegiatan berbasis Masyarakat, seperti: membina kader, memnantau tumbuh kembang balita, pelayanan imunisasi dan gizi serta edukasi Masyarakat.

Praktik Mandiri Bidan (PMB): Bidan sebagai penyedia layanan kesehatan langsung secara mandiri di komunitas. Bidan bertanggung jawab dalam pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas, pelayanan KB serta konseling kesehatan reproduksi dan KB.

Kunjungan Keluarga (*Home Care*): Bidan memberikan pelayanan langsung di rumah pasien. Pada posisi ini, Bidan bertanggung jawab terhadap pemantauan ibu hamil risiko tinggi, kunjungan nifas (KF) dan Neonatus (KN), edukasi/Pendidikan kesehatan dan identifikasi factor lingkungan yang mempenagruhi kesehatan keluarga.

Peran professional Bidan dalam pelayanan primer:

a. *Care Provider* (Pemberi Asuhan)

Bidan menjadi kontak pertama masyarakat dalam meberikan asuhan kebidanan komprehensif berdasarkan standar profesi di tingkat Puskesmas, Pustu atau praktik mandiri untuk menjamin kualitas pelayanan klinis dan keselamatan pasien.

Educator (Pendidik Kesehatan)

Bidan bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada individu, keluarga dan Masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong perubahan perilaku sehat.

Counselor (Konselor)

Bidan membantu pasien mengambil Keputusan yang tepat dan mandiri tentang kesehatan dengan memberikan konseling seperti pada Kehamilan risiko, KB dan menyusui.

Advocate (Advokat)

Bidan menjamin hak pasien terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Bidan dapat membela kepentingan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam kondisi yang tidak mendukung.

F. Peran Bidan dalam Pelayanan Kebidanan

Peran bidan dalam pelayanan kebidanan merupakan manifestasi dari kompetensi profesional yang mencakup aspek klinis, edukatif, sosial dan advokatif. Dalam konteks pelayanan primer dan kebidanan komunitas, peran ini menjadi semakin kompleks karena bidan tidak hanya berhadapan dengan ibu sebagai individu, tetapi juga dengan keluarga dan system sosial yang mempengaruhi Keputusan kesehatan.

Secara profesional, bidan tidak hanya menjalankan satu peran saja, tetapi harus mampu menjalankan beberapa peran sekaligus secara terpadu atau multiperan yang harus dijalankan secara simultan dengan terintegrasi. Untuk memenuhi hal tersebut, maka bidan dituntut memiliki kemampuan:

1. *Clinical reasoning* (Penalaran Klinis)

Peran bidan dalam *Clinical reasoning* adalah kemampuan kognitif untuk menganalisis data klinis, mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan bukti ilmiah dan membuat Keputusan asuhan yang tepat, aman dan individual. Peran ini krusial karena Bidan di haruskan berpikir kritis dalam pengambilan Keputusan klinis.

Communication Skill (Keterampilan Komunikasi)

Peran bidan sebagai komunikator merupakan kemampuan terapeutik untuk membangun hubungan saling percaya, menyampaikan informasi medis secara jelas, serta memberikan dukungan emosional kepada klien dan keluarganya. Kemampuan bidan sebagai komunikator harus mampu memberikan informasi secara jelas dan mudah dipahami, empatik dan tidak menghakimi serta efektif kepada pasien, keluarga dan tim kesehatan. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien.

Ethical decision maker (Pengambilan Keputusan Etis)

Peran bidan sebagai *Ethical decision maker* sangat penting, karena bidan berhubungan langsung dengan nyawa ibu dan bayinya, yang merupakan kelompok rentan dalam layanan kesehatan. Bidan wajib menggunakan prinsip

etika dan moralitas untuk memastikan pelayanan yang aman, berkualitas serta menghormati hak-hak pasien. Kemampuan bidan dalam bertindak benar secara profesional dan moral dalam mengambil Keputusan harus sesuai prinsip etika (autonomy, beneficence, dll), mengutamakan keselamatan pasien dan tetap menghargai hak dan pilihan pasien.

Cultural Competence (Kepekaan budaya)

Peran bidan sebagai *Cultural Competence* adalah kemampuan memahami, menghormati dan mengintegrasikan latar belakang budaya pasien ke dalam asuhan kebidanan. Kemampuan bidan dalam memahami dan menyesuaikan pelayanan dengan nilai dan kepercayaan masyarakat, kebiasaan local serta kondisi sosial budaya pasien sangat diperlukan sehingga pelayanan lebih diterima tanpa mengabaikan keselamatan pasien. Peran ini, bidan berperan menjembatani adat istiadat local dengan praktis medis yang aman, mengurangi kesenjangan layanan serta memberikan asuhan yang sensitif dan non-diskriminatif.

G. Prinsip-prinsip Etika Kebidanan di Komunitas

Prinsip-prinsip etika kebidanan di komunitas berfokus pada pelayanan promotive sampai preventif yang menghormati hak asasi manusia, keadilan sosial dan kerahasiaan pasien. Prinsip utama meliputi otonomi, beneficence, non-maleficence, kejujuran dan kesetiaan yang diwujudkan melalui kemitraan dengan Masyarakat.

1. *Autonomy* (otonomi)

Autonomy merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap pasien memiliki hak penuh untuk menentukan Keputusan terkait kesehatannya sendiri setelah mendapatkan informasi yang cukup, jelas dan benar.

Bidan wajib menghormati hak individu untuk membuat Keputusan sendiri mengenai perawatan kesehatannya setelah diberikan informasi yg cukup (*informed consent/informed choice*).

Beneficence

Beneficence adalah prinsip bahwa setiap Tindakan bidan bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi pasien.

Bidan bertindak demi kepentingan terbaik pasien, mengutamakan keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

Non-maleficence

Prinsip *Non-maleficence* adalah prinsip untuk tidak melakukan Tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan pasien. Bidan berkewajiban menghindari tindakan yang membahayakan, baik fisik maupun emosional,

menghindari Tindakan yang tidak perlu atau berisiko, dan setiap Tindakan harus mempertimbangkan risiko atau manfaat dalam praktik kebidanan.

Justice (keadilan)

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bidan memberikan pelayanan secara adil, setara dan tanpa diskriminasi soal, ekonomi, agama atau suku kepada semua pasien. Dalam memberikan pelayanan prioritas diberikan berdasarkan kebutuhan medis, bukan factor lain.

H. *Patient Safety* dalam Kebidanan Komunitas

Patient safety dalam kebidanan komunitas merupakan system pelayanan asuhan kebidanan yang mengutamakan keselamatan ibu dan bayi melalui asesmen risiko, deteksi dini, komunikasi efektif dan pencegahan infeksi untuk mencegah cedera.

Patient safety adalah pendekatan sistematis dalam pelayanan kebidanan untuk mencegah kesalahan (*error*), mengidentifikasi dan mengelola risiko serta mengurangi dampak kejadian yang tidak diharapkan.

Pada pelayanan komunitas, keselamatan pasien sangat di pengaruhi oleh: lingkungan non-klinis(rumah, posyandu), peran keluarga sebagai pengambil Keputusan dan keterbatasan sarana dan akses rujukan, oleh karena itu *Patient safety* di komunitas lebih ditekan pada deteksi dini, komunikasi yang efektif, Keputusan cepat dan rujukan yang tepat.

Prinsip *Patient safety*:

1. Identifikasi risiko: kemampuan bidan mengenali tanda bahaya dan factor risiko sejak awal melalui skrining sistematis.

Komunikasi efektif: menggunakan teknik SBAR (*Situation, Background, Assesment, Recommendation*) saat serah terima pasien atau rujukan ke fasilitas lebih tinggi.

Pencegahan kesalahan tindakan: setiap Tindakan harus berdasarkan SOP, sesuai indikasi dan mempertimbangkan risiko dan manfaat termasuk tidak *under-treatment* dan tidak *over-treatment*.

Dokumentasi akurat: pencatatan lengkap, sistematis dan tepat waktu (SOAP)

Rujukan tepat dan cepat: merujuk pasien ke fasilitas lebih tinggi dengan indikasi jelas, waktu tepat, dan persiapan memadai.

I. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Seorang Perempuan, Ny. M, usia 29 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 35 minggu, dikunjungi oleh bidan desa. Ibu mengeluh sakit kepala sejak 3 hari terakhir, disertai pandangan kabur dan bengkak pada kedua kaki.

Riwayat:

- ANC hanya 2 kali selama kehamilan
- Tidak rutin mengonsumsi tablet Fe
- Tidak memiliki jaminan kesehatan aktif
- Tinggal di daerah terpencil dengan akses transportasi terbatas

Hasil pemeriksaan:

- TD: 150/100 mmHg
- N: 92 x/menit
- RR : 22 x/menit
- Sh: 36,80 C
- Edema (+)
- DJJ; 150 x/menit

Saat diberikan edukasi, keluarga (suami dan ibu mertua) menyatakan:

- Lebih percaya pengobatan tradisional
- Menganggap kondisi ibu "normal"
- Menolak rujukan karena biaya dan jarak

Bidan menghadapi dilemma antara menghormati Keputusan keluarga dan kewajiban profesional untuk menyelamatkan ibu dan janin

Pertanyaan (Diskusi kelompok)

1. Jelaskan konsep kebidanan komunitas dan identifikasi unsur-unsur pendekatan komunitas yang terdapat dalam kasus di atas.

Analisis ruang lingkup kebidanan komunitas yang muncul dalam kasus ini. Jelaskan minimal 3 aspek yang relevan.

Jelaskan bagaimana prinsip pelayanan primer (akses, promotif, preventif, partisipatif) diterapkan atau yang belum optimal dalam kasus tersebut

Bidan sebagai ujung tombak pelayanan. Analisis posisi bidan dalam pelayanan primer pada kasus ini.

Jelaskan peran bidan dan contoh nyata yang muncul dalam kasus ini, meliputi:

a. Care provider

Edukator

Counselor

Advocate

Identifikasi masalah kebidanan utama dan risiko yang mungkin terjadi pada ibu dan janin.

Analisis kasus menggunakan konsep “3 terlambat” dalam patient safety

Jelaskan Langkah-langkah yang harus dilakukan bidan untuk mencegah terjadinya komplikasi (berbasis patient safety).

Identifikasi dilemma etik yang dihadapi bidan dalam kasus ini

Jelaskan keputusan terbaik yang harus diambil bidan dan berikan alasannya.

J. Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kunjungan Rumah : Ibu Hamil Risiko Tinggi
3	Kasus	Ibu hamil 34 minggu dengan tanda risiko preeklampsia dalam konteks komunitas
4	Tujuan	Untuk menilai kemampuan peserta dalam memberikan asuhan kebidanan komunitas berbasis patient safety dan etika profesi
5	Kompetensi	1. Anamnesis komunitas 2. Pemeriksaan fisik sederhana 3. Identifikasi risiko 4. Diagnosa 5. KIE/edukasi 6. Konseling 7. Advokasi dan rujukan 8. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang ibu hamil, Ny. S, usia 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 34 minggu, dikunjungi bidan di rumah. Keluhan: sakit kepala sejak 2 hari, pandangan kabur, kaki bengkak. ANC tidak rutin (2 kali). Konsumsi Fe tidak teratur. Keluarga lebih percaya pengobatan tradisional. Pemeriksaan: TD 150/100 mmHg N; 88 x/menit, RR: 22 X/menit, edema (+), DJJ 150 X/menit. Keluarga ragu rujuk karena biaya dan jarak. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan sederhana sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan KIE. 5. Berikan konseling berbasis etika 6. Rencana rujuk
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Penilaian menggunakan checklist dan global rating (1-4). Tidak boleh intervensi ke peserta INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta pemeriksaan: • TD: 150/100 mmHg • Edema (+) • DJJ: 15X/menit Diagnosis : Suspek preeklampsia Tindakan yang diharapkan:

No.	Komponen	Isi
		• Deteksi risiko • Edukasi tanda bahaya • Komunikasi efektif • Konseling keluarga • Advokasi rujukan • Perencanaan transportasi
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai hamil 2. PS tampak cemas, lelah, mengeluh sakit kepala dan bengkak. Ragu di rujuk karena biaya. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 4. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak ragu tetapi dapat diyakinkan dan bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya sakit kepala dan kaki bengkak Peserta: Sejak kapan sakitnya? PS: Kira-kira sudah 2 hari, Bu. Peserta: Apakah ANC nya teratur? PS: baru 2 kali Bu. Peserta: Apakah ada minum obat tablet tambah darah? PS: iya Bu, yapi tidak teratur. Peserta: kasus ini perlu di rujuk, untuk pemeriksaan lebih lengkap, apakah Ibu bersedia di rujuk? PS: Keluarga keberatan Bu. Peserta: Alasannya? PS: kami percaya keluhan ini normal pada ibu hamil dan kami ada pengobatan yang dapat mengobati kepala sakit dan kaki bengkak pada ibu hamil dan juga takut biaya nya mahal Bu Peserta: Ibu, kehamilan ibu ini berisiko dan sangat bahaya bagi keselamatan ibu dan bayi, perlu segera ditolong di rumah sakit. Untuk biaya, saya akan berkoordinasi dengan RT dan Bapak Lurah terkait biaya jaminan kesehatan sehingga dapat dibantu. PS: Baik, Bu, tolong bantu saya dan bayi saya ya. Peserta: Saya akan menyiapkan rujukan. PS: Iya, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.

No.	Komponen	Isi
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Tensimeter — 1 4 Steteskop.— 1 5. Doppler – 1 6. Pita Lila – 1 7. Pita Cm - 1 8. Handrub – 1 9. Sarung tangan – 1 pasang 10. Formulir rujukan — 1 lembar 11. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 12. Pena — 1
13	Penulis	
14	Referensi	1. World Health Organization (2018). <i>WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience</i> . Geneva: WHO. 2. World Health Organization (2024). <i>Transitioning to midwifery models of care: Global position paper</i> . Geneva: WHO. 3. International Confederation of Midwives (ICM) (2021). <i>Essential Competencies for Midwifery Practice</i> .

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Kebidanan komunitas

KOMPETENSI 1. Pengkajian (Anamnesis dan Pemeriksaan)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama (sakit kepala, penglihatan kabur dan kaki bengkak)		
2. Riwayat kehamilan (ANC, Fe dan factor risiko lainnya)		
3. Pengkajian factor sosial dan budaya (akses, biaya, budaya)		
4. Pemeriksaan tekanan darah		
5. Permeriksaan edema (Lokasi dan derajat)		
6. Pemeriksaan DJJ		
7. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 7 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–6 dari 7 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 7 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Diagnosis dan Analisis Risiko

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menentukan diagnosis (Suspek preeklampsia)		
2. Identifikasi masalah tambahan		
3. Identifikasi risiko ibu dan janin (kejang dan komplikasi)		
4. Penentuan prioritas masalah (Gawat janin, premature).		
5. menentukan prioritas masalah (risiko tinggi)		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 5 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 3-4 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1-2 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. Perencanaan dan implementasi Asuhan

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan kondisi ibu dengan Bahasa sederhana.		
3. Memberikan edukasi tanda bahaya secara jelas		
4. Melakukan konseling kepada ibu dan keluarga		
5. Menyarankan rujukan secara tegas dan rasional		
6. Mengusulkan Solusi hambatan (Biaya/transportasi)		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3 = Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2 = Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1 = Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Etika Profesi dan Patient Safety

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menghargai pendapat/Keputusan keluarga tanpa menghakimi		
2. Menjelaskan risiko jika tidak dirujuk (patient safety)		
3. Mengupayakan pencegahan delay (edukasi dan advokasi)		
4. Melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan		
5. Menunjukkan sikap empati dan profesional		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 4

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

K. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1.1

Portofolio pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ny. S (preeklampsia di Komunitas)
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada kasus Ny. S, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian ibu hamil risiko tinggi, mengenali tanda bahaya preeklampsia, melakukan edukasi dan konseling keluarga, serta mengambil Keputusan rujukan secara bertahap dan semakin baik
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu hamil dengan risiko tinggi, tetapi juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam komunikasi keluarga, clinical reasoning, dan keputusan rujukan setelah mendapat umpan balik.
OSCE	OSCE dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium yang mengukur kemampuan mahasiswa dalam skenario klinik komunitas secara objektif dan standar	OSCE memuat kemampuan mahasiswa dalam melakukan anamnesis terarah, pemeriksaan TD, identifikasi preeklampsia, edukasi tanda bahaya, serta komunikasi rujukan pada kasus NY. S.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ny. S (preeklampsia di Komunitas)
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Ny. S: G2P1A0, UK 34 minggu, TD 150/100 mmHg, edema (+), keluhan sakit kepala dan pandangan kabur, diagnosis suspek preeklampsia, tindakan edukasi, konseling dan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi keterlambatan, dan merencanakan pencegahan	Mahasiswa merefleksikan pentingnya deteksi dini preeklampsia, risiko keterlambatan Keputusan keluarga (terlambat 1), hambatan transportasi (terlambat 2), serta pentingnya komunikasi efektif untuk mencegah komplikasi ibu dan janin.
Feedback dosen/CI	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	Dosen menilai mahasiswa sudah baik dalam mengidentifikasi tanda bahaya dan menjelaskan kondisi, namun perlu meningkatkan pendekatan budaya dan strategi komunikasi untuk meyakinkan keluarga agar menerima rujukan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman belajar (OSCE, diskusi kasus, refleksi) yang menunjukkan konsistensi dalam mengenali risiko kehamilan dan mengambil asuhan komunitas.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian, mengenali risiko preeklampsia dan merencanakan rujukan pada berbagai scenario komunitas.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang	Pada kasus Ny. S, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep kebidanan komunitas tetapi juga mampu menerapkannya dalam

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ny. S (preeklampsia di Komunitas)
	berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	pelayanan primer secara aman, etis dan berbasis patient safety. .

Tabel 1.2
Case Report pada Kasus Ny. S (Preeklampsia di Komunitas)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ny. S (Preeklampsia di Komunitas)
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan tentang seorang ibu hamil G2P1A0 UK 34 minggu dengan keluhan sakit kepala, pandangan kabur, edema dengan hasil pemeriksaan TD tinggi yang mengarah pada suspek preeklampsia di komunitas.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan secara komprehensif.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan risiko preeklampsia, hambatan sosial (penolakan keluarga terhadap rujukan), Tindakan edukasi dan konseling, serta Keputusan rujukan dan tindak lanjut.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan: Ny. S, 27 tahun, G2P1A0, UK 34 minggu, TD 150/100 mmHg, edema (+), keluhan sakit kepala dan pandangan kabur, ANC tidak rutin, diagnosis suspek preeklampsia, tindakan edukasi tanda bahaya, konseling keluarga, dan rujukan ke fasilitas kesehatan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, ketajaman analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan Tindakan, dan kemampuan mengevaluasi hasil dan mendokumentasikan asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengaitkan tekanan darah tinggi, edema, dan gejala subjektif sebagai tanda bahaya kehamilan, serta mengambil keputusan rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ny. S (Preeklampsia di Komunitas)
		secara tepat dalam konteks keterbatasan akses dan penolakan keluarga.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik kebidanan komunitas.	Dari kasus ini, mahasiswa belajar pentingnya deteksi dini preeklampsia, komunikasi efektif dengan keluarga, serta pencegahan keterlambatan rujukan (delay 1 dan 2) dalam upaya menjaga keselamatan ibu dan janin.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab dan berorientasi pada keselamatan pasien.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep kebidanan komunitas dan preeklampsia, tetapi juga mampu Menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara komprehensif, termasuk aspek klinis, sosial, etika dan patient safety.

Tabel 1.3
Refleksi Patient Safety pada Ny. S (Preeklampsia di Komunitas)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ny. S (Preeklampsia di Komunitas)
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan dalam asuhan kebidanan	Pada kasus Ny. S, mahasiswa merefleksi bahwa keterlambatan mengenali tanda bahaya preeklampsia (TD tinggi, sakit kepala, pandangan kabur, edema) dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kejang (eklamsi) dan membahayakan ibu serta janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa keterlambatan edukasi, komunikasi yang tidak efektif atau penundaan rujukan dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu hamil dengan preeklampsia.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ny. S (Preeklampsia di Komunitas)
	pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman praktik	risiko preeklampsia berat, keterlambatan pengambilan Keputusan oleh keluarga, serta hambatan akses menuju fasilitas kesehatan.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain perkembangan menjadi eclampsia, perdarahan, gawat janin, keterlambatan Keputusan keluarga, keterlambatan transportasi serta kurangnya pemantauan kehamilan karena ANC tidak teratur.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan TD, edukasi tanda bahaya kehamilan, konseling keluarga, pendekatan budaya, advokasi rujukan, serta koordinasi transportasi untuk mencegah keterlambatan penanganan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa komunikasi efektif, kemampuan meyakinkan keluarga dan pengambilan Keputusan cepat dalam mencegah komplikasi preeklampsia di komunitas.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan Tindakan kebidanan, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko, mengevaluasi potensi kesalahan dan meningkatkan kualitas asuhan secara berkelanjutan dalam konteks komunitas.

L. Ringkasan Materi

Preeklampsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah setelah usia kehamilan 20 minggu, yang dapat disertai gejala seperti sakit kepala, gangguan penglihatan dan edema. Dalam praktik kebidanan komunitas, deteksi dini preeklampsia menjadi sangat penting karena kondisi ini dapat berkembang cepat menjadi eklamps yang mengancam jiwa ibu dan janin. Penilaian tidak hanya berfokus pada angka tekanan darah, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan keluhan subjektif, temuan objektif serta factor risiko individu dan lingkungan.

Pada Kasus Ny. S, ibu hamil, usia kehamilan 34 minggu dengan tekanan darah 150/100 mmHg, disertai keluhan sakit kepala, penglihatan kabur dan edema pada kaki, menunjukkan tanda bahaya kehamilan yang mengarah kearah suspek preeklampsia. Kondisi ini diperberat oleh factor risiko berupa kunjungan ANC yang tidak rutin/teratur, kepatuhan konsumsi tablet Fe yang rendah, serta adanya hambatan sosial seperti kepercayaan keluarga terhadap pengobatan tradisional dan keterbatasan akses biaya dan transportasi ke fasilitas kesehatan. Dalam konteks kebidanan komunitas, kondisi ini mencerminkan pentingnya pendekatan holistic yang meliputi aspek biopsiko-sosial dan kultural.

Prinsip pelayanan primer menekankan bahwa asuhan harus bersifat promotive, preventif dan berpusat pada keluarga. Bidan sebagai ujung tombak pelayanan memiliki peran penting sebagai care provider, educator, counsellor dan advocate. Pada kasus ini, bidan tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik seperti pengukuran tekanan darah, penilaian edema dan pemantauan DJJ, tetapi juga memberikan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan, melakukan konseling kepada ibu dan keluarga serta mengadvokasi pentingnya rujukan. Kemampuan komunikasi efektif dan pendekatan budaya menjadi kunci dalam mengatasi penolakan keluarga terhadap rujukan.

Dari perspektif patient safety, kasus ini menunjukkan potensi terjadinya keterlambatan dalam penanganan, terutama terlambat dalam pengambilan Keputusan oleh keluarga dan keterlambatan akses ke fasilitas kesehatan, oleh karena itu Tindakan bidan harus berfokus pada deteksi dini, edukasi risiko, komunikasi yang jelas dan persuasif serta upaya konkret untuk memfasilitasi rujukan. Keputusan rujukan harus dilakukan secara tepat waktu untuk mencegah komplikasi seperti eklampsia, perdarahan dan gangguan kesejahteraan janin.

M. Alur asuhan singkat

Ibu inpartu dengan keluhan sakit kepala, penglihatan kabur, edema → lakukan pengkajian komprehensif (anastesis, TD, DJJ) → identifikasi suspek preeklampsia → nilai factor risiko dan hambatan sosial → berikan edukasi tanda bahaya → lakukan konseling keluarga → advokasi dan siapkan rujukan → dokumentasi dan tindak lanjut.

Tabel 1.4
Red Flags & Eskalasi

Kasus Kebidanan Komunitas : Suspek Preeklampsia pada Ny. S

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
TD 150/100 mmHg	Hipertensi dalam kehamilan, mengarah pada preeklampsia	Lakukan confirm ulang, pantau tanda vital, edukasi tanda bahaya dan siapkan rujukan
Sakit kepala persisten	Gejala neurologis awal preeklampsia	Jangan tunda, segera lakukan eskalasi dan rujukan
Edema kaki	Retensi cairan yang berkaitan dengan preeklampsia	Evaluasi Bersama tanda lain, tingkatkan kewaspadaan dan rencanakan rujukan
ANC tidak rutin	Risiko keterlambatan deteksi komplikasi	Lakukan edukasi intensif, tingkatkan pemantauan dan rencanakan rujukan
Kepatuhan konsumsi Fe rendah	Risiko anemia yang dapat memperburuk kondisi ibu	Edukasi ulang pentingnya suplementasi, evaluasi status ibu
Keluarga menolak rujukan	Risiko terlambat mengambil Keputusan	Lakukan konseling persuasive, pendekatan budaya dan libatkan tokoh keluarga/masyarakat
Hambatan akses (Biaya dan jarak)	Risiko keterlambatan mencapai pelayanan kesehatan	Fasilitasi rencana transportasi, koordinasi dengan fasilitas rujukan.
Potensi perkembangan menjadi eclampsia	Kegawatdaruratan maternal yang mengancam jiwa	Siapkan rujukan segera, pantau ketat dan lakukan stabilisasi awal sesuai kewenangan bidan
Tidak ada tindak lanjut setelah identifikasi risiko	Risiko kegagalan system pelayanan	Pastikan dokumentasi, rencana tindak lanjut dan komunikasi dengan jejaring layanan kesehatan.

N. Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Kebidanan Komunitas – Peran Bidan, etika profesi dan pasien safety pada kasus Preeklampsia pada komunitas

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep kebidanan komunitas dan pelayanan primer	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan peran bidan sebagai care provider, educator, counsellor dan advocate	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu hamil di komunitas	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda bahaya kehamilan (Sakit kepala, penglihatan kabur, edema dan hipertensi)	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah dan interpretasikan secara tepat	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menilai kondisi ibu dan janin secara sederhana di komunitas	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menganalisis data untuk mengidentifikasi preeklampsia	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengidentifikasi factor risiko (ANC tidak teratur, kepatuhan rendah, factor sosial)	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi tanda bahaya kehamilan kepada ibu	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melakukan konseling pada keluarga dengan komunikasi dengan efektif dan empatik	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa melakukan pendekatan budaya dalam menghadapi kepercayaan keluarga	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa mengidentifikasi risiko pasien safety	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menentukan kebutuhan rujukan pada kasus risiko tinggi	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melakukan advokasi kepada keluarga untuk mendukung rujukan	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menyiapkan rencana rujukan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil pengkajian Tindakan secara sistematis	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
17	Saya sudah bisa menerapkan prinsip etika			
18	Saya sudah bisa menjaga keselamatan ibu dan janin melalui deteksi dini dan Tindakan yang tepat.			

Refleksi singkat mahasiswa:

O. Referensi

- Adnani, Q.E.S. et al. (2025). Midwifery continuity of care in low- and middle-income countries: A scoping review. *BMC Health Services Research*, 25, p. 463.
- Cummins, A. et al. (2024). Midwifery continuity of care for women with perinatal mental health conditions: A systematic review. *Birth*, 51(4), pp. 728–737.
- Fahy, K., Foureur, M. & Hastie, C. (2019). *Birth Territory and Midwifery Guardianship: Theory for Practice, Education and Research*. Oxford: Elsevier.
- Fraser, D.M. & Cooper, M.A. (2020). *Myles Textbook for Midwives*. 17th ed. London: Elsevier.
- International Confederation of Midwives (ICM) (2021). *Essential Competencies for Midwifery Practice*. The Hague: ICM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Koblinsky, M. et al. (2020). Quality maternity care for every woman, everywhere: A call to action. *The Lancet Global Health*, 8(7), pp. e872–e873.
- Pairman, S., Tracy, S., Thorogood, C. & Pincombe, J. (2019). *Midwifery: Preparation for Practice*. 4th ed. Sydney: Elsevier.
- Renfrew, M.J. et al. (2019). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), pp. 1129–1145.
- Varney, H., Kriebs, J.M. & Gegor, C.L. (2018). *Varney's Midwifery*. 6th ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- World Health Organization (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. Geneva: WHO.

World Health Organization (2023). *Essential Childbirth Care: Facilitator's Guide*. Geneva: WHO.

World Health Organization (2024). *Transitioning to midwifery models of care: Global position paper*. Geneva: WHO.

BAB 2.

PEMETAAN MASALAH KIA DI WILAYAH KERJA: DATA, SURVEILANS, DAN PENETAPAN PRIORITAS

Capaian Pembelajaran

CPL-1	Menguasai konsep, kebijakan, dan prinsip pelayanan kebidanan komunitas serta pelayanan KIA primer berbasis bukti.
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian kebutuhan dan masalah KIA pada keluarga/komunitas menggunakan data, surveilans, dan analisis prioritas.
CPL-6	Menunjukkan profesionalisme, etika, keselamatan, serta kemampuan monitoring-evaluasi dan perbaikan mutu program KIA.

CPMK

CPMK-3	Menganalisis data KIA dan surveilans untuk pemetaan masalah, penetapan prioritas, serta perencanaan intervensi berbasis bukti.
CPMK-4	Merancang dan mengelola penyelenggaraan layanan KIA berbasis komunitas (Posyandu/UKBM dan layanan terpadu) termasuk pembinaan kader dan jejaring rujukan.
CPMK-7	Menyusun strategi pencegahan–penanggulangan masalah KIA prioritas, kesiapsiagaan rujukan, kolaborasi lintas sektor, serta monitoring-evaluasi program.

Sub CPMK

Sub-CPMK-1	Mengolah data KIA (indikator, register, surveilans) untuk menggambarkan situasi wilayah kerja
Sub-CPMK-2	Menetapkan prioritas masalah dengan kriteria terukur serta menyusun rencana tindak lanjut.
Sub-CPMK-3	Menyusun program penyelesaian masalah sesuai dengan prioritas dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor

A. Pemetaan Masalah KIA diwilayah Kerja: Data, Suveilnas, dan Penetapan Prioritas

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan indikator utama derajat kesehatan masyarakat yang mencerminkan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Permasalahan KIA tidak hanya berkaitan dengan faktor medis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan KIA memerlukan pendekatan berbasis wilayah melalui pemetaan masalah yang sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada prioritas.

Pemetaan masalah KIA adalah proses identifikasi, analisis, dan visualisasi permasalahan kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah kerja tertentu dengan memanfaatkan data yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk mengetahui distribusi masalah, kelompok risiko tinggi, serta faktor determinan yang memengaruhi terjadinya masalah tersebut. Dengan pemetaan yang baik, tenaga kesehatan terutama bidan komunitas dapat merencanakan intervensi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Pembuatan pemetaan kesehatan ibu dan anak sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkala agar pemantauan dapat dilakukan secara berkelanjutan oleh berbagai pihak yang terkait, seperti bidan desa, puskesmas, dinas kesehatan, maupun perangkat desa sendiri. Contoh pemetaan hasil pemetaan masalah kesehatan ibu memuat data dan sebaran ibu hamil, ibu nifas, menyusui, pasangan usia subur, pasangan pernikahan dini serta pengguna kontrasepsi. Sedangkan contoh data pemetaan Kesehatan anak Adalah sebaran bayi dan balita dengan kondisi Kesehatan normal dan dengan resiko(1).

Sumber data dalam pemetaan KIA dapat berasal dari berbagai sistem informasi kesehatan, seperti pencatatan dan pelaporan rutin (misalnya kohort ibu dan bayi), register pelayanan di fasilitas kesehatan, laporan program, survei kesehatan, serta data dari sistem surveilans. Data lapangan yang dikumpulkan melalui survey, wawancara dan observasi memungkinkan identifikasi masalah Kesehatan menjadi lebih akurat(2). Selain itu, data sekunder dari instansi lain seperti kependudukan, pendidikan, dan sosial ekonomi juga penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Kualitas data menjadi aspek krusial, sehingga data harus memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, ketepatan waktu, dan kelengkapan.

Surveilans kesehatan merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan diseminasi data kesehatan secara terus-menerus dan sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan

pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien(3). Dalam konteks KIA, surveilans berfungsi untuk memantau tren indikator seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, cakupan pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, serta kejadian komplikasi. Surveilans juga memungkinkan deteksi dini terhadap masalah atau kejadian luar biasa yang memerlukan respons cepat di tingkat pelayanan kesehatan.

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, langkah berikutnya adalah penetapan prioritas masalah. Tidak semua masalah dapat ditangani secara bersamaan karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan metode penentuan prioritas menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Dapat juga didukung dengan

Dengan demikian, pemetaan masalah KIA berbasis data dan surveilans merupakan fondasi penting dalam manajemen program kesehatan ibu dan anak di tingkat wilayah kerja. Proses ini mendukung perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*), meningkatkan ketepatan intervensi, serta berkontribusi pada penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak secara berkelanjutan.

B. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang bidan koordinator di sebuah puskesmas wilayah kerja pedesaan bertanggung jawab terhadap 5 desa dengan jumlah ibu hamil terdaftar sebanyak 320 orang dalam satu tahun terakhir. Berdasarkan laporan rutin dan hasil surveilans KIA, diperoleh data sebagai berikut:

1. Cakupan kunjungan antenatal minimal 4 kali (K4) sebesar 68% (target nasional $\geq 90\%$)

Persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 85%

Terdapat 6 kasus kematian bayi dalam 1 tahun terakhir, dengan penyebab terbanyak adalah BBLR dan asfiksia

Terdapat 2 kasus kematian ibu, masing-masing disebabkan oleh perdarahan postpartum dan preeklamsia

Cakupan kunjungan nifas lengkap hanya 60%

Ditemukan 25 ibu hamil dengan anemia, namun hanya 15 yang rutin mengonsumsi tablet Fe

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus risiko tinggi dan kematian terjadi di 2 desa terpencil dengan akses transportasi terbatas

Data surveilans menunjukkan keterlambatan rujukan pada sebagian kasus komplikasi

Bidan tersebut diminta untuk melakukan analisis situasi dan menyusun prioritas masalah KIA di wilayah kerjanya sebagai dasar perencanaan program tahun berikutnya.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa saja masalah utama KIA yang dapat diidentifikasi dari data di atas?

Data mana yang paling menunjukkan adanya kesenjangan pelayanan kesehatan ibu dan anak?

Bagaimana peran surveilans dalam mengidentifikasi masalah pada kasus ini?

Faktor determinan apa saja yang kemungkinan berkontribusi terhadap masalah KIA di wilayah tersebut?

Dari berbagai masalah yang ada, masalah mana yang harus diprioritaskan? Jelaskan alasan Anda dengan mempertimbangkan besarnya masalah, keparahan, dan kemungkinan intervensi.

Metode apa yang dapat digunakan untuk menetapkan prioritas masalah dalam kasus ini?

Intervensi awal apa yang dapat direncanakan berdasarkan hasil pemetaan masalah tersebut?

Bagaimana bidan dapat meningkatkan kualitas data dan pemanfaatan data dalam perencanaan program KIA di wilayah kerjanya?

C. Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Station	2
2	Judul	Persalinan: Gadar
3	Kasus	Distosia bahu
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam anamnesis , pendokumentasian , dan perilaku profesional .
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis

No.	Komponen	Isi
		5. KIE/konseling 6. Pendokumentasian 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 34 tahun, G4P3A0, hamil 39 minggu, datang ke TPMB diantar keluarga dan dukun beranak dengan keluhan mulas kuat sejak 10 jam yang lalu. Hasil anamnesis: kepala nampak di vulva, telah dipimpin mengejan di rumah 1 jam lalu, ANC 2 kali di bidan desa. Hasil pemeriksaan: kepala tersangkut di vulva, TD 120/80 mmHg, N 99 x/menit, P 24 x/menit, S 37,8°C, his 4 kali/10 menit/50 detik, DJJ tidak terdengar. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan yang tepat pada kasus tersebut.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen/Leopold, penguji memberikan data:- TFU 35 cm

No.	Komponen	Isi
		4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai ulang kondisi ibu dan janin secara cepat- Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas- Memposisikan ibu miring kiri- Menyiapkan/memasang infus cairan sesuai kewenangan dan fasilitas- Menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih- Melakukan pemantauan DJJ dan tanda vital- Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera- Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapiakan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 5. PS berperan sebagai ibu inpartu kala II. 6. PS tampak cemas, lelah, sesekali meringis saat kontraksi, memegang perut bawah, dan berbicara terputus saat nyeri datang. 7. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 8. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi, Bu. PS: Pagi, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah Ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya mulas kuat dari tadi malam, Bu, tapi belum lahir juga. Peserta: Sejak kapan mulas teratur? PS: Kira-kira sudah 10 jam, Bu. Peserta: Apakah Ibu masih merasa ingin mengejan? PS: Iya, Bu.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Sudah berapa lama Ibu menginap di rumah? PS : Sudah 1 jam, Bu. Peserta : Kapan Ibu terakhir BAK? PS: 2 jam yang lalu, bu. Peserta : Bagaimana gerakan bayi? PS: Sejak tadi tidak terasa, Bu. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS: Ini kehamilan keempat saya, Bu. Peserta: Ada riwayat darah tinggi, jantung, asma, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Ibu, maaf sebelumnya, bayi Ibu sudah tidak terselamatkan. Sudah tidak ada denyut jantung bayi. Saya akan melakukan tindakan untuk mengeluarkan janin dari ibu. PS: Saya menyesal tidak bersalin di bidan, Bu. Tolong bantu saya, Bu. Peserta: Sabar ya, Bu, kita keluarkan bayinya. PS: Iya, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan dalam - Lembar partograf kasus
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Lembar partograf kasus — 1 set 5. Partus set — 1 6. Heacting set — 1 7. APD (penutup kepala, masker, kaca mata google, gown, Sepatu boot) 8. Sduit 3 — 2 9. Sduit 5 cc — 1 10. hanscone steril — 1

No.	Komponen	Isi
		11. Kassa steril pada kom kecil 12. Korentang — 1 13. Oksitosin 14. Methergin 15. lidocain 16. perlak pengalas 17. Air DTT dalam kom kecil 18. Bengkok 19. Larutan Klorin 20. kain bersih untuk perinium 21. handuk 22. Perlengkapan baju ganti ibu dan bayi serta pembalut 23. washlap 24. Tempat sampah 18. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 19. Pena — 1
13	Penulis	Bdn. Humaediah Lestari, SST.,M.Kes
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2008). Education material for teachers of midwifery: Midwifery education modules (2nd ed.): Managing prolonged and obstructed labour. 4. World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience.

Rubrik Penilaian Dan Kelulusan

Stase 1: Persalinan Gawatdarurat

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat persalinan sekarang (sejak kapan mulas, berapa lama mendedan)		
3. Riwayat pengeluaran pervaginam (lendir darah, air ketuban, perdarahan)		
4. Gerak janin		
5. Rasa ingin meneran		
6. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
7. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
8. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3**= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- **2**= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- **1**= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- **0**= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Menggunakan APD		
f. Mencuci tangan/hand hygiene		
g. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Memakai sarung tangan		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
b. Memposisikan ibu dengan mengangkat dan menarik kedua paha ibu sampai menempel ke dada ibu		
c. Menganjurkan ibu untuk mengejan pada saat ada his, sambil kedua paha ke arah dada		
d. Melahirkan bahu anterior dengan menarik kepala ke bawah dengan posisi tangan biparietal		
e. Melahirkan bahu posterior dengan menarik kepala ke atas dengan posisi tangan biparietal		
f. Melahirkan badan bayi seluruhnya secara sangga susur		
3. Pasca tindakan		
a. Membereskan alat dan merendamnya dalam larutan clorine 0,5%		
b. Mencuci tangan dalam larutan clorin 0,5% dan melepas sarung tangan dalam keadaan terbalik		
c. Melepas APD		
d. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		
e. Memberitahukan hasil tindakan kepada ibu dan suami/ keluarga		
f. Mendokumentasikan hasil tindakan dengan baik		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–19 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total score

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total score}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Distosia bahu
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu inpartu dan melakukan pertolongan persalinan dengan manuver yang sesuai
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan pertolongan pada kasus distosia bahu, dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan janin serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan intrapartum yang evidence-based, woman-centred, dan pemantauan kemajuan persalinan yang baik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang distosia, tetapi juga dari kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, membaca data kemajuan persalinan, serta melakukan KIE.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan distosia, identifikasi tanda bahaya, penggunaan partograf, dan penanganan persalinan distosia. WHO menempatkan penggunaan partograf serta identifikasi tanda obstruksi sebagai bagian penting dalam pengelolaan persalinan lama dan obstruktif.	Seorang perempuan, usia 34 tahun, G4P3A0, hamil 39 minggu, datang ke TPMB diantar keluarga dan dukun beranak dengan keluhan mulas kuat sejak 10 jam yang lalu. Hasil anamnesis: kepala nampak di vulva, telah dipimpin mengejan di rumah 1 jam lalu, ANC 2 kali di bidan desa. Hasil pemeriksaan: kepala tersangkut di vulva, TD 120/80 mmHg, N 99 x/menit, P 24 x/menit, S 37,8°C, his 4 kali/10 menit/50 detik, DJJ tidak terdengar.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, DJJ, his,	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, menyimpulkan adanya partus lama/distosia dengan kecurigaan IUFD, lalu menolong persalinan dengan manuver Mc. Robert.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Distosia bahu
	kemajuan persalinan, serta menolong persalinan dengan manuver yang sesuai. WHO juga mencantumkan keterampilan seperti menilai mengenali obstructed labour, serta pencatatan sebagai keterampilan penting.	
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali tanda partus lama/distosia dan ketepatan keputusan eskalasi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan turtle sign, his adekuat, kelelahan ibu, dan DJJ tidak terdengar sebagai tanda bahwa persalinan tidak lagi aman dan bayi harus segera dilahirkan.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan. Pada persalinan lama atau obstruktif, WHO menekankan identifikasi tanda, penggunaan partograf, dan langkah penanganan yang efektif.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan membaca partograf, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, ketelitian dalam menilai kondisi ibu dan janin, atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Distosia bahu
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus partus lama dan distosia, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan tindakan kegawatdaruratan persalinan secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 2.1
Portofolio pada Kegawatdaruratan Persalinan: Distosia Bahu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Distosia bahu
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik partus dengan distosia bahu, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian persalinan, menilai kemajuan persalinan secara profesional, mengenali tanda bahaya ibu dan janin, melakukan tindakan pertolongan persalinan, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu bersalin dengan persalinan dengan distosia, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Distosia bahu
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi profesional, pengenalan distosia, dan tindakan penanganan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu bersalin dan tindakan pertolongan persalinan pada kasus partus lama di ruang bersalin.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Ibu G4P3A0, hamil 39 minggu, dengan kepala nampak di vulva, telah dipimpin mengejan di rumah 1 jam lalu, his 4 kali/10 menit/50 detik, DJJ tidak terdengar, serta tindakan pertolongan yang dilakukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan persalinan tidak maju, pemantauan DJJ, pertolongan persalinan dengan manuver yang sesuai serta komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus distosia.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali distosia bahu dan penatalaksanaan, tetapi masih perlu meningkatkan keterampilan dalam memberikan KIE kepada pasien
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus distosia, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai kemajuan persalinan, mengenali distosia, dan melakukan tindakan secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan yang tepat pada persalinan bermasalah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian	Pada topik partus lama dan distosia, portofolio menunjukkan bahwa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Distosia bahu
	pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel 2.2
Case Report pada Kegawatdaruratan Persalinan: Distosia Bahu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Distosia bahu
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu bersalin multiigravida dengan persalinan fase aktif di mana kepala tersangkut di vulva dan tidak bisa melakukan putaran paksi luar, dan DJJ tidak terdengar.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan pertolongan yang diberikan, dan perkembangan kondisi ibu serta janin setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan mulas lama, kepala tersangkut di vulva dan tidak bisa melakukan putaran paksi luar, his adekuat, DJJ tidak terdengar, analisis distosia bahu dengan kecurigaan IUFD, tindakan pertolongan persalinan dengan manuver MC. Robert.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan persalinan mulas lama, kepala tersangkut di vulva dan tidak bisa melakukan putaran paksi luar, his adekuat, DJJ tidak terdengar, analisis distosia bahu dengan kecurigaan IUFD sebagai kondisi yang memerlukan tindakan pertolongan segera.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Distosia bahu
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus partus lama, mahasiswa belajar bahwa pemantauan ibu-janin, dan keputusan eskalasi dini merupakan inti keselamatan dalam asuhan persalinan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep partus lama dan distosia, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 2.3

Refleksi Patient Safety pada Kegawatdaruratan Persalinan: Distosia Bahu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Distosia Bhu
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus distosia bahu, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan dalam memberikan pertolongan dapat menyebabkan perburukan kondisi ibu.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti tidak memantau DJJ dengan cermat, atau salah dalam melakukan manuver dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah rupture uteri, laserasi jalan lahir yang parah, HPP, serta cedera muskuloskeletal apabila terjadi keterlambatan penanganan persalinan dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis partus lama, distosia, pemantauan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Distosia Bhu
		DJJ, pertolongan persalinan dengan manuver yang sesuai.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pemantauan tanda vital dan DJJ, penilaian 3P, pertolongan segera, komunikasi cepat kepada keluarga, dan rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada persalinan lama, pengkajian serial, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

D. Ringkasan Materi

Persalinan kala I fase aktif dimulai pada pembukaan serviks 5 cm sampai pembukaan lengkap. Dalam praktik mutakhir, kemajuan persalinan tidak boleh dinilai hanya dengan patokan "1 cm/jam", karena laju pembukaan yang lebih lambat dari itu tidak boleh menjadi satu-satunya alasan intervensi. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dengan melihat kondisi ibu, kondisi janin, kekuatan his, perubahan pembukaan serviks, dan penurunan bagian terendah janin pada pemantauan serial.

Partus lama adalah kemajuan persalinan yang tidak memuaskan atau lebih lambat dari yang diharapkan, sedangkan distosia bahu adalah persalinan sulit yang dapat disebabkan oleh ukuran janin yang besar atau panggul sempit. Pada praktik klinik, bidan harus peka terhadap kombinasi tanda seperti pembukaan yang menetap, kepala janin tidak turun, his adekuat tetapi persalinan tidak maju, ibu semakin lelah, dan DJJ tidak normal, kepala tidak melakukan putaran paksi luar. WHO menekankan pentingnya penggunaan partograf, penilaian presentasi dan posisi janin, penilaian penurunan kepala, kepala tidak melakukan putaran paksi luar, pengenalan obstructed labour, pengenalan distosia bahu, dan pencatatan yang baik.

Tindakan bidan pada partus lama atau distosia bahu berfokus pada penilaian cepat ibu dan janin, serta pertolongan segera. Langkah penting mencakup menilai tanda vital ibu, menilai DJJ, menilai his, menilai ketuban dan perdarahan, membaca partograf, memposisikan ibu nyaman dan aman, mengupayakan pengosongan kandung kemih, menyiapkan terapi cairan sesuai kondisi dan kewenangan, memberikan dukungan emosional, menjelaskan kondisi kepada ibu dan keluarga, melaksanakan tindakan pertolongan sesuai manuver, lalu segera mengatur kolaborasi atau rujukan bila persalinan tidak lagi aman ditangani di fasilitas awal. WHO juga menekankan bahwa keputusan rujukan harus dibuat tanpa penundaan, dengan komunikasi yang jelas kepada keluarga dan fasilitas penerima.

E. Alur asuhan singkat

Ibu inpartu distosia bahu → nilai cepat ibu dan janin → kepala lahir dan tidak melakukan putaran paksi luar → identifikasi distosia bahu → lakukan pertolongan dengan manuver yang sesuai → tentukan kebutuhan kolaborasi/rujukan → dokumentasi dan handover yang jelas.

F. Tabel Red Flags & Eskalasi

Kegawatdaruratan Persalinan: Distosia Bahu

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pembukaan serviks tidak menunjukkan kemajuan bermakna pada pemantauan serial	Persalinan tidak maju dan perlu evaluasi lebih lanjut terhadap power, passenger, dan passage	Lapor ke pembimbing/DPJP, evaluasi ulang lengkap, siapkan kolaborasi atau rujukan
Kepala janin tertahan dibahu dan tidak melakukan putaran paksi luar	Curiga distosia bahu, malposisi, malpresentasi, atau disproporsi sefalopelvik	Jangan menunda evaluasi; lakukan pertolongan persalinan segera
DJJ <110 x/menit atau >160 x/menit	Menunjukkan kemungkinan gawat janin	Reposisi ibu, nilai cepat kondisi ibu-janin, lapor segera, percepat eskalasi
DJJ tidak terdengar	Curiga IUFD	Percepat persalinan
Ibu tampak sangat lelah, gelisah, dehidrasi, nadi meningkat, atau suhu meningkat	Menunjukkan perburukan kondisi maternal dan risiko infeksi/kelelahan persalinan	Stabilisasi awal, cairan sesuai kebutuhan, pantau ketat, kolaborasi/rujukan
Ketuban pecah dengan mekonium	Meningkatkan kecurigaan kompromi janin	Pantau janin ketat, lapor segera, siapkan rujukan
Perdarahan pervaginam abnormal	Dapat mengarah pada komplikasi obstetri yang lebih serius	Nilai cepat kondisi ibu, tangani sesuai prioritas, rujuk segera
Moulage/caput bertambah, edema serviks, atau nyeri abdomen menetap	Meningkatkan kecurigaan persalinan obstruktif	Hentikan penundaan, lapor dan rujuk segera
Tanda syok atau penurunan kesadaran	Kegawatdaruratan maternal	Resusitasi awal sesuai kewenangan, panggil bantuan, rujuk emergensi
Keputusan rujukan sudah jelas tetapi proses tertunda	Menambah risiko ibu dan janin	Aktifkan rencana rujukan tanpa delay, lengkapi handover, komunikasikan ke keluarga dan fasilitas penerima

G. Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Kegawatdaruratan Persalinan – Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian partus lama dan distosia	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan bahwa fase aktif persalinan dimulai pada pembukaan 5 cm	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu bersalin dengan kemajuan persalinan tidak memuaskan	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menilai his, pembukaan serviks, dan penurunan kepala secara klinis dari data yang tersedia	☐	☐	
5	Saya sudah bisa membaca partograf dan mengenali persalinan yang tidak maju	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi kemungkinan penyebab berdasarkan power, passenger, dan passage	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya ibu pada kasus partus lama atau distosia	☐	☐	
8	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya janin pada kasus partus lama atau distosia	☐	☐	
9	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	
10	Saya sudah bisa memposisikan ibu dan memberikan dukungan yang tepat saat terjadi kegawatdaruratan persalinan	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menyiapkan pemantauan ibu dan janin secara cepat dan sistematis	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan janin kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk segera	☐	☐	
14	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover singkat dengan jelas	☐	☐	
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan tindakan awal secara ringkas dan tepat	☐	☐	
16	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Referensi

- Astuti Dyah Bestari D, Mandiri A, Martini N. Participatory Rural Appraisal. J Kreat Pengabdian Masyarakat [Internet]. 2024;7:943–52. Available from: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/118033388/Download_20Artikel-libre.pdf?1725748505=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPemetaan_Kesehatan_Ibu_dan_Anak_melalui.pdf&Expires=1774967666&Signature=eNEc1OE00GLmcuse0eXGdfAOklPKT8s7yYJSzIfGfbGkmYehGi059xV2bsY8G8dGy6ktjvhaS2DfiAGz7IV5hOTUVKHpZt6Ck1oZsjVR5eIT51XTyLBxbLqwk9Ra4HY3y8h3HtKaBht9xzc6A9O-uCHHIKpnh9PNfVOq6yWxIKQnkJJFL5mnKsZfLtuO1s5sf6RssRTsNLeJ5wScBbZg-oAqXRB4wtUShpVoXZRrv5wYkVtALuNKBx3jWzy13EJ2zaMSp1tqsP7zF9xB83vFbCNyfykSThZNBW4ydMUQnsOKJ7ZsCEmR0UIUDzfcYX8VaXp1jQuL2EXC3LR8ECMLQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Anik Sulistiyanti SSTMK, Bdn. Okky Merben STK, Bdn. Ria Fazelita Br Gultom MTK, Bdn. Dewi Suri Damayanti SSTMK, Nurul Abidah SSTMK, Bd. Nurhidaya Fitria STKMK, et al. Asuhan Kebidanan Berbasis Komunitas [Internet]. PT Bukuloka Literasi Bangsa; 2025. Available from: <https://books.google.co.id/books?id=x8iiEQAAQBAJ>
- Kemenkes RI 2018. Modul Pelatihan Surveilans. In PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN; 2018. Available from: https://repositori-ditjen-nakes.kemkes.go.id/582/1/Modul_Pelatihan_Surveilans_Epidemiologi_bagi_Petugas_Puskesmas.pdf
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2023). Intrapartum care (NICE Guideline NG235).
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

- World Health Organization. (2008). Education material for teachers of midwifery: Midwifery education modules (2nd ed., Module 3, Managing prolonged and obstructed labour).
- World Health Organization. (2017). Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors (2nd ed.).
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience.
- World Health Organization. (2020). WHO labour care guide: User's manual.
- World Health Organization. (2025). *WHO labour care guide: Implementation resource package*.

BAB 3

POSYANDU DAN UKBM :TATA KELOLA, ALUR PELAYANAN, DAN PEMBINAAN KADER

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, kebijakan, dan prinsip pelayanan kebidanan komunitas serta pelayanan KIA primer berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian kebutuhan dan masalah KIA pada keluarga/komunitas menggunakan data, surveilans, dan analisis prioritas.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-7
CPL-3	Mampu merencanakan dan memberikan asuhan kebidanan berbasis keluarga sepanjang siklus kehidupan dengan kesinambungan layanan (continuity of care).	CPMK-2; CPMK-6
CPL-4	Mampu mengorganisasi dan mengelola layanan KIA berbasis komunitas (Posyandu/UKBM, layanan terpadu) serta membangun jejaring rujukan dan kemitraan.	CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan komunikasi efektif, KIE, promosi kesehatan, pemberdayaan kader/masyarakat, dan pendekatan sensitif budaya.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-2
CPL-6	Menunjukkan profesionalisme, etika, keselamatan, serta kemampuan monitoring-evaluasi dan perbaikan mutu program KIA.	CPMK-1; CPMK-7; CPMK-3

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menguasai konsep, kebijakan dasar, dan peran profesi dalam kebidanan komunitas serta prinsip etika–keselamatan di pelayanan primer.
CPMK-2	Menerapkan pendekatan keluarga dan siklus kehidupan dalam perencanaan serta pelaksanaan asuhan kebidanan berbasis keluarga dan kesinambungan layanan.
CPMK-3	Menganalisis data KIA dan surveilans untuk pemetaan masalah, penetapan prioritas, serta perencanaan intervensi berbasis bukti.
CPMK-4	Merancang dan mengelola penyelenggaraan layanan KIA berbasis komunitas (Posyandu/UKBM dan layanan terpadu) termasuk pembinaan kader dan jejaring rujukan.
CPMK-5	Melaksanakan KIE/promosi kesehatan dan intervensi gizi ibu–bayi–balita di komunitas dengan strategi perubahan perilaku yang terukur.
CPMK-6	Melakukan edukasi, konseling, dan tindak lanjut layanan kesehatan reproduksi remaja serta keluarga berencana di komunitas secara berpusat pada klien.
CPMK-7	Menyusun strategi pencegahan–penanggulangan masalah KIA prioritas, kesiapsiagaan rujukan, kolaborasi lintas sektor, serta monitoring-evaluasi program.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Kebidanan Komunitas dan Peran Bidan di Pelayanan Primer	1.1 Menjelaskan ruang lingkup, prinsip, dan posisi kebidanan komunitas dalam pelayanan primer.	1.2 Menguraikan peran bidan, etika profesi, dan keselamatan pelayanan pada konteks komunitas.	CPMK-1	CPMK-4
Bab 2. Pendekatan Keluarga dan Siklus Kehidupan: Asuhan Kebidanan Berbasis Keluarga	2.1 Mengidentifikasi kebutuhan KIA keluarga berdasarkan siklus kehidupan dan determinan sosial.	2.2 Menyusun rencana asuhan berbasis keluarga (tujuan, intervensi, monitoring) yang berpusat pada klien.	CPMK-2	CPMK-1
Bab 3. Pemetaan Masalah KIA di Wilayah Kerja: Data, Surveilans, dan Penetapan Prioritas	3.1 Mengolah data KIA (indikator, register, surveilans) untuk menggambarkan situasi wilayah kerja.	3.2 Menetapkan prioritas masalah dengan kriteria terukur serta menyusun rencana tindak lanjut.	CPMK-3	CPMK-7; CPMK-4
Bab 4. Posyandu dan UKBM: Tata Kelola, Alur Pelayanan, dan Pembinaan Kader	4.1 Menjelaskan model UKBM/Posyandu, peran kader, dan prinsip tata kelola layanan.	4.2 Mendesain alur pelayanan Posyandu dan rencana pembinaan/supervisi	CPMK-4	CPMK-5; CPMK-2

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
		kader berbasis kebutuhan.		
Bab 5. Pelayanan KIA Terpadu di Puskesmas/Desa: Integrasi ANC, Persalinan, Nifas, dan Neonatus	5.1 Menyusun rancangan integrasi layanan ANC–persalinan–nifas–neonatus pada tingkat primer/komunitas.	5.2 Menetapkan alur rujukan, koordinasi tim, dan mekanisme pencatatan untuk layanan terpadu.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-7
Bab 6. Kunjungan Rumah dan Continuity of Care: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Dokumentasi	6.1 Menyusun rencana kunjungan rumah dan continuity of care berbasis risiko, jadwal, dan sumber daya.	6.2 Menghasilkan dokumentasi dan komunikasi antar layanan untuk menjamin kesinambungan asuhan.	CPMK-2	CPMK-7; CPMK-1
Bab 7. Promosi Kesehatan dan KIE KIA: Metode, Media, dan Strategi Perubahan Perilaku	7.1 Memilih metode dan media KIE sesuai sasaran (ibu, keluarga, kader) dan konteks budaya.	7.2 Merancang strategi perubahan perilaku serta indikator evaluasi keberhasilan KIE.	CPMK-5	CPMK-2
Bab 8. Gizi Ibu, Bayi, dan Balita di Komunitas: Pencegahan Anemia, KEK, dan Stunting	8.1 Mengidentifikasi risiko anemia, KEK, dan stunting melalui skrining dan data pertumbuhan komunitas.	8.2 Menyusun paket intervensi gizi, rujukan, dan pemantauan pertumbuhan berbasis keluarga.	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-7
Bab 9. Kesehatan Reproduksi Remaja di Komunitas: Edukasi, Pencegahan Risiko, dan Rujukan	9.1 Merancang program edukasi kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan perilaku berisiko.	9.2 Menyusun alur konseling, rujukan, dan jejaring layanan ramah remaja.	CPMK-6	CPMK-5
Bab 10. Keluarga Berencana di Tingkat Komunitas: Pelayanan, Jejaring, dan Tindak Lanjut	10.1 Melaksanakan konseling KB berbasis hak, kebutuhan, dan pengambilan keputusan bersama.	10.2 Menyusun mekanisme tindak lanjut pengguna KB (monitor efek samping, kepatuhan, rujukan).	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-2
Bab 11. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah KIA Prioritas: Perdarahan, Preeklamsia, dan Infeksi	11.1 Mengidentifikasi tanda bahaya dan faktor risiko perdarahan, preeklamsia, dan infeksi pada tingkat komunitas.	11.2 Menyusun rencana penanganan awal, rujukan cepat, dan pelacakan kasus sampai tuntas.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 12. Kesiapsiagaan Keluarga dan Desa Siaga: Birth Preparedness, Rencana Rujukan, dan Transport	12.1 Memfasilitasi birth preparedness dan rencana rujukan keluarga (biaya, donor, kontak, transport).	12.2 Mengembangkan rencana transport dan komunikasi darurat desa serta kegiatan simulasi kesiapsiagaan.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-4
Bab 13. Kolaborasi Lintas Program dan Lintas Sektor: Jejaring, Kemitraan, dan Advokasi	13.1 Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan membangun kemitraan lintas program/sektor untuk KIA.	13.2 Menyusun strategi advokasi berbasis data dan rencana pertemuan koordinasi yang terdokumentasi.	CPMK-7	CPMK-4; CPMK-5
Bab 14. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program KIA: Indikator, Register, dan Audit Komunitas	14.1 Menetapkan indikator, sumber data, dan kelengkapan register/pelaporan program KIA.	14.2 Melakukan analisis capaian, audit komunitas sederhana, serta rencana perbaikan berbasis temuan.	CPMK-3	CPMK-7; CPMK-4

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tertulis (MCQ/SAQ) + analisis kasus singkat	Ketepatan konsep & istilah; akurasi mengaitkan peran bidan dengan pelayanan primer; konsistensi keputusan etika–keselamatan pada skenario	10	Lembar jawaban ujian + analisis kasus
CPMK-2	Studi kasus keluarga + OSCE/role play kunjungan rumah + portofolio CoC	Kelengkapan pengkajian keluarga; ketepatan rencana asuhan (tujuan SMART, intervensi, jadwal); mutu dokumentasi & rencana tindak lanjut	15	Rencana asuhan keluarga + logbook/portofolio CoC
CPMK-3	Tugas analisis data (worksheet/spreadsheet) + presentasi peta masalah	Akurasi hitung/interpretasi indikator; ketepatan prioritas (kriteria/scoring); kualitas rancangan	20	Dashboard/peta prioritas + ringkasan rencana intervensi

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		intervensi (sasaran, indikator keluaran)		
CPMK-4	Proyek desain layanan (kelompok) + presentasi + peer assessment	Kejelasan alur layanan; kesesuaian pembinaan kader; kelengkapan jejaring rujukan & pembagian peran operasional	15	Dokumen SOP/alur layanan + rencana pembinaan kader
CPMK-5	Proyek KIE & gizi (rencana + media) + penilaian kinerja	Kesesuaian pesan–media; penerapan strategi perubahan perilaku; ketepatan paket intervensi gizi & indikator pemantauan	15	Media KIE + rencana intervensi gizi + instrumen evaluasi
CPMK-6	OSCE konseling remaja/KB + tugas rujukan & tindak lanjut	Keterampilan komunikasi & informed choice; akurasi informasi opsi/risiko; kelengkapan rencana follow-up/rujukan & catatan konseling	10	Checklist OSCE + catatan konseling + rencana tindak lanjut
CPMK-7	Ujian berbasis skenario (case-performance) + laporan M&E/audit sederhana	Ketepatan respon awal & rujukan; kelengkapan rencana kesiapsiagaan (BP, transport, komunikasi); kualitas rencana M&E (indikator, pelaporan, umpan balik)	15	Rencana kesiapsiagaan & rujukan + ringkasan M&E/audit komunitas

Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Akurasi konsep dan istilah kebidanan komunitas & pelayanan primer	Banyak konsep keliru; istilah tidak tepat; penjelasan tidak runtut	Konsep dasar cukup benar namun parsial; istilah belum konsisten; penjelasan umum	Konsep tepat dan cukup lengkap; istilah konsisten; penjelasan runtut	Konsep sangat akurat dan komprehensif; istilah konsisten; mengaitkan konteks, kebijakan, dan praktik secara kritis
1.2 Konsistensi penerapan etika dan keselamatan dalam analisis kasus	Isu etika/risiko tidak teridentifikasi; keputusan tidak sesuai; tanpa alasan	Isu teridentifikasi sebagian; keputusan umum; alasan terbatas	Isu utama teridentifikasi; keputusan sesuai; alasan logis dan langkah dasar jelas	Analisis menyeluruh; keputusan tepat berbasis risiko; langkah konkret mencakup komunikasi, dokumentasi, dan pencegahan

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan pengkajian keluarga dan penetapan kebutuhan	Data keluarga tidak lengkap; kebutuhan tidak jelas; tidak ada prioritas	Data cukup namun ada komponen penting hilang; prioritas belum tajam	Data lengkap dengan prioritas jelas; kebutuhan dirumuskan terukur	Data komprehensif; prioritas sangat tepat; memasukkan determinan sosial dan faktor protektif secara terintegrasi
2.2 Kualitas rencana asuhan & dokumentasi kesinambungan	Tujuan/intervensi tidak spesifik; rencana tidak realistis; dokumentasi minim	Tujuan/intervensi cukup spesifik namun belum konsisten; follow-up umum; dokumentasi cukup	Tujuan SMART; intervensi sesuai; follow-up jelas; dokumentasi rapi	Tujuan SMART komprehensif; intervensi terintegrasi lintas layanan; follow-up terjadwal; dokumentasi lengkap dan mudah ditelusuri

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan pengolahan dan interpretasi indikator/data KIA	Perhitungan/interpretasi salah; sumber data tidak jelas	Perhitungan cukup benar namun ada kekeliruan; interpretasi deskriptif	Perhitungan benar; interpretasi tepat; menyebut keterbatasan data	Perhitungan sangat akurat; interpretasi analitis (tren/risiko); validasi sumber dan kualitas data jelas
3.2 Ketepatan prioritas dan rancangan intervensi berbasis data	Prioritas tidak berbasis kriteria; intervensi tidak terkait data; indikator tidak ada	Prioritas memakai kriteria terbatas; intervensi umum; indikator belum terukur	Prioritas jelas dengan kriteria; intervensi sesuai; indikator terukur	Prioritas kuat dengan pembobotan; intervensi spesifik dan feasible; indikator keluaran–hasil lengkap beserta baseline/target

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kejelasan desain tata kelola/alur layanan Posyandu/layanan KIA terpadu	Alur tidak jelas; peran tidak terbagi; tidak sesuai konteks	Alur cukup jelas namun ada celah; peran sebagian; standar minimal	Alur jelas dan logis; peran terdefinisi; standar dan titik kontrol ada	Alur sangat jelas dan efisien; peran rinci; standar mutu, mitigasi risiko, dan mekanisme koordinasi terintegrasi
4.2 Mutu rencana pembinaan kader dan jejaring rujukan/kolaborasi	Tidak ada strategi pembinaan; jejaring rujukan tidak terbentuk	Pembinaan ada namun tidak sistematis; jejaring terbatas	Pembinaan sistematis (materi, jadwal, supervisi); jejaring rujukan jelas	Pembinaan komprehensif berbasis kebutuhan; jejaring kuat dengan peran lintas program, SOP rujukan, dan mekanisme umpan balik

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kesesuaian pesan, media, dan metode KIE	Pesan tidak tepat sasaran; media tidak sesuai; tanpa struktur	Pesan cukup sesuai namun terlalu umum; media standar; struktur terbatas	Pesan sesuai sasaran; media tepat; metode jelas dan terarah	Pesan sangat relevan dan sensitif budaya; media kreatif dan efektif; metode terintegrasi dengan rencana evaluasi
5.2 Mutu paket intervensi gizi & strategi perubahan perilaku + indikator evaluasi	Intervensi tidak sesuai masalah; tanpa strategi perilaku; indikator tidak ada	Intervensi sesuai sebagian; strategi perilaku umum; indikator terbatas	Intervensi sesuai dan realistis; strategi perilaku jelas; indikator terukur	Intervensi komprehensif (pencegahan–rujukan–pemantauan); strategi perilaku kuat; indikator lengkap (proses–keluaran–hasil)

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Keterampilan konseling kesehatan reproduksi remaja/KB	Komunikasi tidak efektif; informasi keliru; tidak ada informed choice	Komunikasi cukup; informasi dasar benar; pilihan belum dieksplorasi	Komunikasi empatik; informasi tepat; informed choice terlihat	Komunikasi sangat efektif dan aman; informasi akurat dan seimbang; pengambilan keputusan bersama kuat, menghormati privasi dan hak
6.2 Kelengkapan rencana tindak lanjut, rujukan, dan dokumentasi	Tidak ada tindak lanjut; rujukan tidak jelas; dokumentasi tidak lengkap	Tindak lanjut ada namun umum; rujukan sebagian; dokumentasi cukup	Tindak lanjut spesifik dan terjadwal; rujukan jelas; dokumentasi rapi	Tindak lanjut komprehensif (monitor risiko/efek); rujukan berbasis kriteria; dokumentasi lengkap dan dapat ditelusuri

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan respon skenario masalah KIA prioritas & kesiapsiagaan rujukan	Salah mengenali risiko; respon tidak tepat; rencana rujukan tidak ada	Risiko dikenali sebagian; respon dasar; rencana rujukan umum	Risiko dikenali tepat; respon awal sesuai; rencana rujukan jelas	Risiko dikenali cepat dan tepat; respon terstandar; rencana rujukan lengkap (BP, transport, komunikasi, pelacakan) dan siap diterapkan
7.2 Kualitas rencana monitoring-evaluasi, pelaporan, dan perbaikan mutu	Indikator tidak jelas; pelaporan tidak sistematis; tanpa tindak lanjut	Indikator dasar ada; pelaporan minimal; tindak lanjut umum	Indikator terukur; pelaporan rapi; tindak lanjut berbasis temuan	Indikator komprehensif; pelaporan akurat dan tepat waktu; audit/umpan balik menghasilkan rencana perbaikan mutu yang spesifik dan terukur

Uraian Materi

A. Teori Dasar

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara mandiri. Posyandu berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, perbaikan gizi, serta pencegahan penyakit. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, Posyandu menjadi strategi penting dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Hal ini sejalan dengan konsep pelayanan kesehatan dasar yang dikembangkan oleh World Health Organization melalui pendekatan Primary Health Care.

Sebagai bagian dari UKBM, tata kelola Posyandu menuntut adanya sistem manajemen yang terstruktur dan partisipatif. Tata kelola tersebut mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kader kesehatan, puskesmas sebagai pembina teknis, pemerintah desa atau kelurahan, serta organisasi masyarakat seperti PKK. Prinsip tata kelola yang baik menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola masalah kesehatan di lingkungannya.

Pelaksanaan pelayanan di Posyandu dilakukan melalui sistem lima meja yang mencerminkan alur pelayanan terintegrasi. Kegiatan dimulai dari pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, hingga pelayanan kesehatan. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap sasaran mendapatkan pelayanan secara sistematis dan berkesinambungan. Selain itu, pelayanan Posyandu juga mengadopsi konsep *continuum of care*, yaitu pendekatan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, hingga lanjut usia. Dengan demikian, Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan Posyandu sangat bergantung pada peran kader kesehatan sebagai pelaksana utama kegiatan di tingkat masyarakat. Kader merupakan anggota masyarakat yang dipilih dan dilatih untuk membantu tenaga

kesehatan dalam memberikan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pembinaan kader menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kualitas layanan Posyandu. Pembinaan tersebut meliputi pelatihan dasar dan lanjutan, supervisi berkala, monitoring dan evaluasi, serta pemberian motivasi dan penghargaan. Dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat, kader berperan sebagai agen perubahan (agent of change) yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup sehat.

Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), pembelajaran mengenai Posyandu dan UKBM dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran yang terukur, baik pada tingkat program studi maupun mata kuliah. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mampu menganalisis tata kelola, mengidentifikasi alur pelayanan, serta mengevaluasi efektivitas pembinaan kader. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada kemampuan analitis dan aplikatif. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembelajaran berbasis kompetensi yang menekankan pada pencapaian hasil belajar yang relevan dengan kebutuhan praktik di lapangan.

Secara keseluruhan, Posyandu dan UKBM merupakan implementasi nyata dari konsep pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yang mengintegrasikan aspek manajemen, pelayanan, dan pendidikan kesehatan. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh sinergi antara masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah, serta dukungan sistem pembelajaran yang berbasis luaran seperti OBE. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola, alur pelayanan, dan pembinaan kader menjadi sangat penting dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dan mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

B. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Di sebuah desa, kegiatan Posyandu yang merupakan bagian dari Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) mengalami penurunan kunjungan dalam 6 bulan terakhir. Data menunjukkan bahwa hanya 45% ibu balita yang rutin datang ke Posyandu. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Kader Posyandu kurang aktif dalam melakukan penyuluhan dan kunjungan rumah.

Alur pelayanan 5 meja tidak berjalan optimal, terutama pada meja penyuluhan.

Dukungan dari pemerintah desa dan koordinasi dengan puskesmas masih terbatas. Sebagian masyarakat menganggap Posyandu hanya penting untuk imunisasi, bukan untuk pemantauan tumbuh kembang anak.

Akibatnya, ditemukan beberapa balita dengan status gizi kurang yang tidak terdeteksi sejak dini.

Pertanyaan Diskusi

1. Analisis Masalah

a. Apa saja permasalahan utama dalam tata kelola Posyandu pada kasus tersebut?

Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kunjungan masyarakat ke Posyandu? Bagaimana peran kader dalam kasus ini, dan apa kelemahannya?

Analisis Pelayanan

a. Jelaskan bagian mana dari sistem 5 meja yang tidak berjalan optimal dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan!

Bagaimana seharusnya alur pelayanan Posyandu yang ideal sesuai standar?

Analisis Pembinaan Kader

a. Mengapa pembinaan kader menjadi faktor penting dalam keberhasilan Posyandu?

Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi kader?

Pemecahan Masalah (Higher Order Thinking)

a. Susun rencana intervensi untuk meningkatkan kunjungan Posyandu di desa tersebut!

Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu? Jelaskan peran lintas sektor (pemerintah desa, puskesmas, PKK) dalam memperbaiki kondisi tersebut!

Refleksi

a. Jika Anda sebagai tenaga kesehatan, langkah pertama apa yang akan Anda lakukan?

Bagaimana penerapan konsep pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan kasus ini?

C. Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Posyandu & UKBM: Tata Kelola
3	Kasus	Posyandu di wilayah kerja tidak berjalan optimal akibat kader tidak aktif, pencatatan tidak lengkap, dan kegiatan tidak rutin.
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta mampu menunjukkan kompetensi sebagai bidan dalam pengelolaan Posyandu dan UKBM secara efektif
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK seorang bidan desa yang bertugas di wilayah dengan Posyandu yang tidak aktif. Kader jarang hadir, pencatatan tidak berjalan, dan kegiatan Posyandu tidak rutin dilakukan. TUGAS 1. Lakukan pengkajian masalah Posyandu. 2. Identifikasi masalah utama tata kelola Posyandu. 3. Rumuskan masalah kebidanan komunitas. 4. Susun rencana perbaikan tata kelola Posyandu. 5. Berikan edukasi dan motivasi kepada kader. 6. Jelaskan rencana koordinasi dan pembinaan kader.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3)

No.	Komponen	Isi
		- Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS - Jika peserta melakukan pengkajian, penguji memberikan data: - Jumlah kader aktif hanya 2 dari 5 orang - Pencatatan KMS tidak lengkap - Kegiatan Posyandu hanya berjalan 2 bulan sekali - Jika peserta merumuskan masalah: - Masalah utama: tata kelola Posyandu tidak optimal - Tindakan yang diharapkan: - Mengidentifikasi masalah secara sistematis - Mengusulkan pelatihan kader - Menyusun jadwal rutin Posyandu - Melakukan monitoring dan evaluasi - Melakukan koordinasi dengan puskesmas dan tokoh masyarakat - Memberikan motivasi kepada kader 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN - Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. - Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: - PS berperan sebagai kader Posyandu - PS tampak kurang semangat dan mengatakan: "Kami jarang dapat pelatihan" "Kadang bingung mencatat" - Jika diberi motivasi → PS menjadi lebih responsive
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi, Ibu PS: Pagi, Bu Peserta: Apa kendala di Posyandu? PS: Kader jarang aktif, Bu Peserta: Apakah pernah pelatihan? PS: Sudah lama sekali tidak ada

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Apakah pencatatan dilakukan? PS: Kadang tidak lengkap Peserta: Saya akan membantu meningkatkan kegiatan Posyandu PS: Baik, Bu, kami siap dibina
10	Kebutuhan manikin	Tidak diperlukan (role play komunitas)
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan ruang simulasi - Menyiapkan lembar penilaian
12	Kebutuhan alat	1. Meja dan kursi 2. Buku KIA/KMS 3. Format pencatatan Posyandu 4. Lembar penilaian 5. Alat tulis
13	Penulis	Bdn. Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
14	Referensi	Referensi 1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). <i>Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu</i>. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). <i>Buku KIA</i>. 3. World Health Organization. (2018). <i>Community Health Worker Programs</i>. 4. Notoatmodjo, Soekidjo - Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Posyandu dan UKBM

KOMPETENSI 1. Persiapan dan sikap profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
a. Penampilan dan kebersihan diri		
b. Sikap terhadap kader & masyarakat		
c. Persiapan alat & logistik		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3**= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- **2**= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- **1**= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- **0**= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Tata Kelola dan Posyandu UKBM

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
a. Menjelaskan struktur organisasi Posyandu		
b. Menyusun rencana kegiatan		
c. Koordinasi dengan kader/lintas sektor		
d. Menyiapkan sarana dan prasarana		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3**= Jika peserta ujian melakukan 15–19 langkah dengan tepat dan sistematis.
- **2**= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1**= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0**= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. Pelaksanaan Pelayanan

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
a. Registrasi & pencatatan		
b. Penimbangan & pengukuran		
c. Interpretasi hasil (KMS/status gizi)		
d. Pelayanan kesehatan (imunisasi, ANC, dll)		
e. Konseling/edukasi (kolaborasi dengan tenaga Kesehatan)		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3 = Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2 = Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1 = Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Pembinaan Kader

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Memberikan pelatihan atau edukasi untuk kader		
2. Supervisi dan evaluasi kader		
3. Komunikasi dengan kader/Masyarakat dalam pelayanan		
4. Memberikan umpan balik atau evaluasi kinerja kader		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 5. Komunikasi dan Edukasi

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Edukasi kepada ibu dan Balita		
2. Komunikasi interpersonal yang efektif		
3. Penggunaan Bahasa yang mudah dipahami		

Skoring KOMPETENSI 5

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 6. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Komunikasi efektif		
2. sikap empati		
3. Menjaga privasi dan etika profesi		
4. Penerapan prinsip keselamatan		
5. bertanggung jawab (menyelesaikan tugas dengan baik)		
6. Kerjasama tim (bekerjasama dengan kader dan tenaga lain)		

Skoring KOMPETENSI 6

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3
(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{75} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Posyandu & UKBM
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan mahasiswa dalam setting pelayanan komunitas. Penilai mengamati bagaimana mahasiswa melaksanakan tata kelola Posyandu, menjalankan alur pelayanan, serta membina kader secara nyata, kemudian memberikan umpan balik segera. Domain yang dinilai mencakup komunikasi, manajemen pelayanan, kemampuan teknis, edukasi, dan profesionalisme.	Pembimbing mengamati secara langsung mahasiswa saat mengelola kegiatan Posyandu, mulai dari persiapan meja pelayanan, koordinasi dengan kader, hingga pelaksanaan pelayanan ibu dan balita serta edukasi kesehatan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengelola pelayanan Posyandu secara sistematis, efektif, dan berbasis masyarakat, termasuk kemampuan membina kader agar mampu menjalankan peran secara mandiri. Penilaian juga menekankan pelayanan promotif dan preventif sesuai standar.	Mahasiswa dinilai tidak hanya memahami konsep Posyandu, tetapi mampu mengorganisasi kegiatan, menjalankan alur pelayanan 5 meja, serta membimbing kader dalam pencatatan dan penyuluhan.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi nyata di wilayah kerja, seperti Posyandu dengan cakupan rendah, kader kurang aktif, atau alur pelayanan tidak berjalan optimal.	Posyandu "Melati" memiliki kehadiran balita rendah (hanya 40%), kader belum memahami alur 5 meja dengan baik, dan pencatatan KMS tidak lengkap. Mahasiswa diminta membantu pelaksanaan Posyandu sekaligus membina kader.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan kegiatan nyata, seperti: persiapan Posyandu, pengorganisasian kader, pelaksanaan alur 5 meja (pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, pelayanan kesehatan), serta pembinaan kader.	Mahasiswa melakukan briefing kader, mengatur pembagian tugas meja 1–5, membantu penimbangan dan pencatatan KMS, memberikan penyuluhan gizi kepada ibu balita, serta melatih kader dalam pencatatan dan komunikasi.
Aspek yang dinilai	Meliputi pemahaman tata kelola Posyandu, ketepatan alur pelayanan, kemampuan komunikasi dengan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu memastikan alur berjalan lancar, kader

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Posyandu & UKBM
	masyarakat dan kader, keterampilan edukasi kesehatan, kemampuan supervisi kader, serta profesionalisme.	memahami tugasnya, serta pelayanan dilakukan secara ramah dan efektif.
Fokus observasi pembimbing	Fokus pada performa nyata mahasiswa dalam mengelola pelayanan komunitas, termasuk kemampuan koordinasi, pemecahan masalah, dan pemberdayaan kader.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah (misalnya kader pasif), mengambil inisiatif pembinaan, serta menjaga kualitas pelayanan Posyandu.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah kegiatan, mencakup kelebihan dan area yang perlu diperbaiki, serta saran pengembangan kompetensi.	Pembimbing menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, tetapi perlu meningkatkan kemampuan mengorganisasi waktu pelayanan dan memperkuat metode pembinaan kader.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, Hasil DOPS dikategorikan menjadi: kompeten, perlu supervisi, atau remedial, berdasarkan kinerja nyata mahasiswa.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu mengelola Posyandu secara sistematis dan membina kader dengan baik. Perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan. Remedial jika tidak mampu menjalankan alur atau membina kader.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level “does” dalam konteks pelayanan komunitas. Penilaian berbasis praktik nyata menjamin kesiapan mahasiswa dalam pelayanan kebidanan komunitas.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori Posyandu, tetapi mampu menerapkan tata kelola, alur pelayanan, dan pembinaan kader secara langsung di lapangan.

D. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 3.1

Portofolio pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Posyandu & UKBM
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam pelayanan kebidanan komunitas. Dalam pendekatan OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa dalam konteks pelayanan berbasis masyarakat.	Pada topik Posyandu, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu mengelola kegiatan Posyandu, menjalankan alur pelayanan, membina kader, serta meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio Bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik di komunitas.	Mahasiswa menunjukkan tidak hanya pernah mengikuti kegiatan Posyandu, tetapi juga mengalami peningkatan kemampuan dalam mengelola pelayanan dan membina kader setelah mendapat masukan dari pembimbing.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio sebagai bukti keterampilan terstruktur dan performa nyata di lapangan.	OSCE berisi simulasi alur pelayanan Posyandu dan edukasi kesehatan, sedangkan DOPS berisi hasil observasi langsung saat mahasiswa mengelola Posyandu dan melakukan pembinaan kader.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kegiatan atau kasus komunitas yang ditangani mahasiswa, meliputi masalah, intervensi, dan hasil.	Mahasiswa mencatat kasus Posyandu dengan cakupan rendah, kader kurang aktif, serta

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Posyandu & UKBM
		alur pelayanan tidak optimal, kemudian menjelaskan intervensi berupa pembinaan kader dan perbaikan alur pelayanan.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi risiko dalam pelayanan komunitas serta upaya pencegahannya.	Mahasiswa merefleksikan risiko kesalahan penimbangan, pencatatan KMS yang tidak akurat, serta kurangnya edukasi kepada ibu balita, dan menyusun strategi perbaikan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan kekuatan dan area perbaikan mahasiswa.	Pembimbing menilai mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan edukasi, namun perlu meningkatkan kemampuan koordinasi kader dan manajemen waktu pelayanan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bersifat berkelanjutan dan menilai konsistensi performa mahasiswa dalam berbagai situasi praktik.	Mahasiswa dinilai dari beberapa kegiatan Posyandu yang berbeda untuk melihat konsistensi dalam mengelola pelayanan dan membina kader.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mempertahankan kualitas performa dalam berbagai kesempatan praktik.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, dan refleksi, terlihat mahasiswa konsisten mampu menjalankan alur Posyandu dan melakukan pembinaan kader dengan baik.
Makna dalam OBE	Portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tercapai pada level "does" melalui performa nyata yang terdokumentasi.	Mahasiswa tidak hanya memahami konsep Posyandu, tetapi mampu menerapkan tata kelola, alur pelayanan, dan pembinaan kader secara konsisten di lapangan.

Tabel 3.2

Case Report pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Posyandu & UKBM
Hakikat case report	Case report merupakan laporan sistematis mengenai satu kasus komunitas yang ditangani mahasiswa selama praktik. Dalam pendekatan OBE, case report menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan masalah kesehatan masyarakat secara ilmiah.	Mahasiswa menyusun laporan tentang kegiatan Posyandu dengan permasalahan cakupan rendah, kader kurang aktif, dan alur pelayanan tidak berjalan optimal.
Tujuan	Case report Bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data komunitas, analisis masalah, perencanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi hasil.	Mahasiswa tidak hanya mendeskripsikan kegiatan Posyandu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, intervensi pembinaan kader, perbaikan alur pelayanan, serta hasil yang dicapai.
Isi laporan	Isi case report Meliputi identitas wilayah/kegiatan, masalah utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis komunitas, rencana tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, Mahasiswa menuliskan: cakupan balita 40%, kader tidak memahami alur 5 meja, pencatatan KMS tidak lengkap; analisis masalah berupa rendahnya pengetahuan kader; intervensi berupa pelatihan kader dan reorganisasi alur pelayanan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian komunitas, relevansi analisis masalah, ketepatan intervensi, serta kemampuan evaluasi hasil.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah utama (kader & alur), menentukan prioritas, dan melakukan intervensi yang tepat.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan analisis komunitas, problem solving, dan dokumentasi ilmiah dalam kebidanan komunitas.	Mahasiswa belajar bahwa keberhasilan Posyandu tidak hanya bergantung pada pelayanan, tetapi juga pada tata kelola dan pemberdayaan kader.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, Case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori kebidanan komunitas dalam situasi nyata secara sistematis.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan nyata dalam mengelola Posyandu, memperbaiki alur pelayanan, dan membina kader secara profesional.

Tabel 3.3
Refleksi Patient Safety pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Posyandu & UKBM
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pada pelayanan komunitas, menganalisis penyebab, serta merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kegiatan Posyandu, mahasiswa merefleksikan bahwa ketidaktepatan alur pelayanan dan kurangnya kompetensi kader dapat menyebabkan kesalahan pelayanan pada ibu dan balita.
Tujuan	Bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam pelayanan kebidanan komunitas.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan seperti pencatatan KMS tidak akurat, penimbangan tidak tepat, atau edukasi yang tidak adekuat dapat berdampak pada status kesehatan balita.
Fokus refleksi	Meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran dari praktik lapangan.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama meliputi kesalahan penimbangan, pencatatan yang tidak lengkap, alur pelayanan tidak berjalan, serta kurangnya edukasi kepada ibu balita.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa harus mampu mengenali potensi bahaya dalam pelayanan Posyandu dan UKBM.	Risiko yang diidentifikasi antara lain: kesalahan pengukuran berat badan, kesalahan pencatatan KMS, kader tidak menjalankan tugas sesuai meja, kurangnya deteksi dini masalah gizi, serta rendahnya kualitas edukasi kesehatan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk meminimalkan risiko keselamatan.	Mahasiswa melakukan pelatihan kader, memastikan penggunaan alat timbang yang benar, melakukan supervisi pencatatan KMS, memperjelas alur pelayanan 5 meja, serta meningkatkan kualitas edukasi kesehatan kepada ibu balita.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan insight atau pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman praktik.	Mahasiswa menyadari bahwa keberhasilan Posyandu tidak hanya pada pelayanan, tetapi juga pada sistem, koordinasi, dan pembinaan kader yang baik.
Makna dalam OBE	Refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional,	Mahasiswa tidak hanya melakukan kegiatan Posyandu, tetapi mampu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Posyandu & UKBM
	tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.	mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

E. Ringkasan Materi

Pembelajaran kebidanan komunitas pada Posyandu dan UKBM merupakan bagian penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa berbasis Outcome-Based Education (OBE), yang menekankan kemampuan nyata (*level does*) dalam pelayanan masyarakat. Posyandu sebagai bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berperan dalam pelayanan promotif dan preventif, khususnya pada ibu dan balita, sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penerapan metode Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) digunakan untuk menilai keterampilan mahasiswa secara langsung di lapangan. Mahasiswa diamati saat mengelola kegiatan Posyandu, mulai dari persiapan, pelaksanaan alur pelayanan 5 meja (pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, pelayanan kesehatan), hingga pembinaan kader. Penilaian mencakup aspek komunikasi, teknis, manajerial, dan profesionalisme, serta diikuti dengan umpan balik langsung untuk perbaikan berkelanjutan.

Portofolio menjadi bukti autentik perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Di dalamnya terdapat hasil OSCE, DOPS, catatan kasus komunitas, refleksi, dan umpan balik dosen/Clinical Instructor. Portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi mampu menerapkannya secara konsisten dalam berbagai situasi praktik Posyandu.

Case report digunakan untuk melatih kemampuan analisis mahasiswa terhadap masalah nyata di komunitas, seperti rendahnya cakupan Posyandu, kurang optimalnya alur pelayanan, dan keterbatasan kompetensi kader. Mahasiswa dituntut untuk mengintegrasikan data, menganalisis masalah, merencanakan intervensi (misalnya pembinaan kader dan perbaikan alur pelayanan), serta mengevaluasi hasilnya secara sistematis dan ilmiah.

Aspek patient safety dan community safety menjadi fokus penting dalam pelayanan Posyandu. Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi risiko seperti kesalahan penimbangan, pencatatan KMS yang tidak akurat, kurangnya edukasi, serta kegagalan alur pelayanan. Tindakan pencegahan dilakukan melalui supervisi, pelatihan kader, penggunaan alat yang tepat, serta penguatan edukasi kesehatan.

Secara keseluruhan, integrasi DOPS, portofolio, case report, patient safety, red flags, dan checklist kompetensi memberikan pendekatan pembelajaran yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga mahasiswa mampu menjadi tenaga kesehatan yang kompeten, kritis, dan profesional dalam pelayanan kebidanan komunitas.

F. Alur asuhan singkat

Alur asuhan pelaksanaan Posyandu dan UKBM dimulai dari persiapan (perencanaan kegiatan, koordinasi dengan bidan dan kader, serta penyiapan sarana) → dilanjutkan dengan pelaksanaan pelayanan Posyandu melalui alur 5 meja (pendaftaran → penimbangan → pencatatan KMS → penyuluhan → pelayanan kesehatan) → kemudian pembinaan kader (arahan, pelatihan, dan supervisi langsung) → selanjutnya identifikasi masalah (status gizi, kehadiran, kesalahan alur pelayanan) → dilanjutkan dengan tindak lanjut (edukasi, kunjungan rumah, atau rujukan ke fasilitas kesehatan) → kemudian pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan ke puskesmas → dan diakhiri dengan **evaluasi serta perbaikan kegiatan Posyandu secara berkelanjutan sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

G. Tabel Red Flags & Eskalasi

Posyandu & UKBM: Tata Kelola, Alur Pelayanan, dan Pembinaan Kader

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Kegiatan Posyandu tidak berjalan sesuai jadwal	Gangguan tata kelola dan perencanaan program	Koordinasi dengan kader dan bidan desa, susun ulang jadwal, laporkan ke puskesmas
Kader tidak hadir atau tidak aktif	Kelemahan SDM dan keberlanjutan program	Lakukan pembinaan ulang, rekrut kader baru, laporkan ke penanggung jawab UKBM
Tidak ada pembagian tugas kader	Alur pelayanan tidak sistematis	Lakukan briefing, tetapkan pembagian tugas sesuai meja pelayanan
Alur pelayanan 5 meja tidak berjalan	Pelayanan tidak efektif dan tidak terstandar	Evaluasi langsung, reorganisasi alur, supervisi oleh tenaga kesehatan
Penimbangan tidak sesuai prosedur	Risiko kesalahan penilaian status gizi	Hentikan sementara, lakukan koreksi teknik, pelatihan ulang kader
Pencatatan KMS tidak lengkap/salah	Data pertumbuhan tidak valid	Verifikasi ulang, lakukan pendampingan pencatatan
Tidak dilakukan penyuluhan kesehatan	Kurangnya edukasi masyarakat	Segera lakukan edukasi langsung, siapkan materi standar

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Kader tidak memahami tugas	Risiko kesalahan pelayanan	Lakukan pelatihan dan simulasi tugas kader
Kader tidak mampu melakukan pencatatan	Data program tidak dapat digunakan	Supervisi langsung dan latihan praktik
Balita tidak mengalami kenaikan berat badan	Risiko masalah gizi atau kesehatan	Konseling gizi, evaluasi penyebab, rujuk ke puskesmas
Ibu tidak rutin datang ke Posyandu	Cakupan pelayanan rendah	Lakukan kunjungan rumah dan pendekatan keluarga
Tidak dilakukan deteksi dini masalah kesehatan	Risiko keterlambatan penanganan	Lakukan skrining aktif, libatkan tenaga kesehatan
Tidak tersedia alat (timbangan/KMS)	Pelayanan tidak dapat berjalan optimal	Koordinasi logistik dengan puskesmas
Tidak ada pencatatan dan pelaporan	Tidak ada monitoring dan evaluasi program	Segera lakukan pencatatan, laporkan ke puskesmas
Tidak ada evaluasi kegiatan	Masalah berulang tanpa perbaikan	Lakukan rapat evaluasi rutin
Kurangnya koordinasi lintas sektor	Program tidak berkembang	Libatkan perangkat desa dan lintas sektor
Ditemukan balita dengan tanda gizi buruk/sakit	Kondisi berisiko tinggi pada balita	Segera rujuk ke puskesmas, lakukan pendampingan
Terjadi kesalahan edukasi kesehatan	Risiko misinformation pada masyarakat	Klarifikasi informasi, gunakan materi standar
Terjadi penolakan rujukan oleh keluarga	Risiko keterlambatan penanganan	Edukasi keluarga, komunikasi efektif, libatkan tokoh masyarakat
Masalah sudah teridentifikasi tetapi tidak ditindaklanjuti	Risiko kegagalan program	Segera lakukan eskalasi ke bidan desa/puskesmas tanpa penundaan

H. Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Kegawatdaruratan Persalinan – Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian Posyandu dan UKBM	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan dan manfaat Posyandu bagi masyarakat	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menjelaskan tata kelola Posyandu (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi)	☐	☐	
4	Saya sudah bisa melakukan persiapan kegiatan Posyandu (alat, tempat, kader)	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengkoordinasikan kader sebelum kegiatan Posyandu	☐	☐	
6	Saya sudah bisa menjelaskan dan menerapkan alur pelayanan 5 meja Posyandu	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan pendaftaran (meja 1) dengan benar	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan penimbangan balita sesuai standar (meja 2)	☐	☐	
9	Saya sudah bisa melakukan pencatatan KMS dengan benar (meja 3)	☐	☐	
10	Saya sudah bisa memberikan penyuluhan kesehatan yang sesuai (meja 4)	☐	☐	
11	Saya sudah bisa melakukan pelayanan kesehatan dasar (meja 5) sesuai kewenangan	☐	☐	
12	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan balita di Posyandu	☐	☐	
13	Saya sudah bisa memberikan edukasi kesehatan kepada ibu balita dengan komunikasi efektif	☐	☐	
14	Saya sudah bisa melakukan pembinaan kader (pelatihan, pendampingan)	☐	☐	
15	Saya sudah bisa membimbing kader dalam pencatatan dan pelaporan	☐	☐	
16	Saya sudah bisa melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Posyandu	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
17	Saya sudah bisa bekerja sama dengan kader, bidan, dan masyarakat	☐	☐	
18	Saya sudah bisa mengenali masalah dalam pelaksanaan Posyandu (red flags)	☐	☐	
19	Saya sudah bisa menentukan tindakan atau eskalasi yang tepat	☐	☐	
20	Saya sudah bisa mendokumentasikan kegiatan Posyandu dengan baik dan benar	☐	☐	
21	Saya sudah bisa menjaga sikap profesional dan etika dalam pelayanan komunitas	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman UKBM*. Jakarta.
- World Health Organization. (1978). *Declaration of Alma-Ata*.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Green, Lawrence W. & Kreuter, Marshall W.. (2005). *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*.
- Rifkin, Susan B.. (2014). *Paradigms Lost: Toward a New Understanding of Community Participation*.
- WHO Commission on Social Determinants of Health. (2008). *Closing the Gap in a Generation*.

BAB 4

PELAYANAN KIA TERPADU DI PUSKESMAS/ DESA INTEGRASI ANC, PERSALINAN, NIFAS DAN NEONATUS

CPL, dan CPMK

CPL-4	Mampu mengorganisasi dan mengelola layanan KIA berbasis komunitas (Posyandu/UKBM, layanan terpadu) serta membangun jejaring rujukan dan kemitraan.			
CPMK-4	Merancang dan mengelola penyelenggaraan layanan KIA berbasis komunitas (Posyandu/UKBM dan layanan terpadu) termasuk pembinaan kader dan jejaring rujukan.			
CPMK-7	Menyusun strategi pencegahan–penanggulangan masalah KIA prioritas, kesiapsiagaan rujukan, kolaborasi lintas sektor, serta monitoring-evaluasi program.			
Bab 5. Pelayanan KIA Terpadu di Puskesmas/Desa: Integrasi ANC, Persalinan, Nifas, dan Neonatus	5.1 Menyusun rancangan integrasi layanan ANC–persalinan–nifas–neonatus pada tingkat primer/komunitas.	5.2 Menetapkan alur rujukan, koordinasi tim, dan mekanisme pencatatan untuk layanan terpadu.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-7

Uraian Materi

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu upaya prioritas dalam pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga periode neonatus. Upaya ini menjadi sangat penting karena angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih menjadi indikator utama keberhasilan pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Dalam praktiknya, pelayanan KIA seringkali masih dilakukan secara terpisah antara masa kehamilan (Antenatal Care/ANC), persalinan, nifas, dan pelayanan bayi baru lahir. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya kesenjangan pelayanan (missed opportunities), keterlambatan deteksi komplikasi, serta tidak optimalnya kesinambungan asuhan (continuity of care). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pelayanan KIA yang terintegrasi, terutama di tingkat pelayanan primer seperti Puskesmas dan desa. Integrasi pelayanan KIA mencakup penyelenggaraan pelayanan yang berkesinambungan mulai dari ANC, persalinan, nifas, hingga neonatus, dengan melibatkan tenaga kesehatan, kader, keluarga, serta sistem rujukan yang efektif.

Pelayanan KIA terpadu di Puskesmas/desa tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga mencakup pendekatan promotif dan preventif, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan jejaring pelayanan kesehatan. Dengan integrasi ini diharapkan setiap ibu dan bayi mendapatkan pelayanan yang komprehensif, bermutu, dan berkesinambungan.

A. Pelayanan kesehatan Ibu dan anak Terpadu

1. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terpadu adalah pelayanan Kesehatan secara komprehensif, berkesinambungan dan terintegrasi bagi ibu dan anak yang dimulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas dan neonatus yang dilaksanakan di Puskesmas dan tatanan Komunitas (desa) dengan melibatkan; lintas program, lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak terpadu diawali dengan pelayanan antenatal. Pelayanan antenatal terpadu merupakan pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil.

Tujuan pelayanan terpadu yaitu

- a. meningkatkan kesehatan ibu dan bayi
- menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Meningkatkan asuhan kebidanan yang kontinuitas

Deteksi dini dan penanganan kegawatdaruratan secara cepat dan tepat

Pemberdayaan keluarga guna menjaga kesehatan ibu dan anak

Prinsip dasar pelayanan KIA terpadu

- a. Continuity of care merupakan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak dimulai semenjak kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, neonatal sampai pelayanan keluarga berencana. Asuhan kebidanan berkesinambungan memberikan bukti secara ilmiah dapat meningkatkan kesehatan, mencegah komplikasi pada masa kehamilan persalinan nifas dan BBL. Hasil penelitian telah banyak menunjukkan bukti bahwa COC dalam kehamilan akan berdampak pada penurunan kecemasan serta kesehatan fisik dan mental. Pada persalinan asuhan kebidanan secara komprehensif dalam persalinan dapat menurunkan nyeri persalinan, meningkatkan kenyamanan dan pengalaman persalinan yang positif. Selain itu dengan asuhan kebidanan yang komprehensif dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI. Asuhan kebidanan secara komprehensif juga terbukti meningkatkan kemampuan ibu dalam perawatan bayi secara baik. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi asuhan kebidanan komprehensif yaitu jarak tempat tinggal dengan pelayanan kesehatan, paritas, pendidikan.

Early detection

Early detection atau deteksi dini merupakan suatu upaya untuk mencegah komplikasi dengan mengidentifikasi sistematis dan berkelanjutan faktor resiko kesehatan pada ibu atau anak. Contoh penerapan deteksi dini pada ibu hamil yaitu pemeriksaan kadar hemoglobin, tekanan darah, pemeriksaan reduksi urin dan protein urin, penggunaan partograf dalam persalinan, skrining depresi post partum, deteksi dini hipotermia dan infeksi pada neonatus. Deteksi dini sangat penting dilakukan untuk menentukan kolaborasi dan rujukan Rasional

Tim kolaborasi

Tim kolaborasi merupakan tim kerjasama antara bidan dengan dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan asuhan. Prinsip utama dalam kolaborasi yaitu komunikasi efektif dengan SBAR karena kasus resiko tinggi memerlukan pendekatan multidisiplin sehingga membutuhkan komunikasi yang akurat, pembagian peran yang jelas, Clinical pathway bersama, Respect antarprofesi dengan demikian dapat mengurangi keterlambatan, meningkatkan keselamatan pasien. Teknik komunikasi SBAR merupakan standar komunikasi antar tenaga kesehatan yang berfokus pada pasien, metode SBAR meningkatkan keterampilan komunikasi dengan Tim dan pada situasi tertentu.

Rujukan Efektif

Sistem rujukan efektif adalah mekanisme pengalihan pasien dari fasilitas tingkat primer ke fasilitas yang lebih tinggi atau lengkap sehingga pasien mendapatkan penatalaksanaan yang efektif, efisien, aman dan terkoordinasi. Komponen sistem rujukan terdiri dari identitas kasus, ketika melakukan rujukan kasus yang dirujuk harus jelas diperlukan anamnesa yang akurat serta penatalaksanaan awal yang tepat, semua informasi haruslah transparan sehingga pasien mendapatkan asuhan yang tepat. Stabilitas sebelum rujukan sangatlah penting dilakukan agar kondisi pasien tidak semakin memburuk karena belum mendapatkan penatalaksanaan ditempat rujukan, komunikasi antar fasilitas rujukan sangatlah penting dan membantu untuk kesiapan alat bahan dan SDM untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, transportasi yang aman akan memudahkan untuk sampai dengan selamat dan tepat waktu di tempat rujukan, umpan balik yang cepat akan membantu tempat rujukan primer untuk mengambil keputusan. Penatalaksanaan rujukan yang tepat dapat mengurangi three delays (delay decision, delay transport, dan delay treatment) sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi. Salah satu upaya untuk menghindari keterlambatan dalam melakukan rujukan yaitu dengan meningkatkan edukasi secara intensif pada ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang tanda bahaya dan komplikasi untuk kesiapan dan persiapan apabila ada rujukan.

Pasien safety

Pasien safety adalah sistem untuk mencegah cedera atau kejadian tidak diharapkan selama pelayanan kesehatan melalui identifikasi risiko, pelaporan insiden dan perbaikan sistem. Identifikasi pasien benar sehingga tepat dalam pemberian terapi, komunikasi efektif untuk membina hubungan saling percaya dan asuhan yang tepat, keamanan obat high-alert dalam memberikan asuhan tidak lupa memberikan obat secara 6 benar 1) benar pasien, 2) benar Obat, 3) benar Dosis, 4) benar Waktu, 5) benar cara/ rute dan benar dokumentasi. Pencegahan infeksi dan pencegahan kesalahan prosedur sangatlah penting untuk mengefektifkan pelayanan kesehatan dengan penerapan pasien safety memberikan dampak positif untuk pelayanan kesehatan

B. Komponen Layanan terintegrasi

1. Integrasi ante natal care

Ante natal Care adalah merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk ibu hamil secara terstandar baik secara kualitas maupun kuantitas. Layanan terintegrasi menghasilkan peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan

esensial bagi perempuan deteksi, penanganan pengobatan awal serta meningkatkan kesehatan ibu.

Mekanisme pelaksanaan antenatal care dimulai dari:

a. Penetapan sasaran / jumlah ibu hamil

Standar kuantitas antenatal care merupakan jumlah kunjungan ibu hamil melakukan kunjungan ke tenaga kesehatan selama periode kehamilan, kunjungan ibu hamil 6 kali ini berdasarkan ketentuan

- 1) Satu kali pada trimester pertama
- 2) Dua kali pada trimester kedua
- 3) Tiga kali pada trimester ketiga

Selama kehamilan ibu hamil diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan USG 2 kali yaitu pada trimester 1 satu kali dan 1 kali pada trimester ke 3. USG dapat dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis baik di Puskesmas ataupun Rumah sakit. Apabila Puskesmas tidak bisa melakukan pemeriksaan Kehamilan sesuai standar termasuk pelayanan USG maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Standar kualitas layanan antenatal care terdiri dari 10 T dan pelayanan Ultrasonografi yang terdiri dari

- 1) Pengukuran Berat dan tinggi badan
- 2) Pengukuran tekanan darah
- 3) Pengukuran LILA
- 4) Pengukuran Tinggi Fundus Uteri
- 5) Penentuan Persentasi janin dan DJJ
- 6) Skrining status TT dan pemberian TT bila perlu
- 7) Pemberian Tablet Tambah Darah
- 8) Tes laboratorium
- 9) Tatalaksana kasus
- 10) Temu wicara (konseling)

Pelayanan antenatal yang berkualitas akan meningkatkan keikutsertaan ibu hamil dalam program kesehatan salah satunya VCT dibandingkan ibu hamil yang tidak mendapatkan pelayanan ANC yang tidak sesuai standar.

Integrasi dalam pelayanan antenatal care terdiri dari

- 1) Skrining faktor risiko obstetri yang bertujuan untuk mengidentifikasi riwayat yang dapat meningkatkan terjadinya komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, nifas yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan Neonatus. Skrining dilakukan sejak kontak pertama kali dengan tenaga kesehatan dan kunjungan berikutnya. Tujuan dilakukan skrining untuk menentukan kategori risiko kehamilan, menentukan kebutuhan asuhan

yang lebih intensif, menentukan melakukan rujukan yang fasilitas yang lebih memadai.

- 2) Deteksi dini merupakan suatu tindakan mengidentifikasi tanda dan gejala komplikasi pada kehamilan. Deteksi dini dengan pemeriksaan TTV dan laboratorium akan mencegah terjadinya komplikasi pada masa kehamilan seperti pemeriksaan tekanan darah akan mendeteksi seorang ibu hamil mengalami hipertensi atau Pre eklamsi dan pemeriksaan HB pada ibu hamil untuk mencegah anemia menjadi komplikasi dan perdarahan pada kehamilan muda atau lanjut.
- 3) Edukasi tanda bahaya merupakan tindakan pemberian informasi mengenai tanda bahaya yang bisa terjadi pada masa kehamilan, dengan pemberian informasi lebih awal dan jelas akan meningkatkan antisipasi dan pemeriksaan tenaga kesehatan. Edukasi tanda bahaya akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman ibu hamil mengenai tanda bahaya dan mengenal tanda bahaya yang terjadi pada ibu hamil.
- 4) Perencanaan persalinan masa kehamilan sangatlah penting, pada perencanaan kehamilan ibu akan merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan ibu bersalin dari tempat bersalin, penolong persalinan, transportasi, biaya dan donor darah. Dengan persiapan yang matang maka ibu hamil akan mengurangi keterlambatan ke tenaga kesehatan dan dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, terutama pada daerah terpencil. Selain itu perencanaan persalinan dapat dilakukan deteksi dini faktor resiko ibu hamil.
- 5) Skrining Depresi Antenatal adalah identifikasi kondisi gangguan psikologis ibu selama kehamilan seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, gangguan tidur, cemas berlebihan dan hilangnya minat untuk beraktivitas. Depresi antenatal memberikan dampak negatif pada kelahiran seperti meningkatkan resiko kelahiran prematur, BBLR dan asfiksia. Sehingga skrining depresi antenatal ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan asuhan segera dan mencegah terjadi post partum blues atau depresi post partum.

Keselamatan Pasien pada Pelayanan ANC

- 1) Identifikasi pasien dua parameter tenaga kesehatan harus mengidentifikasi pasien dengan minimal dua identitas berbeda sebelum melakukan pelayanan seperti nama, tempat tanggal lahir, dan nomor rekam medik
- 2) Pencegahan Medication error atau kesalahan dalam pemberian obat. Seorang tenaga kesehatan harus memastikan dosis obat, membaca ulang resep dan edukasi cara minum

- 3) Dokumentasi asuhan sangatlah penting minimal menggunakan SOAP yang merupakan metode sistematis untuk pencatatan dan pelaporan tindakan dan hasil tindakan untuk memastikan kesinambungan kondisi pasien dan evaluasi
- 4) Skoring resiko berbasis checklist alat bantu yang dapat membantu memastikan semua aspek resiko telah dilakukan secara lengkap untuk mencegah kelalaian pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Pelayanan Persalinan Aman dan terpadu

Pelayanan persalinan yang aman dari *World Health Organization* yaitu dengan menggunakan *Child Birth Checklist* yang merupakan panduan keselamatan untuk membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan atau asuhan persalinan secara tepat dan aman untuk mencegah kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi. Checklist ini digunakan pada empat momen penting pelayanan persalinan:

- a. Saat ibu masuk fasilitas kesehatan

Sebelum persalinan berlangsung

Segera setelah bayi lahir

Sebelum ibu dan bayi pulang

Berdasarkan Safe Childbirth Checklist dari World Health Organization intervensi utama dalam persalinan meliputi;

Penggunaan Partograf

Partograf adalah alat pemantauan kemajuan persalinan secara sistematis yang digunakan untuk menilai kondisi ibu dan janin selama proses persalinan, komponn pemantauan kemajuan persalinan yang ada dipartograf yaitu:

- a. Pembukaan serviks

Penurunan kepala janin

Frekuensi dan kekuatan kontraksi

Denyut jantung janin

Tekanan darah ibu

Suhu tubuh ibu

Tujuan penggunaan partograf adalah untuk memantau kondisi ibu dan janin, mendeteksi dini persalinan lama atau macet, mengidentifikasi tanda gawat janin menentukan kebutuhan intervensi atau rujukan .

Rasional: penggunaan partograf membantu tenaga kesehatan mengenali tanda gejala masalah atau kelainan pada proses persalinan lebih cepat, sehingga komplikasi seperti distosia atau gawat janin segera diatasi

Manajemen aktif kala Tiga atau AMTSL (Active Management of third Stage of labor)

Manajemen aktif kala tiga atau AMTSL merupakan suatu upaya pencegahan perdarahan pada kala 3 persalinan yang terdiri dari pemberian oksitosin secara intra Muskuler pada paha atas kanan bagian luar penegangan tali pusat terkendali dan masase uterus setelah plasenta lahir. Tujuan dilakukan AMTSL mencegah perdarahan Post partum, mempercepat pelepasan plasenta, mengurangi kehilangan darah yang berlebihan.

Rasional : perdarahan postpartum merupakan penyebab utamakematian ibu di dunia sehingga tindakan pencegahan melalui AMTSL atau manajemen aktif kala 3 sangat penting.

pencegahan Infeksi

pencegahan infeksi merupakan serangkaian tindakan mencegah penularan mikro organisme. Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan infeksi yaitu;

a. cuci tangan dengan 6 langkah sebelum atau sesudah melakukan tindakan

penggunaan sarung tangan steril

melakukan DTT dan sterilisasi alat dan tempat persalinan

penggunaan teknik aseptik

tujuan dari pencegahan infeksi yaitu melindungi ibu dan bayi dari infeksi postpartum dan neonatal, melindungi tenaga kesehatan, pasien dan pengunjung dari infeksi nosokomial.

Rasional: Infeksi maternal dan neonatal dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sepsis yang meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

IMD merupakan proses bayi mencari putting susu ibu dengan meletakkan bayi diatas dada setelah lahir selama satu sampai dua jam untuk memungkinkan bayi menyusu pertama kali secara alami. Manfaat dari IMD yaitu merangsang produksi ASI, meningkatkan bonding ibu dan bayi, menjaga suhu tubuh bayi sehingga terhindar dari hipotermi, meningkatkan imunitas bayi.

Rasional: IMD terbukti menurunkan risiko kematian neonatal terutama akibat hipotermi dan infeksi.

Resusitasi Neonatus

Resusitasi neonatus merupakan suatu upaya mengembalikan nafas bayi baru lahir atau neonatus yang mengalami gangguan nafas sehingga menjadi normal dan teratur. Langkah awal resusitasi yaitu:

a. Hangatkan tubuh bayi, letakkan bayi pada tempat yang datar kering dibawah pemancar panas atau infant warmer nyalakan lampu dan hindari dingin untuk mencegah hipotermi.

Atur Posisi kepala. Posisikan kepala sedikit tengadah (ekstensi/posisi sniffing) untuk membuka jalan nafas

Isap lendir. Bersihkan jalan nafas dengan mengisap lendir dari mulut terlebih dahulu kemudian hidung terutama jika ada sumbatan.

Keringkan tubuh bayi dengan kain kering dan bersih dan berikan rangsangan taktik (menepuk kaki/menggosok punggung) untuk merangsang pernafasan jika kain basah gantidengan kain kering.

Penilaian ulang, nilai kembali pernapasan detak jantung warna kulit, jika bayi masih megap-megap lakukan ventilasi tekanan positif (VTP)

Tujuan dilakukan HAIKAP yaitu untuk memastikan bayi baru lahir bisa bernafas spontan dan teratur serta mencegah terjadinya asfiksia neonatorum.

Rasional sebagian bayi memerlukan bantuan pernafasan pada menit pertama kehidupan untuk mencegah kerusakan organ akibat kekurangan oksigen
Keselamatan pasien dalam persalinan

Integrasi pada asuhan masa nifas

integrasi asuhan pada masa nifas adalah pelayanan yang berkesinambungan pada ibu setelah persalinan sejak 0 sampai 42 hari yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial dan reproduksi. Menurut World Health Organization (WHO) kematian ibu nifas yang terjadi dalam 42 hari sebesar 40% yang sebagian besar disebabkan oleh perdarahan post partum, infeksi dan hipertensi. Dalam asuhan masa nifas minimal dilakukan minimal 4 kali kunjungan yaitu:

a. kunjungan pertama (KF 1) (6-48 jam) setelah persalinan, tujuan dilakukan kunjungan pertama yaitu mencegah perdarahan postpartum dini, pemantauan kontraksi uterus dan kemampuan ibu dalam menyusui bayinya

Kunjungan kedua (KF2) (3-7 hari) pada kunjungan ini bidan bertugas untuk memastikan involusi uterus (kembali uterus ke bentuk semula), mengecek apakah ada gtanda-tanda infeksi, memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif dan kemampuan ibu dalam perawatan bayi.

Kunjungan ketiga KF3 (8-28 hari) sama halnya dengan KF2 ditambah dengan tumbuh kembang bayi.

Kunjungan keempat KF4 (29-42 hari) pada kunjungan ini bidan menilai pemulihan fisik ibu dan memberikan konseling tentang keluarga berencana pasca persalinan.

Kunjungan pada masa nifas sangatlah penting dilakukan selain untuk deteksi dini resiko atau pencegahan komplikasi secara fisik dengan kunjungan masa nifas juga bidan dapat melakukan skrining depresi post partum, di seluruh dunia sekitar 10% hamil dan 13% ibu nifas mengalami gangguan mental terutama depresi. Di negara berkembang sekitar 19,8% ibu mengalami gangguan mental setelah melahirkan. Ibu nifas yang mengalami depresi post partum tidak

bisa melakukan perannya sebagai ibu dengan baik yang dapat berakibat terhadap tumbuh kembang anak. Gangguan mental yang terjadi pada ibu nifas bisa diatasi dengan asuhan yang efektif yang diberikan oleh tenaga kesehatan(22), untuk mencegah dampak yang akan terjadi pada ibu atau pada bayi maka penting dilakukan pelayanan ibu nifas. Komponen integrasi pelayanan Nifas meliputi

Monitoring Involusi Uterus

Pemantauan proses kembalinya uterus ke ukuran semula sama seperti sebelum hamil. Monitoring ini sangat penting dilakukan untuk mendeteksi adanya perdarahan atau infeksi yang bisa terjadi pada masa nifas. Pemantauan yang dilakukan meliputi:

a. Tinggi Fundus Uteri

Konsistensi Uterus

Lochea adalah cairan yang keluar dari rahim melalui vagina pada masa nifas yang menandai proses pemulihan rahim pada masa nifas. Cairan ini terdiri dari campuran darah, jaringan rahim, lendir, dan selaput ketuban. Lochea umumnya terjadi selama 4–6 minggu pascamelahirkan dengan perubahan warna dan konsistensi.

Deteksi dini adanya tanda-tanda infeksi

salah satu asuhan pada masa nifas yaitu melakukan deteksi dini adanya tanda-tanda infeksi yang ditandai dengan demam lebih dari 38 derajat celsius, nyeri perut bagian bawah, lochea berbau, luka perinium atau luka Operasi Sesar. Tujuan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda infeksi untuk mencegah terjadinya komplikasi pada masa nifas dan komplikasi.

konseling pemberian ASI

konseling pemberian ASI merupakan edukasi dan dukungan yang diberikan oleh kepada ibu nifas agar bisa menyusui dengan benar sehingga ibu bisa memberikan ASI selama 6 bulan. Materi konseling yang diberikan bidan dalam pemberian ASI yaitu teknik menyusui, manajemen laktasi dan penanganan masalah dalam pemberian ASI seperti ASI kurang dan puting susu lecet. Tujuan konseling pemberian ASI yaitu meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, meningkatkan imunitas bayi dan mengurangi infeksi bayi serta meningkatkan bonding antara ibu dan bayi. Konseling yang dilakukan segera setelah melahirkan dapat mempengaruhi inisiasi menyusui dini dan praktik menyusui eksklusif.

Skринg depresi postpartum

Skринg depresi postpartum adalah proses identifikasi dini gangguan psikologis pada ibu setelah melahirkan untuk mencegah gangguan yang lebih

berat. Salah satu alat yang paling banyak digunakan adalah: Edinburgh Postnatal Depression Scale EPDS adalah kuesioner sederhana untuk menilai kemungkinan depresi pada ibu dalam masa nifas. EPDS terdiri dari 10 pertanyaan yang menggambarkan perasaan ibu dalam 7 hari terakhir denganm setiap pertanyaan memiliki skor 0-3. Beberapa aspek yang dinilai yaitu perasaan sedih, cemas gangguan tidur, kehilangan minat, perasaan bersalah dan pikiran menyakiti diri sendiri

Tujuan Skrining EPDS

a. Mendeteksi depresi postpartum secara dini

Mencegah gangguan mental yang lebih berat

Menentukan kebutuhan rujukan atau intervensi

Mendukung kesehatan ibu dan perkembangan bayi

Waktu pelaksanaan Skrining EPDS dapat dilakukan pada:

a. Hari ke-3 sampai minggu ke-2 postpartum

Minggu ke-6 postpartum

EPDS terdiri dari:

a. 10 pertanyaan

Menggambarkan perasaan ibu dalam 7 hari terakhir

Setiap pertanyaan memiliki skor 0–3

Integrasi Pelayanan Neonatus

Integrasi pelayanan neonatus adalah asuhan komprehensif dan berkesinambungan pada bayi baru lahir (0-28 hari yang menggaungkan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, deteksi dini komplikasi dan intervensi cepat dan edukasi keluarga. Menurut WHO kematian neonatal sebesar 75% terjadi pada 7 hari kehidupan dengan penyebab utama asfiksia, prematur dan infeksi. Komponen integrasi pelayanan neonatus terdiri dari

a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses meletakkan bayi di dada ibu segera setelah lahir selama minimal 1 jam untuk memulai menyusu secara alami.

Pencegahan hipotermi

Hipotermi merupakan suatu kondisi tubuh bayi $<35,5^{\circ}\text{C}$. penyebab bayi mengalami hipotermi yaitu lingkungan dingin, bayi tidak segera dikeringkan dan tidak dilakukan IMD. Upaya pencegahan hipotermi dapat dilakukan dengan:

- 1) mengeringkan bayi segera setelah lahir
- 2) kontak kulit ibu dan bayi dengan melakukan IMD
- 3) Membungkus bayi dengankain bersih kering dan hangat
- 4) Menunda memandikan bayi dalam 24 jam

skrining Ikterus

ikterus merupakan suatu keadaan kondii kuli dan mata bayi tampak kuning akibat peningkatan bilirubin. Hiperbilirubinemia didefinisikan sebagai kadar bilirubin serum total $\geq 5 \text{ mg/dL}$ ($86 \mu\text{mol/L}$)(28). Deteksi dini yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan kulit (zona Kramer). Observasi warna kulit terutama hari ke 2 sampai ke 7. Lakukan pemeriksaan bilirubin jika bayi kuning untuk menegakkan diagnosa. Dampak dari ikterus yaitu kernikterus (kerusakan otak) gangguan neorologis

Deteksi infeksi neonatus

Deteksi infeksi adalah upaya mengidentifikasi tanda-tanda awal infeksi pada bayi baru lahir seperti demam, hipotermi, tidak mau menyusu, nafas cepat, kejang dan letargi. Tujuan deteksi infeksi mencegah sepsis neonaturum dan menurunkan kematian neonatus.

Imunisasi HB-0 merupakan pemberian avaksin hepatitis B pertama pada bayi baru lahir dengan waktu 0-24 jam setelah lahir untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi.

C. Aktivitas belajar mahasiswa

Knows How (Mini Case)

Seorang ibu usia 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke Puskesmas untuk kontrol kehamilan. Dari hasil ANC sebelumnya diketahui ibu mengalami anemia ringan dan jarang kontrol. Saat ini ibu mengeluh sering pusing dan gerakan janin berkurang.

Hasil pemeriksaan:

1. TD: 100/70 mmHg

Nadi: 96 x/menit

Hb: 9 g/dL

DJJ: 150 x/menit

TFU sesuai usia kehamilan

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?

Faktor risiko apa yang dimiliki ibu?

Bagaimana hubungan kondisi ANC dengan kemungkinan komplikasi persalinan?

Apa tindakan yang harus dilakukan bidan pada kunjungan ini?

Edukasi apa yang perlu diberikan kepada ibu dan keluarga?

Apakah perlu rujukan? Jelaskan alasan Anda.

D. Soal OSCE Kebidanan

1. Judul

Pelayanan KIA Terpadu: ANC Risiko dan Persiapan Persalinan

Kasus

Ibu hamil dengan anemia dan risiko komplikasi menjelang persalinan

Tujuan

Menilai kemampuan mahasiswa dalam:

a. Anamnesis

Pemeriksaan ANC

Identifikasi risiko

Tindakan awal

Edukasi dan rujukan

Kompetensi

a. Anamnesis

Pemeriksaan fisik

Diagnosis/masalah

Tindakan klinis

KIE/konseling
Kolaborasi/rujukan
Profesionalisme

Skenario

Seorang ibu hamil 38 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan lemas dan pusing. Riwayat ANC tidak teratur. Hasil pemeriksaan Hb rendah dan ibu tampak pucat.

Tugas Peserta

- a. Lakukan anamnesis
- Lakukan pemeriksaan
- Tentukan diagnosis
- Lakukan tindakan
- Berikan edukasi
- Tentukan rujukan

RUBRIK PENILAIAN

1. Pengumpulan Data

- a. Keluhan utama
- Riwayat kehamilan
- ANC sebelumnya
- Riwayat penyakit
- Pola makan dan aktivitas

Tindakan Klinis

- a. Pemeriksaan lengkap
- Interpretasi hasil
- Penatalaksanaan anemia
- Perencanaan persalinan

KIE/Konseling

- a. Edukasi gizi
- Tanda bahaya
- Persiapan persalinan

Profesionalisme

- a. Komunikasi
- Empati
- Sistematis

E. DOPS (*Direct Observation of Procedural Skills*)

Tujuan:

Menilai kemampuan mahasiswa dalam:

1. Melakukan ANC terpadu

Identifikasi risiko

Tindakan awal

Contoh

Mahasiswa melakukan pemeriksaan ibu hamil anemia dan memberikan edukasi serta rujukan.

F. Portofolio

Bukti yang Dikumpulkan

1. OSCE

DOPS

Catatan kasus

Refleksi patient safety

G. Case Report

Mahasiswa membuat laporan kasus ibu hamil dengan anemia yang berisiko komplikasi, mencakup:

1. Data pasien

Analisis masalah

Tindakan

Evaluasi

H. Refleksi Patient Safety

Mahasiswa merefleksikan:

1. Risiko anemia pada kehamilan

Dampak terhadap persalinan

Pencegahan komplikasi

I. Rangkuman Materi

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) terpadu merupakan pendekatan pelayanan komprehensif, berkesinambungan (continuity of care), dan terintegrasi mulai dari masa kehamilan (ANC), persalinan, nifas, hingga neonatus di tingkat Puskesmas dan komunitas. Tujuan utama: meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, menurunkan aki dan akb, meningkatkan kualitas asuhan kebidanan berkelanjutan, deteksi dini dan penanganan kegawatdaruratan, pemberdayaan keluarga. prinsip utama, continuity of care (coc) → asuhan berkesinambungan, deteksi dini risiko & komplikasi, kolaborasi tim (sbar), sistem rujukan efektif (mengurangi 3 delay), patient safety. Komponen integrasi layanan ANC terdiri dari, minimal 6 kali kunjungan, standar 10T dan USG, skrining risiko (medis & psikologis), edukasi tanda bahaya, perencanaan persalinan. komponen integrasi persaliann terdiri dari safe childbirth checklist, partograf untuk deteksi dini komplikasi ibu dan janin, manajemen aktif kala 3 untuk pencegahan perdarahan, Pencegahan infeksi, IMD, resusitasi neonatus sedangakn pada pelayanan nifas yaitu kunjungan 4 kali (KF1–KF4), monitoring involusi uterus, deteksi infeksi dan perdarahan, konseling ASI, skrining depresi postpartum (EPDS) dan integrasi pelayanan neonatus terdiri dari IMD, pencegahan hipotermi, skrining ikterus, deteksi infeksi dan imunisasi HB-0

J. Tabel Red Flags & Eskalasi

Tahap	Red Flags (Tanda Bahaya)	Tindakan Awal	Eskalasi/Rujukan
Kehamilan (ANC)	Tekanan darah tinggi, edema, sakit kepala berat	Monitoring TTV, edukasi	Rujuk ke RS (curiga preeklamsia)
	Hb rendah (anemia berat)	TTD, nutrisi	Rujuk jika Hb sangat rendah
	Perdarahan	Stabilkan	Rujuk segera
	Depresi/cemas berat	Konseling awal	Rujuk psikolog/psikiater
Persalinan	Persalinan lama (partograf abnormal)	Observasi ketat	Rujuk (distosia)
	DJJ tidak normal	Monitoring	Rujuk (gawat janin)
	Perdarahan postpartum	AMTSL, uterotonik	Rujuk emergensi
	Infeksi (demam, ketuban bau)	Antibiotik awal	Rujuk
Nifas	Perdarahan > normal	Evaluasi uterus	Rujuk segera
	Demam, lochea bau	Antibiotik awal	Rujuk
	Nyeri hebat abdomen	Observasi	Rujuk
	Depresi postpartum	Skrining EPDS	Rujuk psikolog
Neonatus	Tidak bernapas/megap-megap	Resusitasi (HAIKAP)	Rujuk NICU
	Hipotermi (<35,5°C)	Hangatkan	Rujuk jika berat
	Ikterus dini/berat	Observasi bilirubin	Rujuk
	Tidak mau menyusu	Evaluasi	Rujuk

K. Daftar Pustaka

- Adli, F. K. (2022). *Edinburgh Post-natal Depression Scale (EPDS): Deteksi Dini dan Skrining Depresi Post-partum Edinburgh Post-natal Depression Scale (EPDS): Early Detection and Screening Post-partum Depression*. 13.
- Agnes Montolalu¹, Kusmiyati², I. M. (2010). *Hubungan Pelaksanaan Standar Pelayanan Antenatal Dengan Keikutsertaan Ibu Untuk Konseling dan Tes HIV*. 55–61.
- Azizah, N., Rahmawati, V. E., Wulandari, D. T., & Widaryanti, Y. (2024). Available online at: <http://journal.ahmareduc.or.id/index.php/AMJPM> *Edukasi Antenatal Care Terpadu Sebagai Upaya Deteksi Dini Terjadinya Komplikasi pada Ibu Hamil di Puskesmas Mayangan Jogoroto Jombang*. 4(1), 53–59.
- Beyene, B. N., Wako, W. G., Moti, D., Edin, A., & Debela, D. E. (2025). *Postnatal counseling promotes early initiation and exclusive breastfeeding: a randomized controlled trial*. February. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1473086>
- Chamy Rahmatika, Denos Imam Fratama, Werman, R. M. (2025). *PENTINGNYA PENCATATAN SKRINING DAN DETEKSI DINI UNTUK KESEHATAN IBU HAMIL DI KLINIK AMANAH PADANG PARIAMAN Chamy*. 8, 1260–1268.
- Christina, L. V., & Susilo, A. P. (2021). *Penggunaan Metode SBAR untuk Komunikasi Efektif antara Tenaga Kesehatan dalam Konteks Klinis*. 3(1), 57–63.
- Indonesia, K. K. R. (n.d.). *Pentingnya Pemeriksaan Kehamilan di Fasilitas Kesehatan atau Puskesmas*. 12 Agustus 2018. <https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kehamilan-anc-di-fasilitas-kesehatan>
- INDONESIA, K. M. K. R. (n.d.). *PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA HIPERBILIRUBINEMIA*. jdih.kemkes.go.id. (2024). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN*. 1–130.
- Jongh, T. E. De, Urganci, I. G., Allen, E., & Zhu, N. J. (2016). *Integration of antenatal care services with health programmes in low – and middle – income countries: systematic review*. 6(1). <https://doi.org/10.7189/jogh.06.010403>
- Khoriah Nst, Misrawati, J. (2022). *GAMBARAN GEJALA DEPRESI PADA IBU HAMIL DI KOTA PEKANBARU*. 11(2).

- Krisdai, Mien, Muhaimin, M. U. (2023). *Hubungan Pengetahuan Dengan Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Tambah*. 6.
- Mega Tri Yullianna, Wiyadi, H. S. (2023). *PENGARUH CONTINUITY OF CARE (COC) PADA ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM TERHADAP KEBERHASILAN PEMBERIAN ASI DI PMB MUZAYARAH BALIKPAPAN* *Effect*. 6(1), 62–70.
- Mukarramah, S., Damayanti, A., & Amin, W. (2025). *Efektivitas Continuum of Care Terhadap Kemampuan Ibu Dalam Perawatan Bayi di Kota Makassar*. XX(1), 173–179.
- Mulyati, T. Yu. (2012). *IMPLEMENTASI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN TINGGI Mulyati & Triani Yuliastanti* *Akademi Kebidanan Estu Utomo Boyolali*. IV(02), 71–83.
- Novita Rudiyaniti¹, B. U. (2018). DETERMINAN KETERLAMBATAN RUJUKAN MATERNAL DI INDONESIA (STUDI EKOLOGI RISKESDAS 2018). <https://Proceedings.Ums.Ac.Id/Semnasfik/Article/View/4294/3942>, 1–20. <https://proceedings.ums.ac.id/semnasfik/article/view/4294/3942>
- Prastika, C. E., & Kirana, D. N. (2025). *Asuhan Kebidanan Berkesinambungan pada Ny. T dengan Pemberian Aromaterapi Lavender untuk Mengurangi Nyeri Persalinan di Praktik Mandiri Bidan Hj. Zurrahmi*. 2(6), 784–798.
- Putri Winasari. Utari Christa Wardani, S. M. (2024). *Pengaruh Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Terhadap Hipotermi Pada Bayi Baru Lahir Peningkatan Produksi ASI Pada Ibu Post Partum*. 2(1).
- Rahayu Arum Winarningsih, N. N. (n.d.). *Edukasi Tanda Bahaya dan Upaya Pencegahan Komplikasi Pada Masa Kehamilan*. 3(1), 38–44.
- Restu Apriena Putri, T. E. (2021). *Dampak Depresi Antenatal Terhadap Hasil Kelahiran: Systematic Review*. 16(1), 63–70.
- S. Septiani, A. Aiti, A. E. (2022). CONTINUITY OF CARE (COC) IN MATERNAL HEALTH SERVICES. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, 108–117.
- Sari, R. N., Chobi, E., Uma, B., & Madiun, U. M. (n.d.). *Edukasi Tanda bahaya pada kelas Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Jiwan*. 50–55.
- Susiloningtyas, L., Kesehatan, P., & Perinatal, M. (2020). *SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA* *REFFERAL SYSTEM IN MATERNAL PERINATAL HEALTH*. 6–16.
- umi Anzamika, lilis susanti. (2025). *Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny "R" Dengan Penerapan Senam Nifas Untuk Involusi Uteri Comprehensive*. 3(2), 139–147.
- WHO. (n.d.). *Mental Health, Brain Health and Substance Use*. Retrieved March 30, 2026, from <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/promotion-prevention/maternal-mental-health>

WHO. (2015). *WHO Safe Childbirth Checklist Implementation Guide*.

WHO. (2024). *Newborn mortality*.

Widyastuti, R. D., Arso, S. P., & Suryoputro, A. (2025). *Keselamatan pasien sebagai pilar penting dalam mencegah kesalahan medis: Tinjauan sistematis*. 19(2), 277–285.

BAB 5

KUNJUNGAN RUMAH DAN CONTINUITY OF CARE: PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN DOKUMENTASI

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, kebijakan, dan prinsip pelayanan kebidanan komunitas serta pelayanan KIA primer berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian kebutuhan dan masalah KIA pada keluarga/komunitas menggunakan data, surveilans, dan analisis prioritas.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-7
CPL-3	Mampu merencanakan dan memberikan asuhan kebidanan berbasis keluarga sepanjang siklus kehidupan dengan kesinambungan layanan (continuity of care).	CPMK-2; CPMK-6
CPL-4	Mampu mengorganisasi dan mengelola layanan KIA berbasis komunitas (Posyandu/UKBM, layanan terpadu) serta membangun jejaring rujukan dan kemitraan.	CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Mampu melakukan komunikasi efektif, KIE, promosi kesehatan, pemberdayaan kader/masyarakat, dan pendekatan sensitif budaya.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-2
CPL-6	Menunjukkan profesionalisme, etika, keselamatan, serta kemampuan monitoring-evaluasi dan perbaikan mutu program KIA.	CPMK-1; CPMK-7; CPMK-3

CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menguasai konsep, kebijakan dasar, dan peran profesi dalam kebidanan komunitas serta prinsip etika–keselamatan di pelayanan primer.
CPMK-2	Menerapkan pendekatan keluarga dan siklus kehidupan dalam perencanaan serta pelaksanaan asuhan kebidanan berbasis keluarga dan kesinambungan layanan.
CPMK-7	Menyusun strategi pencegahan–penanggulangan masalah KIA prioritas, kesiapsiagaan rujukan, kolaborasi lintas sektor, serta monitoring-evaluasi program.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Kunjungan Rumah dan Continuity of Care: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Dokumentasi	6.1 Menyusun rencana kunjungan rumah dan continuity of care berbasis risiko, jadwal, dan sumber daya.	6.2 Menghasilkan dokumentasi dan komunikasi antar layanan untuk menjamin kesinambungan asuhan.	CPMK-2	CPMK-7; CPMK-1

A. Kunjungan Rumah

Definisi

Kunjungan rumah (*home visit*) merupakan bentuk pelayanan kesehatan profesional yang dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan di kediaman pasien, dengan tujuan utama mendekatkan akses layanan serta memantau kesehatan dalam konteks domestik yang nyaman. Lingkungan rumah dianggap sebagai tempat krusial di mana kesehatan dibentuk dan dipelihara, namun juga memiliki risiko paparan bahaya kesehatan tertentu; oleh karena itu, kunjungan ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk menilai kondisi fisik, sanitasi, higiene personal, hingga lingkungan keluarga secara mendalam guna memberikan dukungan sosial dan medis yang tepat sasaran. Berada di lingkungan yang familiar membuat pasien merasa lebih rileks dan bebas untuk berpartisipasi aktif dalam asuhan, sehingga edukasi kesehatan yang diberikan terbukti jauh lebih efektif dalam memicu perubahan perilaku dibandingkan pesan melalui media massa. Lebih lanjut, penelitian mengenai asuhan pascapersalinan di rumah menunjukkan bahwa baik ibu maupun bidan sangat menghargai fleksibilitas dan personalisasi dari model ini, karena selain menghilangkan beban fisik perjalanan bagi ibu baru, hal ini juga memberikan pemahaman yang lebih autentik bagi bidan mengenai situasi nyata pasien untuk menjamin kesejahteraan ibu dan bayi secara holistik (Diema Konlan et al., 2021).

Sebagai bagian integral dari CoC, kunjungan rumah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan layanan klinis dengan realitas harian pasien. Praktik ini memungkinkan bidan untuk mengobservasi kondisi ibu dan bayi secara autentik sekaligus memetakan sejauh mana dukungan keluarga berperan dalam proses penyembuhan. Dengan memahami situasi nyata di lapangan, bidan dapat memberikan bimbingan yang lebih relevan dan mendeteksi risiko kesehatan secara lebih proaktif sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius (Simmelink et al., 2025; Susanti et al., 2022).

B. Continuity of Care (CoC)

1. Definisi

Continuity of Care (CoC) merupakan pendekatan asuhan kebidanan holistik yang mengutamakan kebutuhan perempuan (*Woman-Centered Care*). Layanan ini diberikan secara berkelanjutan dan terpadu mencakup seluruh fase reproduksi, yaitu dimulai dari kehamilan, proses melahirkan, masa nifas, kesehatan bayi baru lahir, hingga program KB. Esensi dari model ini adalah

pendampingan oleh bidan yang sama atau tim yang terintegrasi guna memastikan konsistensi pelayanan (Bradford et al., 2022; Kemenkes RI, 2020).

Penerapan CoC yang efektif bersandar pada tiga pilar utama yang saling terintegrasi untuk menjamin kualitas asuhan. Pertama, aspek relasional menekankan pentingnya hubungan konsisten antara bidan dan ibu di sepanjang perjalanan kehamilan hingga masa nifas, yang secara bertahap membangun fondasi kepercayaan dan kenyamanan bagi pasien. Kedua, aspek informasi memastikan adanya transfer data klinis yang akurat dan tepat waktu antar-tenaga kesehatan melalui sistem dokumentasi yang terstruktur, seperti rekam medis dan Buku KIA, guna menghindari kesenjangan informasi. Terakhir, aspek manajemen menjamin terciptanya konsistensi dalam rencana asuhan, koordinasi lintas profesi yang solid, serta tindak lanjut yang jelas pada setiap tahapan reproduksi. Melalui sinergi ketiga dimensi ini, CoC tidak hanya menjadi sekadar rangkaian kunjungan medis, tetapi sebuah sistem pelayanan yang utuh, aman, dan berorientasi sepenuhnya pada kesejahteraan ibu dan bayi (WHO, 2024).

Menurut *World Health Organization* (WHO), *Continuity of Care* (CoC) diartikan sebagai penyediaan layanan kesehatan yang terkoordinasi secara berkelanjutan dan konsisten oleh tenaga medis yang saling terintegrasi. Dalam lingkup kebidanan, konsep ini diwujudkan melalui model *Midwifery-Led Continuity of Care* (MLCC). Pada model ini, bidan memegang peran sebagai pemberi asuhan utama (*lead carer*) yang memimpin serta bertanggung jawab penuh atas seluruh rangkaian proses asuhan pasien (Simmelink et al., 2025; WHO, 2024). Implementasi *Midwifery-Led Continuity of Care* (MLCC) telah terbukti secara empiris meningkatkan kualitas luaran maternal dan neonatal, yang ditandai dengan tingginya angka persalinan pervaginam spontan serta minimnya intervensi medis seperti operasi sesar. Selain manfaat klinis, model ini juga memberikan penguatan psikologis bagi ibu melalui hubungan interpersonal yang berbasis kepercayaan dengan bidan. Namun, upaya perluasan model ini secara global masih terbentur pada hambatan struktural, mulai dari keterbatasan anggaran dan SDM hingga dinamika kekuasaan di institusi kesehatan. Untuk mengatasinya, diperlukan kepemimpinan strategis dan kolaborasi interprofesional guna membangun ekosistem asuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Aricahyo et al., 2025; Simmelink et al., 2025).

Filosofi Asuhan: Model Midwifery-Led Continuity of Care

Filosofi dasar MLCC berpijak pada prinsip bahwa kehamilan dan persalinan adalah peristiwa fisiologis normal, bukan kondisi medis yang harus diintervensi secara berlebihan. Hubungan terapeutik jangka panjang yang dibangun antara bidan dan ibu menjadi fondasi utama model ini (Australian College of Midwives, 2017; Bradford et al., 2022; ICM, 2025).

Prinsip-Prinsip Filosofi MLCC (International Confederation of Midwives, 2021)

a. Partnership

Kemitraan yang setara antara bidan dan ibu, bukan relasi subordinat.

Holistic

Mempertimbangkan dimensi fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual ibu.

Informed Choice

Ibu dihormati haknya untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap.

Advocacy

Bidan bertindak sebagai advokat yang memperjuangkan hak dan kepentingan ibu.

Continuity

Konsistensi asuhan oleh bidan yang sama atau tim yang terkoordinasi.

Evidence-Based

Seluruh tindakan didasarkan pada bukti ilmiah terkini (best available evidence).

C. Tujuan

1. Tujuan Klinis

Dalam kerangka CoC, kunjungan rumah difokuskan pada pemantauan klinis yang komprehensif untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi (Bradford et al., 2022; Estiningtyas et al., 2025; Kemp et al., 2021). Prioritas utama meliputi:

a. Surveilans Maternal: Melakukan deteksi dini terhadap risiko komplikasi nifas, seperti perdarahan sekunder, pre-eklampsia *late-onset*, serta tanda-tanda infeksi seperti endometritis atau subinvolusi uterus.

Pemantauan Neonatal: Mengevaluasi kondisi bayi baru lahir secara rutin untuk mengantisipasi ikterus, infeksi tali pusat, gangguan respirasi, serta pemantauan ketat pada bayi dengan berat lahir rendah.

Penilaian Involusi Uterus: Mengobservasi proses pemulihan rahim melalui pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (TFU) dan karakteristik pengeluaran lochea.

Manajemen Laktasi: Melakukan skrining terhadap hambatan menyusui, termasuk teknik perlekatan yang salah, masalah pada puting, hingga penanganan mastitis.

Atensi Risiko Tinggi: Memberikan tindak lanjut spesifik bagi ibu yang memiliki riwayat risiko selama kehamilan atau persalinan, seperti pemantauan pasca-operasi sesar pada ibu dengan panggul sempit.

Tujuan Psikososial

Selain tujuan klinis, kunjungan rumah memiliki dampak psikososial yang signifikan (Eskandari et al., 2025; La Rosa et al., 2025):

a. Meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam merawat bayi baru lahir (*infant care confidence*).

Memfasilitasi proses bonding dan attachment antara ibu dan bayi.

Mendeteksi dini tanda-tanda baby blues syndrome dan risiko postpartum depression (*Edinburgh Postnatal Depression Scale/EPDS*) (Levis et al., 2020).

Memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada ibu, terutama pada ibu primipara atau ibu yang mengalami persalinan traumatik.

Melibatkan suami dan anggota keluarga dalam proses perawatan ibu dan bayi.

D. Efektivitas CoC Berdasarkan Riset Terbaru

Berbagai penelitian internasional telah membuktikan efektivitas model CoC dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

Penelitian / Sumber	Temuan Utama
Sandall et al. (2024)	- Wanita yang mendapatkan MLCC memiliki kemungkinan 16% lebih rendah untuk mengalami intervensi obstetrik yang tidak perlu, termasuk episiotomi dan induksi persalinan. - CoC berkontribusi terhadap penurunan 24% angka kematian perinatal dan 19% penurunan kelahiran prematur pada populasi risiko tinggi. - Data secara konsisten menunjukkan bahwa model CoC oleh bidan cenderung lebih hemat biaya atau setara jika dibandingkan dengan standar pelayanan medis biasa.
WHO (2024)	WHO menekankan bahwa CoC bukan hanya soal mencegah kematian, tetapi meningkatkan lebih dari 50 jenis hasil kesehatan lainnya, termasuk keberhasilan menyusui, imunisasi, hingga pencegahan depresi pascapersalinan.

Penelitian / Sumber	Temuan Utama
Fikre (2026)	- Tingkat kepuasan asuhan intrapartum mencapai 91,7% pada kelompok CoC, berbanding terbalik dengan kelompok kontrol yang hanya 49,4%. - Kontinuitas bidan berfungsi sebagai pereda kecemasan (anxiety reducer), yang berkontribusi pada penurunan angka depresi dan penguatan durasi menyusui. - Lebih dari 90% perempuan menginginkan konsistensi tenaga kesehatan (bidan yang sama) selama masa prenatal hingga persalinan.
Sholikah et al. (2025)	Penerapan CoC terbukti secara empiris tidak hanya memperbaiki luaran klinis, tetapi juga secara drastis meningkatkan kapasitas dan kemandirian keluarga dalam mendeteksi serta mencegah komplikasi pada kehamilan risiko tinggi

E. Indikasi dan Kotraindikasi Kunjungan Rumah

1. Indikasi Kunjungan Rumah

Kunjungan rumah dilakukan apabila terdapat kebutuhan klinis, psikologis, atau situasional yang memerlukan pemantauan di lingkungan domestik (Bradford et al., 2022; Kemenkes RI., 2021; Savolainen et al., 2026; WHO, 2022).

a. Asuhan Nifas Rutin (*Postnatal Care*): Memantau involusi uteri, pengeluaran lochea, dan penyembuhan luka perineum/SC pada ibu yang baru pulang dari fasilitas kesehatan.

Pemantauan Neonatus: Melakukan skrining awal pada bayi baru lahir, termasuk pemantauan ikterus (kuning), perawatan tali pusat, dan kecukupan asupan ASI.

Dukungan Laktasi: Membantu ibu yang mengalami kesulitan menyusui, seperti masalah perlekatan (*latch-on*), puting lecet, atau bendungan ASI yang memerlukan observasi langsung.

Kasus Risiko Tinggi: Tindak lanjut bagi ibu dengan riwayat komplikasi, seperti preeklampsia pascapersalinan, anemia berat, atau ibu dengan tinggi badan <145 cm yang memerlukan pengawasan ekstra setelah tindakan operatif.

Kesehatan Mental Maternal: Skrining depresi pascapersalinan (*postpartum blues* atau *postpartum depression*) pada ibu yang menunjukkan tanda-tanda gangguan emosional.

Hambatan Akses: Pasien yang memiliki keterbatasan transportasi, kendala ekonomi, atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bepergian ke puskesmas/klinik.

Penilaian Lingkungan: Perlu melihat secara langsung sanitasi, ketersediaan air bersih, dan dukungan keluarga yang memengaruhi pemulihan ibu dan tumbuh kembang bayi.

Berikut adalah kunjungan yang dianjurkan dalam pelayanan Kebidanan (Kemenkes RI., 2021).

a. Kunjungan Nifas (KF):

Kunjungan	Fokus Asuhan
KF-1 (6 jam – 3 hari)	Memastikan kondisi ibu stabil pasca persalinan, kontraksi uterus baik, tidak terjadi perdarahan, dan laktasi berjalan optimal.
KF-2 (4 – 28 hari)	Evaluasi involusi uterus, pemantauan lochea, skrining masalah menyusui, deteksi infeksi nifas.
KF-3 (29 – 42 hari)	Evaluasi pemulihan total, konseling KB, skrining depresi postpartum (EPDS), dan persiapan kembali beraktivitas.
KF-4 (43 – 60 hari)	Kunjungan tambahan untuk kasus risiko tinggi atau ibu yang membutuhkan tindak lanjut khusus, juga penentuan penggunaan KB.

Kunjungan Neonatal (KN)

Kunjungan	Fokus Asuhan
KN-1 (6 – 48 jam)	Pemeriksaan fisik lengkap BBL, edukasi perawatan tali pusat, verifikasi Vitamin K1, vaksin HB-0, dan skrining hipoglikemia.
KN-2 (3 – 7 hari)	Evaluasi berat badan (toleransi penurunan maks. 10%), pemantauan ikterus fisiologis, observasi pola menyusui.
KN-3 (8 – 28 hari)	Pemantauan pertumbuhan, evaluasi perkembangan refleks primitif, skrining masalah nutrisi dan tanda bahaya lanjutan.

Kontraindikasi Kunjungan Rumah

Kunjungan rumah tidak disarankan atau harus ditunda apabila terdapat kondisi yang memerlukan penanganan medis segera atau mengancam keselamatan (WHO, 2022).

- a. Kedaruratan Medis (*Red Flags*): Jika ibu atau bayi menunjukkan tanda bahaya akut (misalnya perdarahan hebat, kejang, sesak napas berat, atau demam tinggi $>38,5^{\circ}\text{C}$), pasien harus segera dirujuk ke Rumah Sakit, bukan menunggu kunjungan rumah.

Ketidakstabilan Hemodinamik: Pasien dengan tanda-tanda syok atau kondisi klinis yang memerlukan pemantauan alat medis berkelanjutan yang hanya tersedia di fasilitas kesehatan.

Risiko Keamanan Lingkungan: Area tempat tinggal yang sedang mengalami konflik, bencana alam, atau situasi yang mengancam keselamatan fisik tenaga kesehatan.

Penyakit Menular Akut tanpa APD Memadai: Jika di lingkungan rumah terdapat wabah penyakit menular berbahaya dan bidan tidak dilengkapi dengan prosedur proteksi yang sesuai standar.

Penolakan Pasien/Keluarga: Secara etika dan legal, kunjungan rumah tidak dapat dilakukan jika pasien secara sadar menolak asuhan tersebut (setelah diberikan penjelasan mengenai risikonya).

Red Flags: Kondisi yang Mengharuskan Rujukan Segera (BUKAN Kunjungan Rumah) (Bowen & Taylor, 2021)

a. Pada ibu: Perdarahan aktif >500 mL, demam >38,5°C disertai nyeri tekan perut, tekanan darah >160/110 mmHg, kejang, atau penurunan kesadaran.

Pada bayi: Sianosis sentral, frekuensi napas >60x/mnt atau apnea, tidak mau menyusu >8 jam, ikterus mencapai telapak tangan/kaki, atau suhu <36°C.

Kondisi lingkungan: Akses jalan yang tidak aman bagi tenaga kesehatan (daerah konflik, bencana, atau kondisi tidak memungkinkan keselamatan petugas).

Kondisi infeksius: Pasien dengan infeksi menular berbahaya yang belum terisolasi dengan baik (TB aktif belum terapi, COVID-19 aktif tanpa APD memadai).

F. Alat dan Bahan (Midwifery Home Visit Kit)

1. Peralatan Pemeriksaan Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.

Alat	Fungsi / Keterangan
Sphygmomanometer + stetoskop	Pemeriksaan tekanan darah ibu pada setiap kunjungan nifas. Pilih ukuran manset yang sesuai.
Doppler / fetoskop	Auskultasi DJJ jika diperlukan pemantauan pada kunjungan antenatal tambahan.
Termometer digital	Pengukuran suhu tubuh ibu (febris $>38^{\circ}\text{C}$ = tanda infeksi) dan bayi (hipotermi $<36,5^{\circ}\text{C}$).
Timbangan bayi digital	Pemantauan berat badan neonatus. Standar: penurunan BB maks. 10% dari BB lahir pada KN-1.
Pita ukur / infantometer	Pengukuran panjang badan bayi dan lingkaran kepala untuk skrining pertumbuhan.
Pita LILA (Lila meter)	Pengukuran Lingkaran Lengan Atas ibu untuk skrining malnutrisi pascanifas.
Lampu senter / pen light	Pemeriksaan sklera ikterus, konjungtiva anemia, dan pemeriksaan tali pusat.
Jam tangan / stopwatch	Menghitung frekuensi nadi, napas, dan menilai pola kontraksi.
Pulse Oximeter	Sangat penting untuk memantau saturasi oksigen bayi (skrining penyakit jantung bawaan atau gangguan napas) dan ibu (ibu dengan riwayat asma/anemia).

Bahan Habis Pakai

Bahan	Kegunaan
Sarung tangan steril + bersih	Sarung tangan steril untuk tindakan invasif (perawatan luka SC, pemeriksaan dalam). Sarung tangan bersih untuk pemeriksaan fisik rutin.
Kapas DTT + kasa steril	Untuk perawatan luka operasi, perawatan tali pusat, dan kompres puting.
Alkohol swab 70%	Desinfeksi permukaan alat dan kulit sebelum tindakan.

Bahan	Kegunaan
Cairan antiseptik (Povidone Iodine)	Perawatan luka episiotomi / laserasi yang belum sembuh sempurna dan perawatan tali pusat.
Plastik/kantong limbah medis	Pembuangan bahan habis pakai yang terkontaminasi (prinsip pencegahan infeksi).
Masker medis + apron	Perlindungan diri tenaga kesehatan, terutama pada tindakan dengan risiko paparan cairan tubuh.
Hand sanitizer 70% alkohol	Kebersihan tangan sebelum dan sesudah setiap pemeriksaan (5 momen cuci tangan WHO) (MacLeod et al., 2023).
Alat Cek Hemoglobin (Hb Sahli atau Digital)	Untuk memantau anemia pascapersalinan, terutama jika ibu mengalami perdarahan banyak saat melahirkan.
Alat Cek Protein Urine & Glukosa (Dipstick)	Sangat krusial jika ibu memiliki riwayat preeklampsia atau diabetes gestasional selama kehamilan, guna memantau kondisi ginjal dan kadar gula pascapersalinan.
Stetoskop Laennec (Fetoskop)	Sebagai cadangan jika Doppler digital habis baterai, karena fetoskop tidak bergantung pada daya listrik.

Media Edukasi

Media edukasi dalam kunjungan rumah berperan sebagai sarana komunikasi terapeutik sekaligus dokumentasi legal yang menghubungkan layanan profesional dengan kemandirian keluarga. Melalui kombinasi media cetak konvensional dan platform digital, bidan dapat memberikan asuhan yang lebih personal dan komprehensif (Mulyani et al., 2024). Daftar media edukasi pendukung dalam asuhan *Continuity of Care* (CoC) adalah sebagai berikut:

- a. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA), media komunikasi resmi antara pasien dan seluruh tenaga kesehatan.
- Lembar balik (flipchart), visualisasi tanda bahaya nifas, teknik menyusui yang benar, dan perawatan bayi.
- Leaflet, seperti tanda bahaya nifas dan neonatus, diberikan kepada keluarga untuk dijadikan referensi di rumah.

Media digital (smartphone/tablet), untuk demonstrasi video teknik menyusui, senam nifas, atau penggunaan aplikasi pemantauan tumbuh kembang berbasis KIA digital.

Formulir dokumentasi SOAP, lembar isian terstruktur untuk pencatatan hasil kunjungan rumah yang akan diintegrasikan ke dalam rekam medis.

G. Tahap Perencanaan Kunjungan Rumah

Perencanaan yang sistematis sebelum kunjungan rumah merupakan kunci keberhasilan asuhan. Perencanaan yang buruk dapat menyebabkan kunjungan tidak efisien, tidak fokus, dan berpotensi melewatkan masalah klinis yang kritis. Tanpa perencanaan yang matang (seperti meninjau catatan medis sebelumnya dan menyiapkan alat yang sesuai), kunjungan rumah berisiko menjadi tidak fokus dan gagal mendeteksi tanda bahaya klinis yang halus pada ibu dan bayi (WHO, 2022). Perencanaan yang buruk mengakibatkan rendahnya keterlibatan keluarga. Sebaliknya, kunjungan yang direncanakan dengan modul edukasi yang sistematis terbukti meningkatkan skor kesiapan keluarga hingga lebih dari 100% (Sholikhah et al., 2025).

1. Skrining dan Telaah Data (*Data Review*)

Sebelum kunjungan, bidan wajib melakukan telaah menyeluruh terhadap:

- a. Catatan persalinan: jenis persalinan (spontan/SC), komplikasi intrapartum, kondisi bayi lahir (APGAR skor), dan tindakan yang diberikan.

Kondisi klinis terakhir yang tercatat di fasilitas: tekanan darah, Hb, kondisi luka operasi/episiotomi, kemajuan laktasi.

Faktor risiko yang teridentifikasi selama kehamilan dan perlu dipantau berlanjut pascanifas.

Riwayat kunjungan sebelumnya: masalah yang ditemukan dan intervensi yang telah diberikan.

Data sosial-keluarga: dukungan suami/keluarga, kondisi rumah, akses ke fasilitas kesehatan.

Komunikasi Awal dengan Keluarga

Komunikasi awal sebelum kunjungan bertujuan untuk (Kemenkes RI, 2020; Wolff et al., 2015):

- a. Memastikan kesiapan keluarga menerima kunjungan (waktu, kondisi, dan keberadaan pendamping dewasa).

Memberitahukan tujuan kunjungan agar keluarga dapat mempersiapkan diri dan dokumen yang diperlukan (Buku KIA, hasil lab, dll).

Menggali keluhan atau kekhawatiran awal yang akan menjadi prioritas pada saat kunjungan.

Menyepakati waktu kunjungan yang tidak mengganggu waktu istirahat ibu dan bayi.

Tips Komunikasi Efektif Sebelum Kunjungan

- a. Gunakan bahasa yang sederhana dan ramah, hindari istilah medis yang membingungkan keluarga.

Konfirmasi alamat lengkap dan tandai rute sebelum hari kunjungan untuk efisiensi waktu.

Tanyakan secara langsung: "Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau ceritakan sebelum saya datang?"

Jika menggunakan media sosial/WA, simpan komunikasi sebagai bukti koordinasi.

Manajemen Logistik

Kesiapan logistik adalah kunci profesionalisme bidan dalam memberikan asuhan berkelanjutan (*Continuity of Care*). Manajemen logistik yang terencana dengan baik tidak hanya mencakup kelengkapan alat kesehatan, tetapi juga manajemen waktu dan perlindungan diri tenaga kesehatan (Kamlem & Mercer, 2025; Salsabila et al., 2024). Elemen penting dalam persiapan logistik kunjungan rumah adalah:

- a. Persiapkan Midwifery Kit (alat dan bahan) satu hari sebelum kunjungan dan cek kelengkapannya dengan daftar periksa (checklist).

Pastikan semua alat dalam kondisi baik dan terkalibrasi (terutama sphygmomanometer dan timbangan).

Rencanakan rute kunjungan yang efisien jika terdapat lebih dari satu kunjungan dalam satu hari, dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi jalan.

Siapkan APD (masker, sarung tangan, hand sanitizer) sebelum berangkat.

Pastikan baterai/daya alat digital (Doppler, termometer digital) terisi penuh.

Penyusunan Rencana Asuhan (Care Plan)

Rencana asuhan yang efektif harus mencakup elemen-elemen berikut:

- a. Tujuan Kunjungan (Spesifik): Menetapkan fokus utama, misalnya: "Memastikan involusi uteri berjalan normal" atau "Mengevaluasi teknik menyusui pada ibu dengan puting datar."

Intervensi Klinis (Tindakan): Daftar pemeriksaan fisik yang akan dilakukan (TTV, pemeriksaan payudara, fundus, lokhea, dan luka jahitan).

Target Edukasi (Promosi Kesehatan): Topik yang paling relevan dengan kondisi ibu saat itu (nutrisi nifas, higiene perineum, atau tanda bahaya pada bayi).

Manajemen Risiko: Rencana tindakan jika ditemukan *red flags* (misalnya: rujukan segera ke RS jika tekanan darah >140/90 mmHg).

Adapun langkah-langkah penyusunan rencana (Fase Pra-Kunjungan) ialah (Australian College of Midwives, 2017; Sandall et al., 2024; Simmelink et al., 2025):

Tahapan	Aktivitas
Prioritas Masalah	Menentukan masalah utama dari rekam medis (contoh: ibu anemia, bayi BBLR).
Persiapan Logistik	Memastikan alat yang dibawa sesuai dengan kebutuhan spesifik (contoh: membawa timbangan digital ekstra akurat untuk bayi kecil).
Penjadwalan	Mengonfirmasi waktu kunjungan agar tidak berbenturan dengan waktu istirahat ibu atau jadwal imunisasi di puskesmas.
Koordinasi Tim	Jika kasus risiko tinggi, merencanakan apakah perlu didampingi oleh kader kesehatan atau tenaga medis lain.

H. Tahap Pelaksanaan Kunjungan Rumah

1. Persiapan Pasien dan Lingkungan

Setelah tiba di rumah pasien, lakukan persiapan sebelum memulai pemeriksaan:

- a. Ucapkan salam dan lakukan perkenalan kepada seluruh anggota keluarga yang hadir.

Jelaskan tujuan dan prosedur kunjungan secara singkat kepada ibu dan keluarga (informed consent verbal).

Siapkan area pemeriksaan yang cukup cahaya, bersih, hangat (untuk bayi), dan menjamin privasi ibu.

Pastikan tersedia tempat yang aman untuk meletakkan bayi selama pemeriksaan (misalnya: kasur yang rata dengan pengaman di sisi, atau alas bermain).

Cuci tangan 6 langkah WHO selama minimal 20 detik sebelum dan sesudah setiap pemeriksaan.

Langkah Prosedur Klinis

- a. Pengkajian Fisik Ibu (Maternal Assessment) (Bowen & Taylor, 2021; Kemenkes RI, 2021; WHO, 2022)

- 1 Anamnesis** Tanyakan keluhan subyektif: nyeri, perdarahan, demam, gangguan berkemih/BAB, masalah menyusui, kondisi psikologis, kualitas tidur, dan nafsu makan.
- 2 Tanda Vital** Ukur tekanan darah, nadi, suhu, dan frekuensi napas. Catat dan bandingkan dengan hasil kunjungan sebelumnya.

- 3 **Pemeriksaan Payudara** Inspeksi dan palpasi payudara: apakah ada bengkak, nyeri, puting lecet, tanda mastitis (kemerahan, hangat, keras). Observasi proses menyusui secara langsung.
- 4 **Pemeriksaan Abdomen** Palpasi tinggi fundus uteri (TFU). Bandingkan dengan standar involusi. Nilai nyeri tekan suprapubik (tanda infeksi).
- 5 **Observasi Lokhea** Tanyakan dan nilai karakteristik lokhea: warna, jumlah, bau. Lokhea berbau busuk = tanda endometritis → rujuk.
- 6 **Pemeriksaan Perineum/Luka** Inspeksi luka episiotomi atau insisi SC: kebersihan, tanda infeksi (REEDA: Redness, Edema, Ecchymosis, Discharge, Approximation). Lakukan perawatan luka jika diperlukan.
- 7 **Pemeriksaan Tungkai** Inspeksi varises dan edema. Palpasi betis untuk tanda Homan (nyeri tekan = risiko DVT). Kaji mobilisasi ibu.
- 8 **Skrining Psikologis** Terapkan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) jika kunjungan $\geq$ hari ke-7. Skor $\geq$ 13 = risiko tinggi depresi postpartum → konseling + rujukan psikiatri/psikolog.

Pengkajian Fisik Neonatus (Neonatal Assessment) (Bowen & Taylor, 2021; Kemenkes RI, 2021; WHO, 2022)

1	Observasi Umum Nilai kesadaran, warna kulit (ikterus, sianosis, pucat), aktivitas, tangis, dan tonus otot bayi.
2	Tanda Vital Bayi Ukur suhu aksila (normal: 36,5–37,5°C), hitung frekuensi napas (normal: 40–60x/mnt) dan nadi apikal (normal: 120–160x/mnt).
3	Pemeriksaan Berat Badan Timbang bayi. Hitung persentase penurunan BB dari lahir. Jika $>10\%$ dari BB lahir tanpa pemulihan = patologis → evaluasi asupan.
4	Pemeriksaan Kepala-Muka Nilai fontanel (normal: datar dan teraba lembut), sklera ikterus, konjungtiva, dan refleks hisap (suckling reflex).
5	Pemeriksaan Tali Pusat Nilai tali pusat: bersih, kering, tidak berbau, tidak berdarah. Edukasi cara perawatan: bersih dan kering tanpa diberi apapun.
6	Pemeriksaan Kulit Nilai ikterus menggunakan Kramer Zone (zona 1–5). Zona $\geq$ 3 (ikterus mencapai perut ke bawah) → evaluasi bilirubin → rujuk jika perlu.

7	Pemeriksaan Neurologis Nilai refleks primitif: Moro, rooting, sucking, grasp, Babinski. Absennya refleks ini mengindikasikan kelainan neurologis.
8	Observasi Menyusui Minta ibu untuk menyusui dan observasi: posisi tubuh ibu, posisi mulut bayi (latch-on), isapan aktif, transfer ASI, dan kenyamanan ibu.

Observasi Interaksi Ibu-Bayi dan Dukungan Keluarga (Bowen & Taylor, 2021; Kemenkes RI, 2021; WHO, 2022)

Selama kunjungan, bidan juga berperan sebagai observer aktif terhadap:

- 1) Kualitas bonding: apakah ibu merespons tangis/sinyal bayi dengan cepat dan penuh kasih sayang.
- 2) Dukungan suami/keluarga: siapa yang membantu perawatan bayi, apakah ada konflik peran dalam keluarga.
- 3) Kondisi fisik rumah: kebersihan, ventilasi, ketersediaan air bersih, dan fasilitas dasar yang mendukung perawatan ibu-bayi.
- 4) Keyakinan atau praktik tradisional: identifikasi praktik yang berbahaya (misalnya: memberikan madu pada bayi newborn, mengurut perut ibu secara kasar) dan berikan edukasi yang sensitif budaya.

Pemberian KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

KIE di rumah memiliki keunggulan dibanding di fasilitas kesehatan karena dapat disesuaikan langsung dengan kondisi dan kebutuhan spesifik keluarga (Sari et al., 2025). Prinsip KIE efektif di rumah:

- 1) Gunakan bahasa lokal yang dimengerti dan hindari jargon medis.
- 2) Demonstrasikan secara langsung (*show, don't just tell*): praktikkan cara menyusui, perawatan tali pusat, atau cara memandikan bayi secara langsung bersama ibu.
- 3) Libatkan suami dan anggota keluarga yang tinggal serumah sebagai mitra edukasi.
- 4) Berikan materi edukasi tertulis (leaflet, poster, booklet, dll) yang dapat dibaca kembali setelah bidan meninggalkan rumah.
- 5) Pastikan ibu dapat mengulang kembali instruksi (*teach-back method*) (Cheng et al., 2023): "Coba Ibu ceritakan ulang, apa yang harus dilakukan jika bayi terlihat kuning sampai perut?"

Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Menjamin keselamatan ibu dan bayi adalah prioritas utama dalam setiap tahapan kunjungan rumah. Untuk mewujudkan asuhan yang aman dan berkualitas di luar fasilitas kesehatan, bidan harus mengintegrasikan prinsip *patient safety* berikut ke dalam setiap langkah prosedur klinis yang dilakukan (Al-Worafi, 2023; Disik et al., 2025; Kemenkes RI, 2022).

Prinsip Keselamatan Pasien dalam Kunjungan Rumah (Reynard et al., 2026)

- 1) Pencegahan Infeksi Silang: Prinsip 5 Momen Cuci Tangan WHO wajib diterapkan; alat yang digunakan untuk satu pasien tidak boleh langsung digunakan pada pasien lain tanpa dekontaminasi.
- 2) Keamanan Bayi saat Pemeriksaan: Bayi tidak boleh ditinggalkan sendirian di permukaan tinggi; selalu ada satu tangan menyangga bayi saat pemeriksaan berlangsung.
- 3) Identifikasi Pasien: Konfirmasi identitas ibu dan bayi (nama, tanggal lahir, nomor KIA) sebelum setiap tindakan untuk mencegah kesalahan identifikasi.
- 4) Komunikasi Efektif (SBAR): Gunakan teknik SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) saat melaporkan temuan klinis kepada dokter/supervisor (Kosim & Saimi, 2025).

Pelaporan Insiden: Setiap kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian nyaris cedera (KNC) selama kunjungan rumah wajib dilaporkan ke fasilitas kesehatan sesuai prosedur.

I. Tahap Evaluasi Kunjungan Rumah

1. Evaluasi Hasil Asuhan (*Outcome Evaluation*)

Setelah seluruh pengkajian dan intervensi selesai, bidan melakukan evaluasi terhadap (Kemenkes RI, 2021; WHO, 2022):

Parameter Evaluasi	Kriteria Hasil Normal
Kontraksi Uterus	Uterus teraba keras dan bulat → involusi berjalan baik. Jika lembek/atoni → massage uterus, rujuk jika tidak membaik.
Perdarahan Nifas	Lokhea sesuai tahap (rubra hari 1–3, serosa hari 4–9, alba hari 10–dst). Perdarahan >500 mL = PPH → rujuk segera.
Berat Badan Bayi	Bayi kembali ke BB lahir pada hari ke-10–14. Kenaikan minimal 20–30 gram/hari setelah hari ke-5 menandakan asupan ASI adekuat.
Teknik Menyusui	Ibu mampu mendemonstrasikan posisi dan perlekatan yang benar secara mandiri. Bayi menyusu 8–12x per hari.
Tali Pusat	Tali pusat kering, tidak berbau, tidak kemerahan → proses normal. Puput tali pusat biasanya terjadi hari ke-7–10.
Kondisi Psikologis	Tidak ada tanda depresi postpartum (EPDS <10), ibu mampu merawat bayi, ada dukungan keluarga yang adekuat.
Pemahaman Tanda Bahaya	Ibu dan keluarga dapat menyebutkan minimal 3 tanda bahaya nifas dan neonatus serta tahu tindakan yang harus diambil.

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi, bidan menentukan salah satu dari tiga keputusan (Kemenkes RI, 2021; WHO, 2022):

- Laksanakan asuhan rutin sesuai protokol jika tidak ditemukan penyimpangan klinis; pastikan penjadwalan kunjungan ulang telah terkonfirmasi dan terdokumentasi dalam Buku KIA sesuai dengan standar minimal kunjungan rumah (KF-2, KN-2, dll).

Tingkatkan frekuensi pemantauan melalui kunjungan rumah tambahan jika terdapat indikasi klinis yang memerlukan observasi ketat namun masih dalam batas kewenangan bidan; mencakup evaluasi asupan nutrisi bayi, perawatan luka perineum/SC yang suboptimal, serta intervensi laktasi berkelanjutan.

Rujuk segera jika ditemukan komplikasi; gunakan komunikasi SBAR dan lengkapi dokumen rujukan (P-Care/SP2TP) demi keselamatan pasien.

Kriteria Keberhasilan CoC Secara Keseluruhan

- 1) Ibu dan bayi selamat, sehat, dan tidak ada komplikasi berat yang tidak terdeteksi.
- 2) Proses menyusui eksklusif berjalan optimal hingga minimal 6 bulan.
- 3) Ibu telah mendapatkan dan menggunakan metode KB yang sesuai.
- 4) Ibu memiliki kemampuan merawat bayi secara mandiri dan percaya diri.
- 5) Seluruh kunjungan (KF 1–3 dan KN 1–3) telah terlaksana dan terdokumentasi di Buku KIA.

Tidak ada keluhan depresi postpartum yang tidak tertangani.

J. Dokumentasi Asuhan Kunjungan Rumah

1. Prinsip Dokumentasi dalam CoC

Dokumentasi adalah bukti hukum (*legal evidence*) dari setiap asuhan yang diberikan. Dalam CoC, dokumentasi berfungsi sebagai benang merah yang menghubungkan setiap episode asuhan dari kehamilan hingga KB. Dokumentasi yang buruk bukan hanya masalah administrasi namun dapat membahayakan keselamatan pasien karena menyebabkan putusnya informasi antar-tenaga kesehatan (Australian College of Midwives, 2017; Bocanegra et al., 2018; Demsash et al., 2023).

Prinsip	Penjelasan
Tepat Waktu	Dokumentasi dilakukan segera setelah kunjungan (maks. 2 jam), bukan direkonstruksi keesokan harinya karena berisiko kehilangan data penting.
Akurat & Objektif	Catat apa yang diperiksa dan ditemukan, bukan interpretasi atau asumsi. Gunakan satuan ukur yang jelas (TFU 2 jari bawah pusat, bukan "sudah turun").
Lengkap	Setiap komponen SOAP harus terisi. Kolom yang kosong menandakan asuhan yang tidak dilakukan atau tidak dicatat.
Terbaca Jelas	Tulisan tangan harus jelas dan tidak ambigu. Koreksi kesalahan dengan satu garis lurus, beri paraf, dan tulis koreksi di sampingnya (jangan dihapus/dicoret habis).
Teridentifikasi	Setiap entri dokumentasi harus dilengkapi: nama bidan, tanggal, jam, dan tanda tangan/paraf sebagai pertanggungjawaban hukum.
Rahasia	Dokumentasi pasien bersifat konfidensial dan hanya boleh diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Tidak boleh dibagikan ke media sosial dalam bentuk apapun.

Format Dokumentasi SOAP untuk Kunjungan Rumah

Format Dokumentasi umumnya menggunakan format yang sudah disediakan di klinik atau Puskesmas. Berikut adalah salah satu contoh format SOAP untuk Kunjungan Rumah (Podder et al., 2023):

FORMAT DOKUMENTASI SOAP KUNJUNGAN RUMAH NIFAS & NEONATUS	
Tanggal/Jam Kunjungan: _____ Kunjungan ke: _____ Usia Nifas: _____ hari Usia Neonatus: _____ hari Nama Ibu : _____ Nama Bayi : _____ No. Buku KIA : _____	
S	SUBJEKTIF: Data yang diperoleh dari anamnesis (keluhan utama dan keluhan tambahan ibu) IBU: Keluhan utama: _____ Pola makan: _____ Pola istirahat: _____ Perdarahan: _____ BAK/BAB: _____ Nyeri perineum/luka SC: _____ Produksi ASI: _____ Masalah menyusui: _____ Kondisi emosional: _____ BAYI: Pola menyusui: _____ BAK $\geq$ 6x/hari: _____ BAB: _____ Tangis: _____ Aktivitas: _____
O	OBJEKTIF: Data hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang IBU: TD: ____/____ mmHg N: ____x/mnt S: ____°C RR: ____x/mnt TFU: _____ Lokhea: _____ Payudara: _____ Perineum/Luka: _____ Edema: _____ EPDS: _____ BAYI: BB: ____ gram S: ____°C RR: ____x/mnt N: ____x/mnt Warna kulit: _____ Ikterus zona: _____ Tali pusat: _____ Refleks: Moro ____ Rooting ____ Sucking ____ Observasi menyusui: _____
A	ANALISIS: Diagnosa kebidanan dan identifikasi masalah/kebutuhan Diagnosa Ibu: Ny. ____ usia ____ tahun P____A____ hari ke-____ postpartum, kondisi: _____ Diagnosa Bayi: By. Ny. ____ neonatus hari ke-____, kondisi: _____ Masalah: _____ Kebutuhan: _____
P	PENATALAKSANAAN: Rencana dan tindakan yang telah dilakukan beserta evaluasinya 1. _____ (Evaluasi: _____) 2. _____ (Evaluasi: _____) 3. _____ (Evaluasi: _____) 4. _____ (Evaluasi: _____)

FORMAT DOKUMENTASI SOAP KUNJUNGAN RUMAH NIFAS & NEONATUS	
	5. _____ (Evaluasi: _____) Rencana Tindak Lanjut: _____ Jadwal Kunjungan Berikutnya: _____ Bidan Pelaksana: _____ Tanda Tangan: _____

Pengisian Buku KIA sebagai Media Dokumentasi Legal

Buku KIA adalah dokumen resmi milik keluarga yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pasien dan semua tenaga kesehatan yang merawatnya (Kemenkes RI, 2021; WHO, 2022). Setiap kunjungan rumah wajib dicatat di Buku KIA dengan:

- a. Mencantumkan tanggal, temuan klinis ringkas, dan paraf bidan pada halaman kunjungan nifas dan neonatal.

Memperbarui grafik pertumbuhan bayi (berat badan, panjang badan, lingkaran kepala) pada halaman KMS Bayi.

Memberikan stempel puskesmas/klinik jika kunjungan dilakukan atas nama fasilitas kesehatan.

Menginformasikan kepada keluarga bahwa Buku KIA harus dibawa pada setiap kunjungan ke fasilitas kesehatan, posyandu, maupun kunjungan bidan berikutnya.

Integrasi Data ke Rekam Medis CoC

Seluruh data hasil kunjungan rumah harus diintegrasikan ke dalam rekam medis CoC yang tersimpan di fasilitas kesehatan, baik secara manual (P-Care Puskesmas, formulir asuhan kebidanan) maupun digital (Kemenkes RI, 2021; WHO, 2022). Integrasi ini penting untuk:

- a. Memastikan kesinambungan informasi saat terjadi handover (pergantian bidan penanggung jawab).

Menyediakan data audit mutu layanan dan evaluasi program CoC di institusi.

Menjadi dokumen pendukung klaim JKN/BPJS jika pelayanan kunjungan rumah masuk dalam paket layanan yang ditanggung.

Melindungi bidan secara hukum jika di kemudian hari timbul perselisihan atau kasus medikolegal.

K. Aktivitas 1: *Knows How*

Skenario Kasus

Seorang perempuan usia 22 tahun, G1P1A0, melahirkan secara sectio caesarea (SC) atas indikasi cephalopelvic disproportion (CPD) 3 hari yang lalu di RSUD Kabupaten Mamuju. Ibu dipulangkan kemarin dengan kondisi umum baik, luka operasi kering, dan bayi lahir cukup bulan dengan berat badan 3.050 gram, APGAR skor 8/9.

Hari ini adalah hari ke-3 pascapersalinan. Bidan Ratna, penanggung jawab program CoC di Puskesmas Topore, melakukan kunjungan rumah pertama (KF-1/KN-1). Dari catatan buku KIA dan resume keluar RS, diketahui bahwa ibu memiliki tinggi badan 144 cm, LILA 22 cm, Hb pra-operasi 9,8 g/dL, dan tekanan darah intraoperatif sempat turun ke 90/60 mmHg namun stabil sebelum dipulangkan.

Saat kunjungan, Bidan Ratna mendapati kondisi berikut: ibu tampak lelah dan pucat, mengeluh nyeri pada luka operasi (skala 5/10), dan belum bisa duduk tegak sehingga menyusui sambil berbaring. ASI sudah keluar namun ibu merasa produksinya "kurang" karena bayi sering rewel dan menangis. Ibu juga mengaku khawatir karena mertua menyarankan untuk memberikan air putih pada bayi agar tidak kehausan. Suami bekerja di luar kota dan baru bisa pulang 2 minggu lagi.

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Bidan Ratna: keadaan umum cukup, kesadaran kompos mentis. Tanda vital: TD 100/70 mmHg, nadi 88 x/menit, suhu 37,8°C, respirasi 20 x/menit. TFU teraba 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus cukup baik, lochea rubra, jumlah sedang, tidak berbau. Luka operasi SC tampak bersih, tidak ada tanda-tanda infeksi (REEDA negatif), balutan masih utuh. Konjungtiva tampak sedikit pucat. Tungkai tidak edema, tanda Homan negatif.

Pemeriksaan neonatus: bayi tampak aktif, menangis kuat, warna kulit kemerahan, suhu aksila 36,8°C, frekuensi napas 48 x/menit. Berat badan hari ini 2.970 gram (turun 80 gram dari BB lahir 3.050 gram). Tali pusat tampak lembab, dibungkus kain oleh nenek dengan alasan "biar hangat". Refleks hisap baik. Saat diobservasi menyusui, terlihat posisi perlekatan kurang optimal: hanya puting yang masuk ke mulut bayi (tidak sampai areola).

Kondisi rumah: ruangan bersih, ventilasi cukup, tersedia air bersih. Namun nenek tampak mendominasi pengambilan keputusan perawatan bayi, sementara ibu terlihat pasif dan kurang percaya diri.

Pertanyaan diskusi:

1. Apakah kunjungan Bidan Ratna hari ini sudah tepat waktu dan tepat sasaran sebagai bagian dari model Midwifery-Led Continuity of Care (MLCC)? Sebutkan data dalam kasus yang menjadi dasar pertimbangan Bidan Ratna dalam menetapkan prioritas asuhan pada kunjungan ini.

Dari hasil pemeriksaan ibu, identifikasi seluruh masalah dan risiko yang ditemukan pada kasus ini. Kelompokkan temuan tersebut berdasarkan tingkat urgensi: (a) masalah yang memerlukan tindakan segera, (b) masalah yang memerlukan pemantauan ketat, dan (c) masalah yang memerlukan edukasi dan tindak lanjut rutin.

Temuan suhu 37,8°C pada ibu pascasc hari ke-3 perlu dianalisis secara kritis. Apakah ini termasuk demam yang memerlukan tindakan segera, ataukah masih dalam batas normal fisiologis? Jelaskan dasar teori Anda, dan tindakan apa yang harus dilakukan Bidan Ratna berdasarkan temuan ini?

Berat badan bayi turun 80 gram (dari 3.050 gram menjadi 2.970 gram) pada hari ke-3 pascalahir. Berdasarkan standar yang berlaku, apakah penurunan ini masih dalam batas yang dapat diterima (acceptable weight loss) atau sudah melewati batas patologis? Apa hubungannya dengan temuan perlekatan menyusui yang tidak optimal pada kasus ini, dan apa intervensi bidan yang paling prioritas?

Nenek menyarankan untuk memberikan air putih pada bayi, dan tali pusat dibungkus kain. Kedua praktik ini merupakan kepercayaan turun-temurun dalam keluarga tersebut. Bagaimana pendekatan komunikasi yang tepat bagi Bidan Ratna dalam menyikapi situasi ini (antara menghormati budaya keluarga sekaligus melindungi keselamatan bayi)? Gunakan prinsip KIE berbasis bukti dan pendekatan sensitif budaya dalam jawaban Anda.

Susunlah rencana asuhan lengkap (Planning CoC) untuk kunjungan hari ini dan kunjungan berikutnya. Rencana Anda harus mencakup: (a) tindakan yang dilakukan hari ini beserta rasionalisasinya, (b) KIE yang diberikan kepada ibu dan keluarga, (c) jadwal kunjungan berikutnya dengan fokus asuhan yang spesifik, dan (d) kriteria kapan ibu/bayi harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.

Bagaimana Bidan Ratna mendokumentasikan seluruh temuan dan asuhan kunjungan hari ini menggunakan format SOAP? Tuliskan dokumentasi SOAP lengkap untuk kasus ini. Pastikan setiap komponen (Subjektif, Objektif, Analisis, Penatalaksanaan) terisi secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

L. Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	3
2	Judul	Nifas: Kunjungan Rumah (Deteksi Dini)
3	Kasus	Kunjungan rumah pada ibu nifas hari ke-5 (KF 2) dengan masalah bendungan ASI dan kecemasan laktasi.
4	Tujuan	Menilai kemampuan peserta dalam merencanakan asuhan, melakukan pemeriksaan fisik di rumah, memberikan edukasi pemberdayaan keluarga, dan dokumentasi CoC.
5	Kompetensi	1. Anamnesis terarah, 2. Pemeriksaan fisik terfokus, 3. Perumusan diagnosis, 4. Prosedur tindakan klinis (Manajemen laktasi), 5. KIE/Konseling kemandirian keluarga, 6. Perilaku profesional.
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO: Seorang perempuan, usia 26 tahun, P1A0, nifas hari ke-5, dikunjungi bidan di rumahnya. Hasil persalinan normal di PKM. Kedua payudara terasa bengkak, keras, dan nyeri sejak kemarin. Ibu merasa ASI-nya kurang karena bayi sering menangis, sehingga ibu tampak cemas dan lelah. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian subjektif (anamnesis) terkait keluhan dan dukungan keluarga. 2. Lakukan pemeriksaan fisik terfokus (Payudara, TFU, Lokhea). 3. Sampaikan diagnosis/masalah yang ditemukan. 4. Lakukan tindakan awal manajemen laktasi (posisi menyusui/kompres). 5. Berikan edukasi kemandirian kepada ibu dan anggota keluarga yang ada.
7	Instruksi Penguji	INSTRUKSI UMUM: 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian.

No.	Komponen	Isi
		2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: • Actual mark (0/1/2/3) • Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE.

INSTRUKSI KHUSUS:

1. Jika peserta meninjau rekam medis (perencanaan), beri data: Persalinan spontan, perdarahan normal, bayi lahir 3100 gr.
2. Data Palpasi Payudara: Bengkak (+), nyeri tekan (+), mengkilap (+), ASI keluar sedikit.
3. Data TFU: 3 jari bawah pusat, kontraksi keras.
4. Data Lokhea: Sanguinolenta (merah kecokelatan), bau khas.
5. Tanda Vital: TD 110/70 mmHg, Nadi 88x/m, S 37,7°C.
6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
7. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai.

INSTRUKSI TAMBAHAN

1. Rapikan kembali tas bidan dan pastikan semua alat (tensimeter, stetoskop, termometer) berada di tempat semula sesuai kompartemen tas.

No.	Komponen	Isi
		2. Tarik lembar dokumentasi/Buku KIA yang telah diisi peserta sebelumnya, pastikan identitasnya jelas, dan ganti dengan lembar baru yang bersih. 3. Pastikan ketersediaan <i>handrub</i> dan tisu cukup untuk peserta berikutnya.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	INSTRUKSI PS: 1. Peran: Ibu nifas tampak cemas, sesekali memegang payudaranya. 2. Sikap: Kooperatif namun bertanya dengan nada khawatir: <i>"Bu Bidan, kenapa payudara saya sakit sekali dan ASI saya sedikit? Apa bayi saya kelaparan?"</i> 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 4. Bila peserta memeragakan cara perawatan payudara atau cara memerah ASI. PS dapat mempraktikkan ulang
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Ibu. Saya Bidan [Nama], sesuai janji kita kemarin, saya datang untuk melakukan kunjungan nifas hari ke-5. Apakah Ibu bersedia diperiksa? PS: Iya, Bu Bidan, silakan masuk. Saya bersedia. Peserta: Bagaimana kabar Ibu hari ini? Apa ada keluhan utama yang dirasakan? PS: (Tampak cemas dan memegang payudara) Aduh Bu, payudara saya sakit sekali, bengkak dan keras dari kemarin sore. Rasanya nyut-nyutan. Peserta: Sejak kapan payudara mulai terasa bengkak dan keras seperti ini? PS: Mulai terasa sekali sejak kemarin sore, Bu. Makin lama makin keras dan nyeri kalau tersenggol. Peserta: Bagaimana dengan pengeluaran ASI-nya? Apakah lancar saat menyusui? PS: Itu dia Bu, kayaknya ASI saya sedikit sekali, nggak keluar lancar. Bayi saya nangis terus, apa bayi saya kelaparan ya Bu? Saya takut dia nggak cukup minum.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Apakah Ibu sudah mencoba melakukan sesuatu untuk mengurangi nyerinya? PS: Belum saya apa-apakan Bu, saya takut salah pencet malah tambah sakit. Jadi saya biarkan saja. Peserta: Ibu sudah mencoba memerah ASI atau tetap menyusui meskipun sakit? PS: Tetap saya kasih ke bayi Bu, tapi bayi kayak susah ngenyotnya karena payudara saya keras banget. Akhirnya dia nangis, saya jadi makin stres. Peserta: Bagaimana dengan istirahat dan makan Ibu akhir-akhir ini? PS: Makan sih doyan Bu, tapi saya kurang tidur. Semalam hampir nggak tidur karena payudara sakit dan bayi rewel terus. Peserta: Apakah Ibu merasa demam atau menggigil? PS: Badan rasanya meriang Bu, sumeng-sumeng gitu, tapi nggak sampai menggigil hebat. Peserta: Apakah ada keluhan lain seperti pusing hebat atau perdarahan yang banyak? PS: Nggak ada Bu, cuma payudara ini saja yang bikin saya kepikiran. Peserta: Ibu, payudara Ibu mengalami bendungan ASI karena pengosongan yang kurang maksimal. Saya akan bantu ajarkan cara kompres dan posisi menyusui yang benar supaya ASI lancar dan nyeri berkurang. PS: Oh gitu ya Bu... Baik Bu Bidan, tolong bantu saya ya, saya kasihan sama bayi saya kalau dia nggak kenyang. Peserta: (Sambil memeragakan) Nanti Ibu bisa lakukan kompres hangat seperti ini ya, lalu posisikan bayi mulutnya terbuka lebar menutupi bagian hitam payudara. PS: (Mempraktikkan ulang gerakan/posisi) Jadi posisinya harus nempel banget ya Bu? Kalau saya kompres pakai air hangat sesering mungkin boleh ya?

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Iya Bu, benar. Saya akan bantu siapkan alatnya dan periksa kondisi Ibu lebih lanjut. PS: Iya, Bu, terima kasih banyak ya Bu Bidan.
10	Kebutuhan manikin	• Phantom payudara (untuk simulasi perawatan/kompres/perah ASI) • Phantom abdomen untuk pemeriksaan TFU/involusia uterus • Phantom vulva untuk pemeriksaan lochea dan luka perineum. • Manikin bayi (untuk posisi menyusui).
11	Kebutuhan laboran	Menyiapkan tas bidan, merapikan alas periksa di tempat tidur pasien, memastikan buku KIA tersedia, dan memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan Alat	1. Tas Bidan lengkap (Tensimeter, Termometer, Metline). 2. Sarung tangan bersih & Handrub/ hand sanitizer. 3. Baskom berisi air hangat & waslap. 4. Leaflet/Lembar balik laktasi. 5. Buku KIA & Alat tulis.
13	Penulis	
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). <i>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual</i>. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2. World Health Organization. (2022). <i>WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience</i>. World Health Organization. 3. Kemenkes RI. (2021). <i>Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)</i>. Gizi KIA Kemenkes RI. 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 3: Kunjungan Rumah Nifas (KF 2)

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama (fokus pada payudara/laktasi)		
2. Riwayat persalinan (jenis persalinan, komplikasi, tempat lahir)		
3. Pola nutrisi dan hidrasi ibu		
4. Pola eliminasi (BAK dan BAB pascapersalinan)		
5. Pola istirahat dan tidur ibu		
6. Riwayat pengeluaran pervaginam (warna, jumlah, bau lokhea)		
7. Riwayat kesehatan/tanda bahaya nifas (pusing, pandangan kabur, demam)		
8. Aktivitas sosial & psikologis (dukungan keluarga, kecemasan, perawatan bayi)		

Skoring KOMPETENSI 1:

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai

Skoring

Skor

1. Persiapan

- a. Menyapa klien dan keluarga dengan sopan (mengucap salam)
- b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kunjungan rumah
- c. Meminta persetujuan tindakan (Informed Consent)
- d. Menjaga privasi ibu (menutup pintu/gorden rumah)
- e. Mencuci tangan/hand hygiene sesuai standar
- f. Menyiapkan alat tas bidan di atas alas yang bersih

2. Langkah-langkah Pemeriksaan

- a. Menilai keadaan umum dan emosional ibu
- b. Menilai tanda vital ibu
- c. Memeriksa konjungtiva dan edema wajah
- d. Melakukan inspeksi dan palpasi payudara (massa, bengkak, lecet)
- e. Menilai involusi uteri (TFU dan kontraksi)
- f. Menilai kandung kemih
- g. Menilai pengeluaran lochea dan kondisi perineum/luka SC
- h. Memeriksa tanda Homan (ekstremitas bawah)
- i. Menyimpulkan diagnosis (misal: Nifas normal atau Bendungan ASI)
- j. Melakukan tindakan sesuai diagnosis (misal: kompres/perawatan payudara)
- k. Melakukan observasi pada teknik menyusui ibu
- l. Menilai kebersihan lingkungan rumah yang relevan dengan kesehatan

3. Pasca Tindakan

- a. Menjelaskan hasil pemeriksaan fisik secara menyeluruh
- b. Mencatat temuan pada Buku KIA dan lembar catatan medis

Komponen yang dinilai**Skoring****Skor**

- c. Merapikan alat ke dalam tas bidan dan mencuci tangan

Skoring KOMPETENSI 2:

- 3= Jika peserta ujian melakukan 17–21 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 11–16 langkah dengan tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–10 langkah dengan tepat.
- 0= Jika peserta tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai**Skoring****Skor**

1. Memberikan pujian/dukungan atas keberhasilan ibu menyusui
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dengan bahasa yang mudah dimengerti
3. Memberikan edukasi spesifik (misal: teknik menyusui, perawatan luka)
4. Melibatkan suami/keluarga dalam pemberian dukungan kepada ibu
5. Menjelaskan tanda bahaya nifas dan kapan harus ke faskes
6. Menyepakati jadwal kunjungan ulang berikutnya

Skoring KOMPETENSI 3:

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0= Jika tidak melakukan.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai**Skoring****Skor**

1. Melaksanakan tindakan secara sistematis dan efisien
2. Menunjukkan sikap empati dan menghargai norma di rumah pasien
3. Komunikasi efektif (tenang, informatif, dan tidak menggurui)

4. Menjaga kebersihan dan ketertiban alat selama kunjungan
5. Percaya diri dan menjaga keselamatan pasien

Skoring KOMPETENSI 4:

- 3 = Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2 = Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1 = Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0 = Jika tidak melakukan.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = (Skor Komp 1 + Komp 2 + Komp 3 + Komp 4)

Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom penilaian umum:

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Nilai Akhir =

$$\frac{\text{Jumlah Total Skor}}{12} \times 100$$

(Kota),

Penguji:

M. Penerapan DOPS pada Kunjungan Rumah dan Continuity of Care (CoC)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kunjungan Rumah (KF/KN) dan Continuity of Care
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural di lahan praktik/simulasi. Penilai mengamati tindakan mahasiswa, lalu memberikan umpan balik segera. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati langsung bagaimana mahasiswa melakukan kunjungan rumah nifas atau neonatus, mulai dari cara berkomunikasi dengan keluarga hingga keterampilan teknis pemeriksaan fisik di rumah.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan yang aman, sistematis, dan berpusat pada keluarga (<i>family-centered care</i>) di luar fasilitas kesehatan. WHO menekankan pentingnya asuhan pascapersalinan yang terintegrasi, <i>evidence-based</i> , dan <i>woman-centred</i> , di mana bidan harus mampu mengidentifikasi tanda bahaya secara dini guna menurunkan angka morbiditas ibu dan bayi.	Mahasiswa dinilai dari kemampuannya mengidentifikasi risiko nifas/neonatus di rumah, memberikan edukasi yang sesuai konteks rumah tangga, dan mendokumentasikan kesinambungan asuhan (CoC).
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata kunjungan rumah	Seorang perempuan 26 tahun, P1A0 nifas hari ke-5,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kunjungan Rumah (KF/KN) dan Continuity of Care
Aktivitas mahasiswa yang diamati	yang mencakup pemantauan masa nifas, kesehatan bayi baru lahir, dan identifikasi tanda bahaya dini di komunitas. WHO menempatkan kunjungan rumah sebagai strategi kunci dalam menjamin kesinambungan asuhan (<i>Continuity of Care</i>).	dikunjungi di rumah (KF 2). Ibu mengeluh payudara bengkak dan nyeri (bendungan ASI), bayi rewel karena kesulitan menyusui, dan ibu tampak cemas. Hasil pemeriksaan menunjukkan suhu ibu 37,7°C dan puting tampak lecet.
	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan rangkaian tindakan klinik. Keterampilan yang relevan antara lain: menilai keadaan umum ibu, tanda vital, involusi uteri (TFU), lokhea, bendungan ASI, serta pemeriksaan fisik bayi (tali pusat, ikterus). WHO juga mencantumkan keterampilan komunikasi interpersonal dan pemberdayaan keluarga sebagai bagian integral dari asuhan komunitas.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, melakukan pemeriksaan fisik ibu dan bayi secara sistematis, melakukan manajemen bendungan ASI (kompres/masase), mendemonstrasikan teknik menyusui yang benar kepada ibu dan suami, serta melakukan dokumentasi pada Buku KIA.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi persiapan alat (tas bidan), <i>informed consent</i> , kemampuan teknis pemeriksaan, komunikasi terapeutik, dan kemampuan pengambilan keputusan klinis. Pada konteks CoC, aspek ini juga mencakup	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keluhan payudara bengkak, suhu subfebris, dan kecemasan ibu sebagai satu kesatuan masalah yang memerlukan penanganan laktasi segera agar tidak berlanjut menjadi mastitis.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kunjungan Rumah (KF/KN) dan Continuity of Care
Fokus observasi pembimbing	ketepatan mengenali tanda bahaya (seperti infeksi atau depresi pascasalinan) dan ketepatan keputusan rujukan.	
	Fokus pada mutu performa nyata. Pembimbing melihat apakah mahasiswa menjaga privasi, menggunakan alat secara higienis, dan melibatkan keluarga dalam asuhan. Pada kunjungan rumah, WHO menekankan pentingnya asuhan yang menghormati martabat ibu (<i>respectful care</i>) dan ketelitian dalam melakukan skrining komplikasi pada neonatus.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi masalah, melakukan prioritas tindakan (laktasi), menjaga privasi pasien di rumah, menghindari intervensi yang tidak perlu, serta memberikan edukasi yang jelas dan tidak menghakimi.
	Umpan balik diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS menekankan komentar <i>assessor</i> mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing menyampaikan bahwa mahasiswa sudah sangat baik dalam teknik pemeriksaan fisik, namun perlu meningkatkan kemampuan dalam melibatkan anggota keluarga (seperti suami) saat sesi edukasi agar dukungan di rumah menjadi lebih optimal.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan asuhan nifas dan neonatus secara runtut,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kunjungan Rumah (KF/KN) dan Continuity of Care
Makna dalam OBE	berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan klinis di komunitas.	aman, dan edukatif. Remedial diberikan jika mahasiswa gagal mengenali tanda bahaya atau melakukan prosedur yang membahayakan keselamatan pasien.
	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level <i>does</i> karena performanya diamati langsung. Observasi pada setting rumah menjadikan DOPS sangat sesuai untuk menilai kompetensi kebidanan komunitas.	Pada kasus kunjungan rumah, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori CoC, tetapi mampu menerapkan tindakan asuhan secara langsung, aman, profesional, dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan pasien di lapangan.

N. Portofolio: Bukti Kompetensi *Continuity of Care* (CoC)

Bukti yang dikumpulkan:

1. Hasil OSCE (Laboratorium) + DOPS (Lahan Praktik).

Catatan kasus singkat (Logbook CoC).

Refleksi *Patient Safety* dan *Respectful Care*.

Feedback dari CI (*Clinical Instructor*)/Dosen.

Catatan untuk penulis:

1. Portofolio ini bukan sekadar kumpulan tugas sekali ujian, melainkan rekam jejak perkembangan keterampilan mahasiswa.

Menekankan pada **bukti konsistensi** dalam memberikan asuhan yang aman di rumah pasien.

Tabel 5.1

Portofolio pada Kunjungan Rumah dan *Continuity of Care* (CoC)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kunjungan Rumah dan <i>Continuity of Care</i>
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata dari waktu ke waktu, bukan hanya satu kali ujian.	Pada topik CoC, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan asuhan nifas/neonatus di rumah, menilai involusi dan laktasi, mengenali tanda bahaya, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik kunjungan sebelumnya.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik lapangan.	Mahasiswa menunjukkan bagaimana ia mengelola kunjungan rumah misalnya pada kasus ibu nifas dari kunjungan pertama hingga kunjungan berikutnya, serta bagaimana ia merespons kendala atau permasalahan yang ditemui di lapangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah

**OSCE dan
DOPS**

OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata saat melakukan kunjungan rumah di lahan praktik.

mendapat masukan dari dosen atau CI.

OSCE memuat hasil ujian teknik pemeriksaan fisik neonatus dan edukasi laktasi. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penanganan pada kasus saat kunjungan rumah seperti manajemen bendungan ASI atau perawatan tali pusat di rumah pasien.

**Catatan
kasus
singkat**

Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang ditangani secara berkelanjutan, mencakup data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil asuhan.

Mahasiswa menuliskan ringkasan asuhan pada Ny. A (P1A0) nifas hari ke-5 dengan bendungan ASI, tindakan kompres yang dilakukan, edukasi posisi menyusui, dan hasil evaluasi pada kunjungan berikutnya.

**Refleksi
*patient
safety***

Refleksi *patient safety* menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien dan menyusun langkah pencegahan asuhan di lingkungan rumah. Refleksi Manajemen *Patient Safety* sangat krusial dalam metode *Outcome-Based Education* (OBE) karena melatih kognitif tingkat tinggi dan kesadaran etis mahasiswa.

Mahasiswa dituntut untuk menganalisis bagaimana setiap tindakan klinis dan pola komunikasi yang dilakukan dapat memitigasi bahaya, menjaga privasi, serta menjamin keselamatan ibu dan bayi melalui pemberdayaan keluarga yang terukur dan terdokumentasi dalam Buku KIA. Mahasiswa merefleksikan pentingnya pencegahan infeksi (cuci tangan) sebelum memegang bayi di rumah, ketelitian skrining ikterus, dan pencegahan keterlambatan rujukan jika ditemukan tanda bahaya nifas.

**Feedback
CI/dosen**

Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan dalam asuhan komunitas.

CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pendekatan pada keluarga, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam mendeteksi masalah laktasi pada ibu nifas dan mendokumentasikan pada Buku KIA.

**Karakteristik
penilaian**

Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utama adalah konsistensi performa mahasiswa.

Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kali kunjungan, tetapi dari beberapa laporan kasus yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan deteksi dini risiko pada ibu dan bayi, sehingga dapat menyimpulkan keefektifan CoC.

**Bukti
konsistensi
kompetensi**

Portofolio memperlihatkan kemampuan mahasiswa mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan waktu yang berbeda.

Melalui akumulasi hasil OSCE, DOPS, dan rekam asuhan pada Buku KIA, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu memantau tren pemulihan ibu (involusi dan laktasi) serta transisi neonatus dari kunjungan awal hingga akhir. Mahasiswa terbukti stabil dalam memberikan edukasi yang akurat, melakukan pemeriksaan fisik yang benar di setiap kunjungan rumah, serta mengambil keputusan rujukan yang tepat waktu saat ditemukan penyimpangan fisiologis pada ibu maupun bayi.

**Makna
dalam OBE**

Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tampak dalam performa yang

Pada topik kunjungan rumah dan CoC, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep asuhan

berulang, berkembang,
dan terdokumentasi secara
nyata.

berkelanjutan secara
teoritis, tetapi secara
konsisten mampu
menerapkannya dalam
praktik kebidanan nyata.
Portofolio menjadi bukti
bahwa mahasiswa berhasil
mengintegrasikan
pemantauan klinis,
pemberdayaan keluarga,
dan pengambilan
keputusan yang tepat
untuk menjamin
kesejahteraan ibu dan bayi
dari satu kunjungan ke
kunjungan berikutnya.

Tabel 5.2
Case Report pada Kunjungan Rumah dan Continuity of Care (CoC)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kunjungan Rumah dan Continuity of Care (CoC)
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien (ibu dan bayi) yang ditangani mahasiswa selama kunjungan rumah. Dalam OBE, <i>case report</i> berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan asuhan berkelanjutan secara ilmiah.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang asuhan pada seorang ibu nifas hari ke-5 (KF 2) dan neonatus (KN 2) yang mengalami kendala laktasi berupa bendungan ASI di rumah.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian nifas/bayi, analisis masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi asuhan di rumah, dan evaluasi hasil.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data klinis ibu dan bayi, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas (bendungan ASI), tindakan awal (manajemen laktasi), pemberdayaan keluarga, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat, keluhan utama (seperti nyeri payudara atau bayi rewel), data subjektif dan objektif, analisis diagnosis, tindakan, implementasi, evaluasi, serta poin pembelajaran dari kasus tersebut.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan keluhan payudara bengkak, suhu ibu 37,7°C, analisis bendungan ASI, tindakan kompres hangat, perah ASI dan perbaikan teknik menyusui, serta evaluasi peningkatan kenyamanan ibu dan bayi.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian nifas/neonatus, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik dalam setting rumah, ketepatan tindakan edukasi, dan kemampuan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan payudara yang keras, suhu subfebris, dan teknik menyusui yang salah sebagai kondisi yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kunjungan Rumah dan Continuity of Care (CoC)
Nilai edukatif	mengevaluasi kemandirian keluarga.	memerlukan penanganan laktasi segera agar tidak terjadi mastitis.
	<i>Case Report</i> membantu mahasiswa mengembangkan <i>clinical reasoning</i> , keterampilan dokumentasi pada Buku KIA, dan kebiasaan merefleksikan praktik asuhan komunitas secara ilmiah.	Dari kasus kunjungan rumah, mahasiswa belajar bahwa pemantauan berkelanjutan, dukungan psikologis bagi ibu, dan keterlibatan suami dalam laktasi merupakan inti dari keberhasilan asuhan pascapersalinan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori <i>Continuity of Care</i> ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis, bertanggung jawab, dan profesional.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep teoretis KF/KN, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan yang utuh dan berkesinambungan di lapangan.

Tabel 5.3

Refleksi *Patient Safety* pada Kunjungan Rumah dan *Continuity of Care* (CoC)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kunjungan Rumah dan CoC
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan di lingkungan komunitas/rumah.	Pada kasus kunjungan rumah, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali tanda bahaya di rumah dapat menyebabkan perburukan kondisi ibu dan bayi secara fatal.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kunjungan Rumah dan CoC
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama meskipun asuhan dilakukan dalam setting rumah yang memiliki keterbatasan alat.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan seperti kurang teliti melakukan skrining ikterus (bayi kuning), mengabaikan suhu subfebris ibu, atau tidak memvalidasi pemahaman keluarga, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Meliputi identifikasi risiko di rumah, analisis penyebab masalah, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman praktik lapangan.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kunjungan rumah adalah infeksi tali pusat, bendungan ASI yang berlanjut menjadi mastitis, dehidrasi pada bayi, serta keterlambatan rujukan akibat keluarga tidak mengenali tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi atau kondisi lingkungan rumah yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi meliputi: pencahayaan rumah yang buruk (mengaburkan penilaian warna kulit bayi), teknik cuci tangan yang tidak standar, penyimpanan obat/suplemen yang tidak aman, hygiene yang kurang, serta minimnya dukungan suami dalam pengawasan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien selama periode <i>Continuity of Care</i> .	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan Buku KIA secara konsisten sebagai media komunikasi, melakukan edukasi <i>red flags</i> (tanda bahaya) yang spesifik kepada keluarga,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kunjungan Rumah dan CoC
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kualitas praktik kebidanan di masa depan.	memastikan sterilitas perawatan tali pusat, serta menyiapkan rencana rujukan mandiri bagi keluarga.
		Mahasiswa menyadari bahwa dalam asuhan di komunitas, ketajaman observasi klinis, keterampilan komunikasi yang empatik, dan pemberdayaan keluarga adalah pilar utama keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap kualitas asuhan secara berkelanjutan.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik rutin, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko lingkungan dan meningkatkan standar keselamatan asuhan kebidanan di tingkat keluarga.

O. Ringkasan Materi

Kunjungan rumah (*home visit*) merupakan jembatan vital dalam layanan kesehatan yang mendekatkan asuhan kebidanan ke lingkungan domestik pasien. Sebagai bagian integral dari *Continuity of Care* (CoC), praktik ini mengedepankan pendekatan woman-centered care yang holistik, di mana bidan memberikan pendampingan berkelanjutan mulai dari masa kehamilan hingga nifas. Melalui model *Midwifery-Led Continuity of Care* (MLCC), bidan berperan sebagai pemberi asuhan utama yang membangun hubungan terapeutik berbasis kepercayaan, yang terbukti secara empiris mampu meningkatkan kualitas luaran maternal dan neonatal serta mengurangi intervensi medis yang tidak perlu.

Secara strategis, asuhan berkelanjutan ini memiliki dua fokus utama: klinis dan psikososial. Secara klinis, bidan melakukan surveilans ketat terhadap pemulihan fisik ibu (seperti involusi uteri dan manajemen laktasi) serta pemantauan kesehatan neonatus guna mendeteksi dini komplikasi seperti ikterus atau infeksi tali pusat. Di

sisi lain, dimensi psikososial bertujuan meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi, memfasilitasi *bonding*, serta melakukan skrining dini terhadap risiko depresi pascapersalinan menggunakan instrumen seperti EPDS. Riset menunjukkan bahwa model ini sangat efektif dalam menurunkan angka kematian perinatal dan meningkatkan kepuasan pasien hingga di atas 90%.

Keberhasilan kunjungan rumah sangat bergantung pada perencanaan yang sistematis dan persiapan logistik yang matang. Sebelum berangkat, bidan wajib melakukan skrining data rekam medis, berkomunikasi dengan keluarga untuk memastikan kesiapan, serta menyiapkan *Midwifery Home Visit Kit* yang lengkap mencakup alat pemeriksaan fisik (tensi, timbangan, oximeter) hingga bahan habis pakai steril. Perencanaan yang baik tidak hanya menjamin efisiensi kunjungan, tetapi juga krusial dalam membedakan antara indikasi asuhan rutin dan kondisi *Red Flags* (seperti perdarahan hebat atau sesak napas) yang mengharuskan rujukan segera ke fasilitas kesehatan.

Pada tahap pelaksanaan, bidan melakukan pengkajian fisik secara sistematis pada ibu dan bayi dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*) dan pencegahan infeksi. Selain tindakan klinis, pemberian KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) menjadi pilar penting yang dilakukan melalui demonstrasi langsung, seperti teknik menyusui dan perawatan tali pusat yang benar. Penggunaan Buku KIA sebagai media komunikasi resmi sangat ditekankan untuk memastikan adanya kesinambungan informasi antara tenaga kesehatan dan keluarga.

Tahap akhir dari kunjungan rumah adalah evaluasi hasil asuhan untuk menentukan rencana tindak lanjut. Bidan menilai parameter normalitas, seperti kontraksi uterus yang baik, kenaikan berat badan bayi yang adekuat, serta pemahaman keluarga terhadap tanda bahaya. Asuhan CoC dianggap berhasil secara keseluruhan apabila ibu dan bayi selamat dan sehat, proses menyusui eksklusif berjalan optimal, ibu menggunakan metode KB yang sesuai, serta terciptanya kemandirian keluarga dalam merawat ibu dan bayi secara profesional dan percaya diri.

Dokumentasi dalam *Continuity of Care* (CoC) merupakan bukti hukum (*legal evidence*) sekaligus instrumen vital untuk menjamin keselamatan pasien melalui kesinambungan informasi antar-tenaga kesehatan. Agar berfungsi optimal sebagai "benang merah" asuhan, dokumentasi harus memenuhi prinsip utama: tepat waktu (maksimal 2 jam setelah kunjungan), akurat dan objektif berdasarkan temuan klinis nyata, serta lengkap tanpa mengosongkan kolom asuhan. Selain itu, catatan harus terbaca jelas, teridentifikasi dengan tanda tangan bidan pelaksana, dan dijaga kerahasiaannya sesuai kode etik profesi untuk melindungi privasi pasien.

Implementasi dokumentasi pada kunjungan rumah menggunakan format SOAP (Subjektif, Objektif, Analisis, dan Penatalaksanaan) yang disusun secara sistematis untuk ibu dan bayi.

1. Subjektif (S): Menggali keluhan fisik, pola nutrisi, istirahat, dan kondisi emosional ibu, serta pola menyusui dan eliminasi bayi.

Objektif (O): Mencatat hasil pemeriksaan fisik terukur, seperti tanda vital, involusi uteri (TFU), karakteristik lochea, hingga skor EPDS untuk ibu, serta berat badan, suhu, dan refleks primitif pada neonatus.

Analisis (A): Menetapkan diagnosis kebidanan serta mengidentifikasi masalah atau kebutuhan mendesak.

Penatalaksanaan (P): Berisi tindakan nyata yang dilakukan, evaluasinya, serta rencana tindak lanjut dan jadwal kunjungan berikutnya.

Selain catatan internal fasilitas kesehatan, Buku KIA memegang peranan krusial sebagai dokumen resmi milik keluarga yang menjamin transparansi asuhan. Setiap temuan klinis dan grafik pertumbuhan bayi wajib diperbarui dalam Buku KIA agar menjadi referensi bagi tenaga kesehatan lain saat pasien berkunjung ke faskes berbeda. Seluruh data tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam rekam medis CoC (baik manual maupun digital) untuk mendukung audit mutu, mempermudah klaim JKN/BPJS, serta memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi bidan jika terjadi perselisihan medikolegal di masa depan.

Alur Asuhan Singkat: Kunjungan Rumah & CoC

Persiapan dan telaah data asuhan sebelumnya → pengkajian fisik dan psikologis ibu-bayi secara komprehensif → pemantauan involusi, laktasi, dan transisi neonatus → deteksi dini penyimpangan atau tanda bahaya (red flags) → pemberian KIE dan pemberdayaan keluarga → penetapan rencana tindak lanjut (rutin, intensif, atau rujukan, tanggal kunjungan ulang) → dokumentasi lengkap pada Buku KIA dan rekam medis CoC.

P. Tabel Red Flags & Eskalasi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
IBU POSTNATAL (Tanda Bahaya Ibu Nifas)		
Perdarahan pervaginam >500 mL atau lokhea berbau busuk	Perdarahan abnormal → kemungkinan HPP sekunder atau endometritis	Hentikan kunjungan, pasang IV line jika terlatih, rujuk segera ke fasilitas dengan kemampuan operatif
Suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ pada hari ke-3 nifas atau lebih	Demam nifas → kemungkinan infeksi luka SC, endometritis, mastitis, atau tromboflebitis	Lakukan identifikasi sumber infeksi secara menyeluruh dan pemantauan tanda-tanda vital secara berkala, serta segera lakukan koordinasi dengan dokter atau fasilitas rujukan apabila ditemukan tanda bahaya seperti nyeri abdomen atau pengeluaran lokhea yang berbau menyengat.
Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg atau sakit kepala hebat dan pandangan kabur	Risiko pre-eklampsia lanjut atau hipertensi pascapersalinan	Lakukan stabilisasi posisi miring kiri dan mobilisasi rujukan segera ke fasilitas kesehatan; hindari penundaan asuhan karena kondisi ini memerlukan intervensi medis darurat yang tidak dapat menunggu kunjungan terjadwal.
Nyeri, kemerahan, panas, atau indurasi pada luka SC atau jalan lahir disertai discharge	Infeksi luka operasi (SSI/ <i>Surgical Site Infection</i>), infeksi luka jahitan	Nilai REEDA, laporkan ke dokter bedah/SpOG, jangan buka balutan tanpa instruksi dokter
Tungkai nyeri tekan, hangat, bengkak unilateral; tanda Homan positif	Deep Vein Thrombosis (DVT) pasca persalinan, komplikasi serius yang dapat berakibat emboli paru	Batasi pergerakan tungkai, hubungi dokter untuk rujukan segera, dan pastikan tidak ada intervensi pijat pada area kaki untuk menjaga keselamatan vaskuler ibu.

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Skor EPDS ≥ 10 atau ibu menyatakan ingin menyakiti diri/bayi	Risiko depresi postpartum atau psikosis postpartum yang memerlukan penanganan segera	Jangan tinggalkan ibu sendirian, libatkan keluarga, rujuk ke psikologi/psikiater pada hari yang sama
Ibu menolak/tidak mampu menyusui, bayi tidak menyusu >8 jam	Risiko kegagalan laktasi eksklusif dan malnutrisi neonatus	Konsultasi konselor laktasi, nilai supply ASI, pertimbangkan donor ASI atau suplementasi sesuai indikasi medis
NEONATUS (Tanda Bahaya Bayi Baru Lahir)		
Penurunan BB >10% dari BB lahir atau tidak kembali ke BB lahir pada hari ke-14	Penurunan BB patologis → risiko dehidrasi, hipoglikemia neonatus, atau kegagalan laktasi berat	Pantau durasi dan efektivitas menyusui, lakukan observasi berat badan setiap dua hari, dan segera konsultasikan rencana asuhan kepada dokter terkait urgensi pemberian suplementasi.
Ikterus mencapai zona Kramer 3–5 (perut ke bawah, telapak tangan/kaki)	Hiperbilirubinemia patologis yang memerlukan fototerapi	Lakukan rujukan segera ke rumah sakit dan hindari keterlambatan penanganan akibat hanya mengandalkan paparan matahari langsung sebagai tindakan intervensi tunggal.
Sianosis sentral, frekuensi napas >60x/mnt, atau apnea >20 detik	Gangguan pernapasan neonatus atau sepsis neonatal	Resusitasi dasar jika tersedia alat, rujuk emergensi
Suhu aksila <36,5°C (hipotermi) atau >37,5°C (febris neonatal)	Hipotermi → risiko hipoglikemia; febris → curiga infeksi/sepsis	Berikan kehangatan melalui kontak kulit (PMK), evaluasi indikasi sepsis, dan aktivasi sistem rujukan segera jika intervensi awal dalam 30 menit tidak memberikan hasil optimal.
Tali pusat berbau, kemerahan melebihi batas tali pusat, keluar pus	Omfalitis, infeksi tali pusat yang dapat berkembang ke sepsis	Jangan beri obat tradisional apapun, rujuk segera untuk terapi antibiotik

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Bayi tidak mau menyusu >8 jam, tangis lemah, atau hipotonus	Kemungkinan hipoglikemia, sepsis, atau kegagalan adaptasi neonatus	Skrining kadar gula darah sewaktu jika memungkinkan dan segera mobilisasi rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut karena adanya indikasi darurat neonatal.
Kejang pada neonatus (gerakan berulang involunter, mata melirik)	Kemungkinan hipoglikemia, hipokalsemia, infeksi SSP, atau ensefalopati hipoksik iskemik	Lakukan rujukan darurat segera, prioritaskan pemeliharaan jalan napas (<i>airway</i>), dan lakukan observasi serta pencatatan durasi kejang untuk kepentingan diagnosis lanjut.

Q. Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Kunjungan Rumah dan Continuity of Care: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Dokumentasi

Nama Mahasiswa : _____ Tanggal : _____
NIM : _____ Tempat Praktik : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan kemampuan Anda saat ini.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
A. KONSEP DAN PERENCANAAN KUNJUNGAN RUMAH				
1	Saya sudah bisa menjelaskan definisi dan prinsip Continuity of Care (CoC) dalam kebidanan	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan perbedaan antara Relational, Informational, dan Management Continuity	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan jadwal kunjungan nifas (KF-1 s.d. KF-4) dan neonatal (KN-1 s.d. KN-3) beserta fokus asuhan masing-masing	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi indikasi dan kontraindikasi kunjungan rumah	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menyebutkan kondisi yang memerlukan rujukan segera (red flags) pada ibu nifas dan neonatus	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa merancang rencana asuhan (care plan) kunjungan rumah berdasarkan usia nifas dan usia neonatal	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menyiapkan Midwifery Home Visit Kit secara	☐	☐	_____

	lengkap sesuai daftar periksa			
8	Saya sudah bisa melakukan komunikasi awal (janji temu) dengan keluarga sebelum kunjungan secara profesional	☐	☐	_____
B. PELAKSANAAN KUNJUNGAN RUMAH				
9	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terstruktur pada ibu nifas di rumah (keluhan, laktasi, lokhea, psikologis, dukungan keluarga)	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik ibu nifas secara sistematis (tanda vital, payudara, TFU, lokhea, luka operasi, tungkai)	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik neonatus secara sistematis (tanda vital, BB, tali pusat, ikterus, refleks, menyusui)	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menilai perlekatan menyusui (latch-on) dan mengidentifikasi posisi yang tidak optimal	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mengoreksi teknik menyusui secara demonstratif kepada ibu dan keluarga	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa memberikan edukasi perawatan tali pusat yang benar (kering, bersih, tanpa dibungkus)	☐	☐	_____

15	Saya sudah bisa merespons praktik tradisional keluarga yang tidak berbasis bukti dengan pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa melakukan skrining depresi postpartum menggunakan EPDS dan menginterpretasikan hasilnya	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menerapkan prinsip 5 momen cuci tangan WHO dan pencegahan infeksi silang selama kunjungan rumah	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa memastikan keamanan bayi selama pemeriksaan (tidak ditinggal tanpa pengawasan di permukaan tinggi)	☐	☐	_____
C. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT				
19	Saya sudah bisa mengevaluasi hasil asuhan berdasarkan 7 parameter evaluasi CoC (TFU, lokhea, BB bayi, laktasi, tali pusat, psikologis, pemahaman tanda bahaya)	☐	☐	_____
20	Saya sudah bisa menentukan apakah kunjungan berikutnya sesuai jadwal, dipercepat, atau pasien perlu dirujuk	☐	☐	_____
21	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan bayi kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	_____

22	Saya sudah bisa menentukan jadwal kunjungan berikutnya dan mengkomunikasikannya kepada keluarga	☐	☐	_____
D. DOKUMENTASI				
23	Saya sudah bisa menulis dokumentasi SOAP ibu nifas secara lengkap, akurat, dan tepat waktu	☐	☐	_____
24	Saya sudah bisa menulis dokumentasi SOAP neonatus secara lengkap, akurat, dan tepat waktu	☐	☐	_____
25	Saya sudah bisa mengisi Buku KIA pada halaman kunjungan nifas dan neonatal dengan benar	☐	☐	_____
26	Saya sudah bisa memperbarui grafik pertumbuhan bayi (BB, PB, LK) pada halaman KMS Buku KIA	☐	☐	_____
27	Saya sudah bisa mengintegrasikan data hasil kunjungan rumah ke dalam rekam medis di fasilitas kesehatan	☐	☐	_____
E. PROFESIONALISME DAN PATIENT SAFETY				
28	Saya sudah bisa mengidentifikasi risiko keselamatan pasien selama kunjungan rumah dan mengambil tindakan pencegahan	☐	☐	_____
29	Saya sudah bisa menggunakan teknik komunikasi SBAR saat melaporkan temuan klinis kepada dokter atau supervisor	☐	☐	_____

30	Saya sudah bisa menjaga kerahasiaan data pasien dan tidak membagikannya ke media sosial dalam bentuk apapun	☐	☐	_____
31	Saya sudah bisa menyusun refleksi patient safety berdasarkan pengalaman kunjungan rumah nyata	☐	☐	_____
32	Saya sudah bisa menyusun case report satu kasus CoC secara sistematis dan ilmiah	☐	☐	_____

Refleksi Singkat Mahasiswa

Tuliskan satu hal paling bermakna yang Anda pelajari dari topik Kunjungan Rumah dan CoC ini, dan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi praktik kebidanan Anda ke depan.

R. Referensi

- Al-Worafi, Y. (2023). *Patient safety in developing countries: Education, research, case studies*. CRC Press.
- Aricahyo, N. P., Izzati, D., & Diah, I. (2025). The Importance of Continuity of Care (COC) as a Support System During Pregnancy: a Case Report. *Jurnal EduHealth*, 16(03), 1079–1087.
- Australian College of Midwives. (2017). *Continuity of Care Handbook*. [https://midwives.org.au/common/Uploaded files/Continuity of Care Handbook.pdf](https://midwives.org.au/common/Uploaded_files/Continuity_of_Care_Handbook.pdf)
- Bocanegra, H. T. de, McKean, A., Darney, P., Saleeby, E., & Hulett, D. (2018). Documentation of Contraception and Pregnancy Intention In Medicaid Managed Care. *Health Services Research and Managerial Epidemiology*, 5, 2333392817748870. <https://doi.org/10.1177/2333392817748870>
- Bowen, R., & Taylor, W. (2021). *Skills for Midwifery Practice E-Book: Skills for Midwifery Practice E-Book*. Elsevier Health Sciences.
- Bradford, B. F., Wilson, A. N., Portela, A., McConville, F., Fernandez Turienzo, C., & Homer, C. S. E. (2022). Midwifery continuity of care: A scoping review of where, how, by whom and for whom? *PLOS Global Public Health*, 2(10), e0000935.

- Cheng, G. Z., Chen, A., Xin, Y., & Ni, Q. Q. (2023). Using the teach-back method to improve postpartum maternal-infant health among women with limited maternal health literacy: a randomized controlled study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-05302-w>
- Demsash, A. W., Kassie, S. Y., Dubale, A. T., Chereka, A. A., Ngusie, H. S., Hunde, M. K., Emanu, M. D., Shibabaw, A. A., & Walle, A. D. (2023). Health professionals' routine practice documentation and its associated factors in a resource-limited setting: a cross-sectional study. *BMJ Health & Care Informatics*, 30(1), e100699.
- Diema Konlan, K., Kossi Vivor, N., Gegefe, I., A. Abdul-Rasheed, I., Esinam Kornyo, B., & Peter Kwao, I. (2021). The practice of home visiting by community health nurses as a primary healthcare intervention in a low-income rural setting: A descriptive cross-sectional study in the Adaklu District of the Volta region, Ghana. *The Scientific World Journal*, 2021(1), 8888845.
- Disik, B., Bunga, A. L., & Kusumaningsih, I. (2025). Clinical supervision on patient safety: A systematic literature review | Science Midwifery. *Science Midwifery*, 13(1), 280–285. <https://www.midwifery.iocspublisher.org/index.php/midwifery/article/view/1903>
- Eskandari, B., Nourizadeh, R., Mehrabi, E., Heshmati, R., Ivanbagha, R., & Akbarivand, Z. (2025). Evaluating the impact of home supportive counseling and telephone supportive counseling on postpartum depression and anxiety: a randomized controlled trial. *BMC Psychiatry*, 25(1), 510.
- Estiningtyas, Q., Adnani, S., Nurfitriyani, E., Merida, Y., Khuzaiyah, S., & Okinarum, G. Y. (2025). *Ninety-one years of midwifery continuity of care in low and middle-income countries: a scoping review*.
- Fikre, R., Gerards, S., Teklesilasie, W., & Gubbels, J. (2026). Women's Satisfaction with Midwifery-Led Continuity of Care: Insights from Antenatal, Intrapartum, and Postnatal Experiences in the Sidama Region, Ethiopia. A Non-Randomized Control Trial. *Health Services Insights*, 19, 11786329251404112.
- ICM. (2025). *Philosophy and Model of Midwifery Care / International Confederation of Midwives*. <https://internationalmidwives.org/resources/philosophy-and-model-of-midwifery-care/>
- International Confederation of Midwives. (2021). *ICM Professional Framework for Midwifery*. International Confederation of Midwives.
- Kamlem, T., & Mercer, K. M. (2025). *The Importance of Supply Chain Management in Improving Maternal, Newborn, and Child Health*.
- Kemenkes RI. (2021). *Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)*. Gizi KIA Kemenkes RI.

- Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*.
- Kemenkes RI. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/314519/permenkes-no-21-tahun-2021>
- Kemenkes RI. (2022). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: Hk.01.07/Menkes/1261/2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kemp, J., Maclean, G. D., & Moyo, N. (2021). *Global midwifery: Principles, policy and practice*. Springer.
- Kepmenkes. (2020). Kepmenkes 320 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Bidan. In *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology* (Vol. 34, Issue 8, pp. 709.e1-709.e9).
- Kosim, N., & Saimi, S. (2025). Enhancing patient safety outcomes through SBAR communication: A systematic review. *Malahayati International Journal of Nursing and Health Science*, 8(7), 843–857.
- La Rosa, V. L., Alparone, D., & Commodari, E. (2025). Psychological and social factors influencing mother–child bonding in the first year after birth: A model for promoting infant and maternal well-being. *Frontiers in Psychology*, 16, 1588433.
- Levis, B., Negeri, Z., Sun, Y., Benedetti, A., & Thombs, B. D. (2020). Accuracy of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for screening to detect major depression among pregnant and postpartum women: systematic review and meta-analysis of individual participant data. *BMJ*, m4022. <https://doi.org/10.1136/bmj.m4022>
- MacLeod, C., Braun, L., Caruso, B. A., Chase, C., Chidziwisano, K., Chipungu, J., Dreibelbis, R., Ejemot-Nwadiaro, R., Gordon, B., & Esteves Mills, J. (2023). Recommendations for hand hygiene in community settings: a scoping review of current international guidelines. *BMJ Open*, 13(6), e068887.
- Mulyani, E. Y., Rakhmawati, T., Damayanti, S., & Sumaedi, S. (2024). Digital communication media and maternal health education: Integration of bibliometric analysis, methodological analysis, and meta-synthesis. *Digital Health*, 10, 20552076241304820.
- Podder, V., Lew, V., & Ghassemzadeh, S. (2023). SOAP Notes. In *Ploughshares* (Vol. 48, Issue 4, pp. 145–148). StatPearls Publishing. <https://doi.org/10.1353/plo.2022.0155>
- Reynard, J., Stevenson, P., Catchpole, K., Forde, M., Stedman, F., Ives, F., Walker, J., &

- Kane, T. (2026). *Practical patient safety*. Oxford university press.
- Salsabila, A., Kusuma, P. N., Lesmana, A. E., Iswanto, A. H., & Istanti, N. D. (2024). Optimization of Logistics Management In Health Services: Literature Review. *Journal for Quality in Public Health*, 8(1), 52–59.
- Sandall, J., Fernandez Turienzo, C., Devane, D., Soltani, H., Gillespie, P., Gates, S., Jones, L. V, Shennan, A. H., & Rayment-Jones, H. (2024). Midwife continuity of care models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2024(5). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub6>
- Sari, K., Tarja, P., Minna, H., & Outi, K. (2025). Parents' Experiences of Family-Centred Care in Home-Based Paediatric Care of Their Child With Life-Limiting Illness: A Qualitative Descriptive Study. *Journal of Advanced Nursing*, 81(12), 8780–8793. <https://doi.org/10.1111/jan.16898>
- Savolainen, O., Rouvinen, H., & Barry, M. M. (2026). Core Components of Effective Home Visiting Programmes and Parenting Interventions Delivered by Nurses and Midwives—A Scoping Review. *Journal of Advanced Nursing*.
- Sholikah, S. M., Nurwulansari, F., Aini, E. N., Wardoyo, S., & Pramudita, J. J. (2025). The role of continuity of care in high-risk pregnant women in Indonesia. *European Journal of Midwifery*, 9, 10–18332.
- Simmelink, R., Neppelenbroek, E., Pouwels, A., van der Lee, N., Pajkrt, E., Ziesemer, K. A., Harmsen van der Vliet-Torij, H. W., Verhoeven, C. J. M., de Jonge, A., & Nieuwenhuijze, M. (2025). Understanding how midwife-led continuity of care can be implemented and under what circumstances: a realist review. *BMJ Open*, 15(2), e091968.
- Susanti, A. I., Ali, M., Hernawan, A. H., Rinawan, F. R., Purnama, W. G., Puspitasari, I. W., & Stellata, A. G. (2022). Midwifery continuity of care in Indonesia: Initiation of mobile health development integrating midwives' competency and service needs. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21), 13893.
- WHO. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. World Health Organization.
- WHO. (2024). *Transitioning the midwifery models of care: global position paper*. World Health Organization.
- Wolff, J. L., Clayman, M. L., Rabins, P., Cook, M. A., & Roter, D. L. (2015). An exploration of patient and family engagement in routine primary care visits. *Health Expectations*, 18(2), 188–198. <https://doi.org/10.1111/hex.12019>

BAB 6

PROMOSI KESEHATAN DAN KIE KIA: METODE, MEDIA, DAN STRATEGI PERUBAHAN PERILAKU

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mendemonstrasikan promosi kesehatan serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam pelayanan kebidanan komunitas berbasis teori perubahan perilaku, keselamatan pasien, dan regulasi nasional.

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep promosi kesehatan dalam kebidanan komunitas dan pelayanan KIA berbasis keluarga.
- Menguraikan teori perubahan perilaku (*Health Belief Model*, *Theory of Planned Behavior*, *Social Cognitive Theory*, dan model ekologi sosial) dalam praktik KIE.
- Menganalisis determinan sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan ibu dan anak.
- Memilih metode dan media promosi kesehatan yang sesuai dengan karakteristik sasaran.
- Menerapkan strategi perubahan perilaku dalam skenario kasus kebidanan komunitas.
- Mengintegrasikan prinsip keselamatan, etika, dan *Respectful Maternity Care* (RMC) dalam pelaksanaan KIE.
- Mendemonstrasikan keterampilan promosi kesehatan melalui simulasi (OSCE) dan praktik lapangan (DOPS).

Capaian Pembelajaran :

Kognitif

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep promosi kesehatan dalam kebidanan komunitas berbasis keluarga dan pelayanan kesehatan primer.
- Mahasiswa mampu menganalisis teori perubahan perilaku (Health Belief Model, Theory of Planned Behavior, Social Cognitive Theory, dan model ekologi sosial) dalam konteks praktik komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada pelayanan KIA.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi determinan sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi perilaku kesehatan ibu dan anak di komunitas.
- Mahasiswa mampu mengintegrasikan regulasi nasional (termasuk UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan kebijakan KIA) ke dalam perencanaan promosi kesehatan di tingkat pelayanan primer.
- Mahasiswa mampu merancang strategi promosi kesehatan berbasis teori perubahan perilaku untuk kasus kebidanan komunitas.

Psikomotor

- Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan konseling KIE secara sistematis, empatik, dan berpusat pada perempuan/keluarga sesuai prinsip Respectful Maternity Care (RMC).
- Mahasiswa mampu menggunakan media promosi kesehatan (Buku KIA, lembar balik, leaflet, media audiovisual, dan media digital) secara tepat sesuai karakteristik sasaran.
- Mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi promosi kesehatan dalam simulasi (OSCE) dengan memperhatikan keselamatan pasien, etika, dan efektivitas komunikasi.
- Mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan di komunitas (Posyandu/kelas ibu hamil/kunjungan rumah) dan menerima evaluasi melalui DOPS.

Afektif

- Mahasiswa menunjukkan sikap empati, menghargai nilai budaya, dan tidak menghakimi dalam memberikan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga.
- Mahasiswa menjunjung tinggi etika profesional, keselamatan pasien, dan kerahasiaan informasi dalam praktik promosi kesehatan.
- Mahasiswa menunjukkan tanggung jawab profesional dan sikap reflektif dalam mengevaluasi efektivitas KIE yang telah dilakukan.

- Mahasiswa mampu bekerja secara kolaboratif dan komunikatif dalam tim pelayanan kesehatan dan kader komunitas.

Strategi Pembelajaran Bab (Pendekatan Outcome-Based Education/OBE) yang menekankan pencapaian kompetensi secara bertahap. Mahasiswa tidak hanya memahami konsep promosi kesehatan, tetapi juga mampu mengaplikasikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam praktik nyata.

Proses pembelajaran mengikuti tahapan:

- Pemahaman konsep dan teori perubahan perilaku (Knows)
- Analisis kasus kebidanan komunitas (Knows How)
- Simulasi komunikasi dan konseling KIE (Shows How)
- Praktik langsung di komunitas melalui DOPS (Does)

Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mencapai kompetensi secara komprehensif pada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif.

Pendahuluan

Promosi kesehatan dalam kebidanan komunitas merupakan strategi fundamental dalam transformasi pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) berbasis keluarga. Dalam sistem pelayanan kesehatan primer, bidan tidak hanya berperan sebagai pelaksana tindakan klinis, tetapi sebagai fasilitator perubahan perilaku kesehatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kemampuan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara sistematis dan berbasis teori menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh mahasiswa kebidanan.

Permasalahan kesehatan ibu dan anak di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar determinan risiko bukan semata-mata bersifat medis, melainkan berkaitan erat dengan perilaku, literasi kesehatan, dukungan keluarga, serta norma sosial budaya. Ketidakefektifan imunisasi dasar, anemia pada remaja putri, keterlambatan kunjungan antenatal, serta rendahnya kesiapsiagaan komplikasi sering kali berakar pada kurang efektifnya promosi kesehatan dan KIE yang dilakukan di tingkat keluarga dan komunitas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya promotif dan preventif menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional. Hal ini memperkuat posisi promosi kesehatan sebagai mandat profesional bidan dalam pelayanan berbasis Posyandu, Puskesmas, dan kunjungan rumah. Sejalan dengan pendekatan Primary Health Care dari World Health Organization (WHO), promosi kesehatan harus dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas keluarga sebagai unit terkecil sistem sosial.

Bab ini membahas secara komprehensif konsep promosi kesehatan dalam kebidanan komunitas, teori perubahan perilaku yang mendasari praktik KIE, pemilihan metode dan media edukasi, analisis kebijakan nasional, serta integrasi evaluasi kompetensi melalui pendekatan OSCE dan DOPS. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi mampu mendemonstrasikan keterampilan promosi kesehatan secara aman, efektif, dan profesional.

Uraian Materi

Aktivitas Belajar (Scaffolding)

Aktivitas pembelajaran dalam bab ini dirancang secara bertahap untuk membantu mahasiswa mencapai kompetensi promosi kesehatan secara optimal.

Aktivitas 1 — Knows How

Mahasiswa diberikan mini-case terkait masalah kesehatan ibu dan anak (misalnya kepatuhan konsumsi tablet Fe atau penolakan imunisasi). Mahasiswa diminta mengidentifikasi masalah perilaku, menganalisis determinan menggunakan teori (HBM, TPB, SCT), serta merancang intervensi KIE.

Aktivitas 2 — Shows How

Mahasiswa melakukan simulasi konseling promosi kesehatan pada ibu atau keluarga dalam setting laboratorium atau role play. Fokus pada komunikasi terapeutik, pemilihan media, serta keselamatan pasien.

Catatan:

Mahasiswa tidak langsung diuji, tetapi melalui tahapan pembelajaran dari analisis menuju simulasi sebelum praktik nyata.

A. Konsep Promosi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas

(Capaian Kognitif No. 1)

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep promosi kesehatan dalam kebidanan komunitas berbasis keluarga dan pelayanan kesehatan primer.

1. Hakikat Promosi Kesehatan dalam Perspektif Global dan Nasional

Promosi kesehatan merupakan proses yang memungkinkan individu dan masyarakat meningkatkan kontrol terhadap determinan kesehatannya serta memperbaiki status kesehatannya secara berkelanjutan (*World Health Organization* [WHO], 1986). Definisi ini menegaskan bahwa promosi kesehatan tidak terbatas pada penyampaian informasi, melainkan mencakup proses pemberdayaan (empowerment), penguatan kapasitas (capacity building), serta penciptaan lingkungan yang mendukung perilaku sehat.

Piagam Ottawa (*Ottawa Charter for Health Promotion*) menekankan lima area aksi utama promosi kesehatan, yaitu: (1) pembangunan kebijakan publik berwawasan kesehatan, (2) penciptaan lingkungan yang mendukung, (3) penguatan aksi komunitas, (4) pengembangan keterampilan individu, dan (5) reorientasi pelayanan kesehatan (WHO, 1986). Dalam konteks kebidanan komunitas, kelima area ini terintegrasi dalam pelayanan KIA berbasis keluarga, Posyandu, serta pelayanan primer di Puskesmas.

Secara nasional, paradigma promotif dan preventif diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus mengutamakan upaya promotif dan preventif sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Regulasi ini memberikan legitimasi normatif terhadap praktik promosi kesehatan sebagai kewajiban profesional tenaga kesehatan, termasuk bidan.

Dalam kebidanan komunitas, promosi kesehatan berfokus pada peningkatan literasi kesehatan ibu dan keluarga, kesiapsiagaan terhadap komplikasi obstetri dan neonatal, serta pembentukan perilaku sehat sejak masa prakonsepsi hingga periode 1000 Hari Pertama Kehidupan. Dengan demikian, promosi kesehatan tidak bersifat insidental, tetapi menjadi bagian integral dari setiap kontak pelayanan kebidanan.

Promosi Kesehatan dalam Kerangka Primary Health Care

Pendekatan Primary Health Care (PHC) menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi sistem kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Deklarasi Alma-Ata (WHO, 1978) dan diperbarui dalam Deklarasi Astana (WHO, 2018) menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan bahwa pelayanan kesehatan primer harus berorientasi pada pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi komunitas.

PHC memiliki tiga komponen utama:

- a. Pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan terintegrasi
- Kebijakan multisektoral untuk mengatasi determinan sosial kesehatan
- Pemberdayaan individu dan komunitas

Dalam konteks Indonesia, implementasi PHC tercermin melalui penguatan Puskesmas sebagai *gatekeeper* pelayanan kesehatan dan revitalisasi Posyandu sebagai wadah partisipasi masyarakat. Bidan sebagai tenaga kesehatan garis depan memiliki peran sentral dalam mengoperasionalkan prinsip PHC melalui edukasi kesehatan, konseling, dan pemberdayaan keluarga.

Promosi kesehatan dalam kerangka PHC tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam pelayanan *antenatal care* (ANC), pelayanan nifas, imunisasi, konseling gizi, serta pemantauan tumbuh kembang anak. WHO (2018) menekankan bahwa tanpa promosi kesehatan yang efektif, sistem kesehatan akan terjebak pada pembiayaan kuratif yang mahal dan tidak berkelanjutan.

Pendekatan Berbasis Keluarga dalam Kebidanan Komunitas

Kebidanan komunitas berlandaskan pada filosofi *woman-centered care* yang diperluas menjadi *family-centered care* dalam praktik komunitas. Pendekatan ini menempatkan perempuan dan keluarga sebagai subjek aktif

dalam pengambilan keputusan kesehatan (International Confederation of Midwives [ICM], 2019). Dalam paradigma ini, bidan berperan sebagai fasilitator dialog, bukan sebagai otoritas yang bersifat paternalistik.

Dalam masyarakat Indonesia yang bercorak kolektivistik, keputusan kesehatan sering kali bersifat relasional dan dipengaruhi oleh suami maupun anggota keluarga lain. Oleh karena itu, promosi kesehatan yang hanya menargetkan ibu sebagai individu cenderung kurang efektif.

Temuan empiris dari penelitian Pihahay (2025) menunjukkan bahwa konstruk persepsi dalam Health Belief Model—khususnya persepsi kerentanan dan manfaat—memiliki hubungan signifikan dengan kelengkapan imunisasi anak. Namun, penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa persepsi ibu tidak berkembang secara terisolasi, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial terdekat, termasuk keluarga.

Hasil penelitian Nahuway, Pihahay, dan Iryani (2024) semakin memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa media informasi, dukungan tenaga kesehatan, dan dukungan keluarga berperan penting dalam membentuk pengetahuan ibu hamil mengenai imunisasi Tetanus Toxoid. Temuan ini menggarisbawahi bahwa dukungan keluarga bukan sekadar faktor tambahan, tetapi determinan signifikan dalam peningkatan literasi kesehatan ibu.

Lebih lanjut, penelitian Bambang et al. (2023) mengenai hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap vaksin COVID-19 menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan belum tentu secara otomatis menghasilkan sikap positif apabila tidak didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif. Dengan kata lain, perubahan kognitif harus diiringi penguatan norma sosial keluarga agar terjadi transformasi sikap dan perilaku.

Secara konseptual, pendekatan berbasis keluarga juga selaras dengan prinsip *Respectful Maternity Care* (RMC) yang menekankan penghormatan terhadap martabat perempuan, hak atas informasi, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan (White Ribbon Alliance, 2011). KIE yang berorientasi keluarga memungkinkan proses negosiasi nilai, klarifikasi miskonsepsi, dan pembentukan keputusan kolektif yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, pendekatan berbasis keluarga dalam kebidanan komunitas bukan hanya strategi komunikatif, melainkan pendekatan berbasis bukti yang relevan secara kontekstual dan empiris di Indonesia. Integrasi teori perilaku, dukungan keluarga, dan peran tenaga kesehatan menjadi fondasi perubahan perilaku kesehatan ibu dan anak yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Peran Strategis Bidan dalam Promosi Kesehatan

Peran strategis bidan dalam promosi kesehatan tidak hanya bersumber dari mandat etik dan profesional, tetapi juga ditegaskan secara eksplisit dalam kerangka regulasi nasional dan kebijakan transformasi sistem kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan upaya promotif dan preventif sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional. Orientasi ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan kuratif menuju pendekatan promotif-preventif berbasis siklus hidup. Dalam konteks tersebut, bidan sebagai tenaga kesehatan lini depan memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa setiap kontak pelayanan—baik di Puskesmas, Posyandu, maupun kunjungan rumah—mengintegrasikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara sistematis.

Transformasi Layanan Primer yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkuat peran promotif-preventif melalui penguatan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup dan integrasi layanan di tingkat komunitas. Revitalisasi Posyandu sebagai bagian dari transformasi tersebut menempatkan Posyandu tidak lagi sekadar sebagai tempat penimbangan balita, tetapi sebagai pusat layanan kesehatan terintegrasi yang mencakup edukasi kesehatan ibu hamil, pencegahan stunting, imunisasi, pengendalian penyakit tidak menular, serta skrining kesehatan dasar. Dalam konteks ini, bidan berperan sebagai pembina teknis, fasilitator kader, serta pengarah strategi promosi kesehatan berbasis masyarakat.

Permenkes tentang Puskesmas menegaskan bahwa Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang mencakup promosi kesehatan sebagai fungsi esensial pelayanan primer. Artinya, promosi kesehatan bukan aktivitas tambahan, melainkan bagian struktural dari sistem pelayanan. Selain itu, standar pelayanan kebidanan dan standar kompetensi bidan nasional juga menekankan bahwa bidan wajib memiliki kemampuan komunikasi efektif, konseling, serta pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam pengambilan keputusan kesehatan. Standar kompetensi global dari International Confederation of Midwives (ICM, 2019) semakin mempertegas bahwa promosi kesehatan merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki bidan dalam semua konteks praktik.

Secara empiris, efektivitas peran promotif bidan terlihat dalam berbagai intervensi berbasis media dan pemberdayaan komunitas. Peningkatan keterampilan kader melalui penggunaan lembar balik edukatif terbukti memperkuat kapasitas komunikasi kesehatan di tingkat komunitas dan meningkatkan pemahaman ibu mengenai isu kesehatan maternal dan anak. Media audiovisual dan booklet juga menunjukkan efektivitas dalam

meningkatkan pengetahuan serta sikap orang tua terhadap praktik kesehatan, yang menegaskan pentingnya pemilihan media yang tepat dalam strategi promosi kesehatan (Pihahay, 2025; Pihahay, Laelaem, & Padwa, 2024; Nahuway, Pihahay, & Iryani, 2024; Bambang et al., 2023; Qurrotul, Setyawan, & Pandu, 2023; Dellayani, Immawati, & Sari, 2026).

Dengan demikian, peran strategis bidan dalam promosi kesehatan berada pada titik temu antara kebijakan, praktik profesional, dan pemberdayaan masyarakat. Bidan bukan hanya pelaksana program, tetapi aktor kunci dalam tata kelola kesehatan (health governance) di tingkat komunitas. Integrasi regulasi nasional, standar profesi, dan bukti empiris memperkuat posisi promosi kesehatan sebagai fungsi inheren dalam praktik kebidanan komunitas, sekaligus sebagai instrumen utama dalam mencapai indikator kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

Integrasi Konseptual: Promosi Kesehatan sebagai Kompetensi Inti

Promosi kesehatan dalam kebidanan komunitas merupakan integrasi antara paradigma global kesehatan masyarakat, regulasi nasional, standar profesi, dan bukti empiris praktik lapangan. Secara konseptual, promosi kesehatan berakar pada Piagam Ottawa yang menekankan pemberdayaan dan reorientasi pelayanan dari kuratif ke promotif-preventif (WHO, 1986), serta diperkuat melalui pendekatan Primary Health Care yang mengedepankan partisipasi komunitas dan keadilan kesehatan (WHO, 2018). Dalam konteks Indonesia, orientasi tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan kebijakan Transformasi Layanan Primer yang menempatkan upaya promotif sebagai fondasi sistem pelayanan.

Dalam praktik kebidanan, filosofi *woman-centered care* dan *family-centered care* menegaskan bahwa perempuan dan keluarga merupakan subjek aktif dalam pengambilan keputusan kesehatan (ICM, 2019). Bukti empiris menunjukkan bahwa perubahan perilaku ibu dipengaruhi oleh persepsi risiko, dukungan keluarga, interaksi dengan tenaga kesehatan, serta efektivitas media edukasi yang digunakan dalam proses promosi kesehatan (Pihahay, 2025; Nahuway et al., 2024; Bambang et al., 2023). Berbagai media edukatif seperti lembar balik, leaflet, poster, video, dan booklet terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, memperjelas pesan kesehatan, serta memperkuat perubahan sikap keluarga terhadap praktik kesehatan ibu dan anak ketika digunakan secara sistematis dan kontekstual (Pihahay et al., 2024; Qurrotul et al., 2023; Dellayani et al., 2026).

Sintesis tersebut menunjukkan bahwa promosi kesehatan merupakan kompetensi inti bidan yang mencakup dimensi kognitif (penguasaan teori dan

determinan sosial), psikomotor (keterampilan komunikasi dan penggunaan media), serta afektif (empati dan profesionalisme). Oleh karena itu, promosi kesehatan bukan aktivitas tambahan, melainkan fondasi profesionalisme bidan dalam mendukung pencapaian indikator kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

B. Teori Perubahan Perilaku dalam Praktik KIE

(Capaian Kognitif No. 2)

1. Pentingnya Teori dalam Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan dalam kebidanan komunitas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan. Perubahan perilaku kesehatan ibu dan keluarga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, bidan perlu memahami teori perubahan perilaku sebagai dasar dalam merancang komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang efektif.

Tanpa pemahaman teori, edukasi kesehatan berisiko menjadi penyampaian informasi satu arah yang tidak menghasilkan perubahan perilaku. Teori membantu bidan untuk:

- a. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keputusan kesehatan.
Memilih pendekatan komunikasi yang tepat.
Menentukan strategi intervensi yang sesuai dengan kondisi keluarga.
Mengevaluasi efektivitas KIE yang telah dilakukan.

Pertanyaan Pemantik:

- a. Mengapa pemberian informasi saja sering tidak menghasilkan perubahan perilaku?
Bagaimana peran persepsi individu dalam menentukan keputusan kesehatan?

Beberapa teori perubahan perilaku yang sering diterapkan dalam promosi kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Health Belief Model (HBM)

Health Belief Model menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan tindakan kesehatan apabila ia:

- 1) Merasa berisiko terhadap suatu penyakit (*perceived susceptibility*)
- 2) Menganggap penyakit tersebut serius (*perceived severity*)
- 3) Meyakini adanya manfaat tindakan (*perceived benefits*)
- 4) Menilai hambatan dapat diatasi (*perceived barriers*)

Teori ini sangat relevan dalam pelayanan kebidanan karena banyak perilaku kesehatan ibu dipengaruhi oleh persepsi pribadi terhadap risiko dan manfaat.

Contoh dalam Praktik

Seorang ibu hamil tidak rutin mengonsumsi tablet Fe karena merasa tubuhnya sehat dan tidak pernah pusing. Dalam pendekatan HBM, bidan tidak langsung menyalahkan ibu, tetapi terlebih dahulu menggali persepsinya. Bidan dapat menjelaskan bahwa anemia sering tidak bergejala, dapat menyebabkan persalinan prematur, perdarahan, dan berat badan lahir rendah. Selanjutnya, bidan menekankan manfaat tablet Fe dan membantu mengatasi hambatan seperti rasa mual.

Penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko dan manfaat berpengaruh terhadap kelengkapan imunisasi anak (Pihahy, 2025). Artinya, sebelum memberikan edukasi, bidan perlu memahami bagaimana ibu memandang risiko dan manfaat suatu tindakan kesehatan. Melalui pemahaman HBM, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis persepsi ibu sebelum merancang intervensi KIE.

Refleksi Kritis

Bagaimana Anda akan mengubah persepsi ibu yang merasa dirinya tidak berisiko mengalami anemia?

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh:

- 1) Sikap terhadap perilaku
- 2) Norma subjektif (dukungan keluarga/lingkungan)
- 3) Persepsi kontrol diri

Dalam masyarakat Indonesia, norma keluarga sering menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan kesehatan. Ibu mungkin memiliki sikap positif terhadap imunisasi, tetapi jika suami atau orang tua tidak mendukung, maka keputusan dapat tertunda.

Contoh dalam Praktik

Seorang ibu ingin melakukan imunisasi TT, tetapi suaminya khawatir karena informasi dari media sosial. Dalam pendekatan TPB, bidan perlu melibatkan suami dalam konseling, menjelaskan manfaat imunisasi, dan memberikan kesempatan bertanya.

Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup mengubah sikap jika tidak didukung lingkungan sosial yang kondusif (Bambang et al., 2023). Oleh karena itu, strategi KIE harus melibatkan keluarga, bukan hanya ibu. Melalui TPB, mahasiswa belajar bahwa perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada dukungan sosial

Refleksi Kritis

Bagaimana strategi Anda jika ibu memiliki sikap positif, tetapi keluarga menolak intervensi kesehatan?

Social Cognitive Theory (SCT)

Social Cognitive Theory menekankan pentingnya *self-efficacy*, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya melakukan tindakan tertentu. Seseorang yang percaya diri akan lebih konsisten menjalankan perilaku sehat. Dalam pelayanan KIA, *self-efficacy* ibu dapat ditingkatkan melalui:

- 1) Demonstrasi langsung (misalnya teknik menyusui yang benar)
- 2) Latihan praktik
- 3) Umpan balik positif
- 4) Dukungan berkelanjutan

Contoh dalam Praktik

Seorang ibu merasa tidak mampu memberikan ASI eksklusif karena merasa produksi ASI sedikit. Bidan dapat memberikan edukasi tentang teknik pelekatan yang benar, melakukan demonstrasi, serta memberikan dukungan emosional. Ketika ibu merasa mampu, maka kemungkinan keberhasilan ASI eksklusif meningkat.

Dukungan tenaga kesehatan dan media informasi terbukti membantu meningkatkan pemahaman ibu terhadap imunisasi dan pelayanan kesehatan lainnya (Nahuway et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan *self-efficacy* dapat diperkuat melalui komunikasi yang efektif dan media edukasi yang tepat. Mahasiswa diharapkan mampu membangun rasa percaya diri ibu sebagai bagian dari strategi KIE.

Refleksi Kritis

Mengapa perubahan perilaku harus melibatkan faktor komunitas dan kebijakan, tidak hanya individu?

Pendekatan Ekologi Sosial

Pendekatan ekologi sosial menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh berbagai tingkat faktor, yaitu:

- 1) Individu
- 2) Keluarga
- 3) Komunitas
- 4) Institusi pelayanan kesehatan
- 5) Kebijakan

Dalam praktik kebidanan komunitas, perubahan perilaku tidak dapat hanya difokuskan pada ibu sebagai individu. Misalnya, kepatuhan imunisasi tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan ibu, tetapi juga oleh jadwal Posyandu, dukungan kader, akses transportasi, dan kebijakan pemerintah.

Contoh dalam Praktik

Jika cakupan imunisasi di suatu wilayah rendah, bidan tidak hanya memberikan edukasi kepada ibu, tetapi juga berkoordinasi dengan keluarga, kader, tokoh masyarakat, dan perangkat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pendekatan ini membantu mahasiswa memahami bahwa promosi kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat individual.

C. Media Promosi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas

(Capaian Kognitif No. 5 dan Psikomotor)

Media promosi kesehatan merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan agar lebih mudah dipahami, menarik, dan efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Dalam kebidanan komunitas, media berfungsi memperjelas informasi, meningkatkan daya ingat, serta membantu ibu dan keluarga memahami risiko dan manfaat suatu tindakan kesehatan. Oleh karena itu, pemilihan media tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Bidan perlu mempertimbangkan tingkat pendidikan sasaran, budaya dan bahasa lokal, ketersediaan sarana, serta karakteristik masalah kesehatan yang dihadapi. Media yang tepat akan memperkuat pesan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), sedangkan media yang tidak sesuai dapat menurunkan efektivitas proses edukasi.

Secara umum, media promosi kesehatan dalam kebidanan komunitas dapat berupa media cetak, audiovisual, media massa, maupun media digital, yang masing-

masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik sasaran agar pesan kesehatan dapat diterima dengan baik dan mendorong perubahan perilaku. Tabel berikut merangkum berbagai jenis media promosi kesehatan yang relevan dalam pelayanan kebidanan komunitas beserta dukungan evidensinya.

Tabel 6.1
Jenis Media Promosi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas

No	Jenis Media	Karakteristik	Kegunaan dalam KIA	Kelebihan	Contoh Praktik
1	Leaflet	Lembaran ringkas berisi informasi singkat	Tanda bahaya kehamilan, anemia, imunisasi	Mudah dibawa, dapat dibaca ulang	Dibagikan setelah konseling ANC
2	Poster	Media visual ditempel di ruang publik	Pengingat pesan kesehatan	Menarik perhatian, mudah dilihat	Poster di ruang tunggu Puskesmas
3	Booklet	Buku kecil materi lebih lengkap	Edukasi kehamilan, BBL, imunisasi	Dapat dipelajari berulang	Dibagikan saat kelas ibu hamil
4	Lembar Balik (Flipchart)	Media dua sisi untuk penyuluhan kelompok	Kelas ibu hamil, Posyandu	Interaktif dan sistematis	Digunakan saat penyuluhan
5	Video Edukasi	Media audio-visual	Teknik menyusui, KB, imunisasi	Lebih menarik, mudah dipahami	Pemutaran video kelas ibu hamil
6	Televisi (TV)	Media massa audio-visual skala luas	Kampanye ASI, imunisasi nasional	Jangkauan luas, visual kuat	Iklan layanan masyarakat
7	Radio	Media audio berbasis siaran	Edukasi daerah terpencil	Biaya murah, jangkauan luas	Talkshow kesehatan ibu
8	Billboard	Media luar ruang berukuran besar	Kampanye gizi, pencegahan stunting	Paparan berulang, visibilitas tinggi	Billboard di pusat kota
9	Instagram (IG)	Media sosial berbasis visual	Edukasi infografis KIA	Interaktif, menarik generasi muda	Konten edukasi Puskesmas
10	Facebook (FB)	Media sosial komunitas	Edukasi kelompok ibu/ Komunitas	Diskusi dan berbagi informasi	Grup ibu hamil
11	TikTok	Video pendek interaktif	Edukasi cepat & kampanye	Viral, mudah diterima generasi muda	Video singkat tanda bahaya
12	YouTube	Platform video panjang	Tutorial Yoga Teknik menyusui, MPASI	Visual detail, dapat diulang	Channel edukasi kesehatan

Prinsip Pemilihan Media

Pemilihan media promosi kesehatan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan determinan perilaku yang dihadapi. Media cetak seperti leaflet lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran (HBM), sedangkan media audiovisual dan demonstrasi lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan dan self-efficacy (SCT). Media sosial dapat digunakan untuk memperkuat norma sosial dan dukungan lingkungan (TPB).

D. Metode Promosi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas

(Capaian Kognitif No. 5 dan Psikomotor)

Metode promosi kesehatan merupakan cara atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat. Jika media adalah alat bantu, maka metode adalah strategi pelaksanaan komunikasi yang digunakan bidan dalam proses edukasi. Pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku kesehatan ibu dan anak.

Dalam kebidanan komunitas, metode promosi kesehatan harus disesuaikan dengan tujuan edukasi, karakteristik sasaran, jumlah peserta, serta konteks pelayanan (Posyandu, Puskesmas, kelas ibu hamil, atau kunjungan rumah). Metode yang digunakan sebaiknya bersifat partisipatif dan berpusat pada perempuan serta keluarga.

1. Jenis Metode Promosi Kesehatan

Bidan perlu memahami berbagai metode yang dapat digunakan agar kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) menjadi lebih sistematis, interaktif, dan berorientasi pada perubahan perilaku. Pada Tabel 7.2 Metode Promosi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas merangkum berbagai metode promosi kesehatan yang umum digunakan dalam kebidanan komunitas beserta contoh penerapannya.

2. Pemilihan Metode yang Tepat

Dalam memilih metode promosi kesehatan, bidan perlu mempertimbangkan:

a. Tujuan edukasi (pengetahuan, sikap, atau keterampilan)

Jumlah sasaran (individu atau kelompok)

Tingkat literasi Kesehatan

Ketersediaan waktu dan fasilitas

Dukungan keluarga dan lingkungan

Sebagai contoh, untuk meningkatkan pengetahuan dasar tentang tanda bahaya kehamilan, metode ceramah singkat dengan leaflet mungkin cukup.

Namun, untuk meningkatkan keterampilan menyusui, metode demonstrasi dan praktik langsung lebih efektif.

Tabel 6.2
Metode Promosi Kesehatan dalam Kebidanan Komunitas

No	Metode	Deskripsi	Kelebihan	Contoh Penerapan dalam KIA	Kesesuaian Teori
1	Ceramah/Edukasi Individu	Penyampaian informasi secara langsung kepada individu	Efektif untuk konseling personal	Konseling ANC, edukasi tablet Fe	HBM
2	Diskusi Kelompok	Edukasi interaktif dalam kelompok kecil	Meningkatkan partisipasi dan berbagi pengalaman	Kelas ibu hamil	TPB
3	Demonstrasi	Menunjukkan cara melakukan tindakan tertentu	Meningkatkan keterampilan dan self-efficacy	Teknik menyusui, perawatan BBL	SCT
4	Simulasi/Role Play	Latihan peran untuk memahami situasi nyata	Meningkatkan kesiapsiagaan dan empati	Simulasi tanda bahaya kehamilan	Ekologi Sosial
5	Kunjungan Rumah	Edukasi langsung di lingkungan keluarga	Kontekstual dan personal	Edukasi ibu nifas di rumah	TPB & Ekologi Sosial
6	Penyuluhan Massal	Edukasi pada kelompok besar	Jangkauan luas	Kampanye stunting	Ekologi Sosial

Pengambilan Keputusan Klinis dalam Pemilihan Metode

Pemilihan metode promosi kesehatan tidak bersifat acak, tetapi harus disesuaikan dengan analisis teori perilaku. Jika masalah utama adalah persepsi risiko, maka konseling individu lebih tepat. Jika berkaitan dengan norma sosial, maka diskusi kelompok dan pendekatan keluarga lebih efektif. Jika berkaitan dengan keterampilan, maka demonstrasi dan praktik langsung menjadi pilihan utama.

3. Integrasi Metode dan Teori Perubahan Perilaku

Metode promosi kesehatan sebaiknya tidak dipilih secara acak, tetapi disesuaikan dengan teori perubahan perilaku yang telah dipelajari sebelumnya. Integrasi teori perubahan perilaku dan metode promosi kesehatan sangat penting agar kegiatan KIE tidak dilakukan secara acak. Bidan perlu menyesuaikan metode dengan faktor perilaku yang dianalisis berdasarkan teori. Tabel 7.3 Integrasi Teori Perubahan Perilaku dengan Metode Promosi Kesehatan dalam Praktik KIE diatas menunjukkan hubungan antara teori, metode, dan tujuan perubahan perilaku dalam praktik kebidanan komunitas.

Tabel 6.3
Integrasi Teori Perubahan Perilaku dengan Metode Promosi Kesehatan dalam Praktik KIE

Teori	Fokus Analisis Perilaku	Metode Promosi Kesehatan	Media yang Mendukung	Output Perubahan Perilaku
Health Belief Model (HBM)	Persepsi risiko, persepsi keparahan, manfaat dan hambatan	Konseling individu, edukasi personal	Leaflet, booklet, konseling tatap muka	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
Theory of Planned Behavior (TPB)	Sikap, norma subjektif, dukungan keluarga	Diskusi kelompok, konseling pasangan	Poster, diskusi kelas ibu hamil, media sosial	Penguatan niat berperilaku
Social Cognitive Theory (SCT)	Self-efficacy, observasi, pengalaman langsung	Demonstrasi dan praktik langsung	Video edukasi, lembar balik	Meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri
Pendekatan Ekologi Sosial	Faktor individu, keluarga, komunitas, dan kebijakan	Penyuluhan massal, advokasi, kolaborasi lintas sektor	Media massa, kampanye, media digital	Perubahan perilaku berkelanjutan

E. Strategi Perubahan Perilaku dalam Pelayanan KIA

(Capaian Kognitif No. 5 dan Psikomotor)

Strategi perubahan perilaku dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk memengaruhi pengetahuan, sikap, dan praktik kesehatan ibu serta keluarga. Berbeda dengan metode yang bersifat teknis, strategi bersifat lebih komprehensif karena mengintegrasikan teori perilaku, metode pelaksanaan, media komunikasi, serta konteks sosial budaya masyarakat. Dalam kebidanan komunitas, perubahan perilaku tidak terjadi secara instan. Perubahan tersebut memerlukan proses yang melibatkan persepsi individu, dukungan keluarga, interaksi tenaga kesehatan, serta faktor lingkungan dan kebijakan. Oleh karena itu, bidan perlu menyusun strategi yang terencana dan berbasis bukti agar intervensi promosi kesehatan menjadi efektif dan berkelanjutan.

F. Tahapan Strategi Perubahan Perilaku

Strategi perubahan perilaku dalam praktik KIE dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Identifikasi Masalah Perilaku

Bidan mengidentifikasi perilaku yang menjadi masalah, misalnya:

- a. Ibu tidak rutin mengonsumsi tablet Fe
- b. Anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap
- c. Ibu tidak melakukan ANC sesuai standar

Identifikasi dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis faktor penyebab

2. Analisis Faktor Determinan Perilaku

Berdasarkan teori perubahan perilaku, bidan perlu menganalisis:

- a. Persepsi risiko dan manfaat (HBM)
- b. Norma keluarga dan dukungan sosial (TPB)
- c. Self-efficacy atau kepercayaan diri (SCT)
- d. Faktor komunitas dan kebijakan (Ekologi Sosial)

Tahap ini sangat penting agar strategi tidak bersifat umum, tetapi sesuai dengan penyebab utama perilaku.

3. Pemilihan Metode dan Media

Setelah determinan perilaku dianalisis, bidan memilih:

- a. Metode (konseling, diskusi, demonstrasi, advokasi)
- b. Media (leaflet, video, poster, media sosial, dll.)
- c. Pemilihan harus disesuaikan dengan karakteristik sasaran.

4. Implementasi Intervensi

Strategi dilaksanakan secara sistematis, misalnya:

- a. Konseling individual saat ANC
 - b. Diskusi kelompok pada kelas ibu hamil
 - c. Demonstrasi teknik menyusui
 - d. Kolaborasi dengan kader dan tokoh masyarakat
5. Evaluasi dan Tindak Lanjut
- Evaluasi dilakukan untuk menilai:
- a. Perubahan pengetahuan
 - b. Perubahan sikap
 - c. Kepatuhan terhadap anjuran kesehatan
 - d. Jika belum terjadi perubahan, strategi dapat dimodifikasi.

Contoh Kasus 1

Kasus 1: Ibu Tidak Rutin Mengonsumsi Tablet Fe

Analisis:

1. Ibu merasa sehat (persepsi risiko rendah)
2. Suami tidak memahami pentingnya tablet Fe
3. Strategi:
4. Konseling individu berbasis HBM
5. Edukasi keluarga (TPB)
6. Pemberian leaflet dan booklet
7. Monitoring kepatuhan setiap kunjungan

Target:

Meningkatkan kesadaran risiko anemia dan kepatuhan konsumsi tablet Fe.

Kasus 2: Cakupan Imunisasi Rendah di Posyandu

Analisis:

1. Adanya informasi hoaks
2. Kurangnya dukungan keluarga
3. Minimnya pemahaman manfaat imunisasi
4. Strategi:
5. Diskusi kelompok di Posyandu
6. Pemutaran video edukasi
7. Demonstrasi oleh kader
8. Kampanye melalui media sosial Puskesmas

Target:

Meningkatkan kepercayaan dan kelengkapan imunisasi.

G. Prinsip Strategi yang Efektif dalam Kebidanan Komunitas

Strategi perubahan perilaku yang efektif harus:

1. Berbasis teori ilmiah
2. Melibatkan keluarga
3. Sensitif terhadap budaya lokal
4. Menggunakan media yang sesuai
5. Berkelanjutan dan dievaluasi

Pendekatan yang hanya bersifat informatif tanpa mempertimbangkan determinan perilaku cenderung kurang efektif dalam menghasilkan perubahan jangka panjang.

Penegasan Pembelajaran

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis determinan perilaku kesehatan ibu dan anak
2. Merancang strategi promosi kesehatan berbasis teori
3. Mengintegrasikan metode dan media secara tepat
4. Melakukan evaluasi hasil intervensi

H. Aktivitas Belajar

Analisis Kasus (Knows How)

Mahasiswa diminta menganalisis kasus berikut menggunakan pendekatan teori perubahan perilaku dan merancang intervensi KIE secara sistematis.

Studi Kasus 1

1. Kasus: Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe pada Ibu Hamil

Seorang ibu hamil usia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke Puskesmas untuk kunjungan ANC. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar Hb 9,8 g/dL. Ibu mengaku sering lupa mengonsumsi tablet Fe karena merasa tidak ada keluhan dan menganggap dirinya sehat. Suami juga tidak terlalu memperhatikan anjuran tenaga kesehatan karena merasa anemia bukan masalah serius. Di wilayah tersebut, beberapa ibu hamil juga menunjukkan kepatuhan rendah terhadap konsumsi tablet Fe.

2. Tugas Mahasiswa

- a. Identifikasi masalah perilaku utama dalam kasus tersebut.
- b. Analisis determinan perilaku menggunakan minimal dua teori perubahan perilaku.
- c. Tentukan metode promosi kesehatan yang sesuai.
- d. Pilih media yang tepat.

- e. Susun strategi intervensi terintegrasi.
- 3. Contoh Analisis (Model Jawaban)
 - Masalah utama:
Rendahnya kepatuhan konsumsi tablet Fe.
 - Analisis teori:
 - a. HBM → Persepsi risiko rendah (tidak merasa sakit).
 - b. TPB → Dukungan suami rendah (norma subjektif lemah).
 - c. Strategi:
 - d. Konseling individu berbasis HBM (menjelaskan risiko anemia pada ibu dan janin).
 - e. Konseling pasangan (melibatkan suami).
 - Pemberian leaflet edukatif.
 - Monitoring kepatuhan pada kunjungan berikutnya.
 - Target perubahan:
Meningkatkan kesadaran risiko dan kepatuhan konsumsi tablet Fe.

Studi Kasus 2

- 1. Kasus: Penolakan Imunisasi di Posyandu
 - Di sebuah desa, cakupan imunisasi dasar lengkap hanya mencapai 65%. Beberapa orang tua menolak imunisasi karena terpengaruh informasi di media sosial yang menyebutkan imunisasi berbahaya. Kader Posyandu merasa kesulitan menjawab pertanyaan masyarakat.
- 2. Tugas Mahasiswa
 - a. Identifikasi faktor individu, keluarga, dan komunitas yang memengaruhi perilaku.
 - b. Gunakan pendekatan ekologi sosial untuk menganalisis masalah.
 - c. Rancang strategi promosi kesehatan berbasis komunitas.
 - d. Tentukan metode dan media yang digunakan.
- 3. Contoh Analisis
 - Faktor individu: Kurangnya pemahaman manfaat imunisasi. Faktor keluarga: Pengaruh opini anggota keluarga. Faktor komunitas: Penyebaran hoaks di media sosial.
 - Strategi:
 - a. Diskusi kelompok di Posyandu.
 - b. Demonstrasi dan penjelasan oleh bidan dan kader terlatih.
 - c. Pemutaran video edukasi.
 - d. Kampanye melalui media sosial Puskesmas.

e. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat.

Target perubahan:

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi dan meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap.

I. Latihan Reflektif

Jawablah pertanyaan berikut secara tertulis:

1. Mengapa perubahan perilaku tidak dapat dicapai hanya dengan pemberian informasi?
2. Bagaimana peran keluarga memengaruhi keputusan kesehatan ibu?
3. Jelaskan hubungan antara teori perubahan perilaku dan strategi intervensi.

J. Penugasan Kelompok

Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta untuk:

1. Mengidentifikasi satu masalah KIA di wilayah praktik.
2. Melakukan analisis determinan perilaku.
3. Menyusun strategi promosi kesehatan lengkap (teori + metode + media).
4. Mempresentasikan rencana intervensi.

Penilaian mencakup aspek analisis, kreativitas strategi, dan kemampuan komunikasi.

Integrasi Pembelajaran Berbasis Piramida Miller

Pembelajaran dalam bab ini mengacu pada piramida Miller, yaitu:

1. Knows: memahami konsep promosi kesehatan
2. Knows How: menganalisis kasus
3. Shows How: melakukan simulasi (OSCE)
4. Does: praktik nyata di lapangan (DOPS)

Pendekatan ini memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkannya dalam praktik nyata.

K. Evaluasi Kompetensi: Rubrik OSCE dan DOPS dalam Promosi Kesehatan dan KIE KIA

Evaluasi pembelajaran dalam kebidanan komunitas tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga keterampilan praktik (psikomotor) dan sikap profesional (afektif). Dalam konteks promosi kesehatan dan KIE, mahasiswa harus mampu melakukan komunikasi efektif, menganalisis determinan perilaku, memilih metode dan media yang tepat, serta menunjukkan empati dalam interaksi dengan ibu dan keluarga.

Dua metode evaluasi berbasis kompetensi yang umum digunakan dalam pendidikan kebidanan adalah:

- OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
- DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)

1. Rubrik OSCE

Simulasi Konseling Promosi Kesehatan)

Skenario OSCE

Mahasiswa melakukan konseling kepada ibu hamil trimester II yang tidak rutin mengonsumsi tablet Fe.

Durasi: 10–15 menit.

Rubrik Penilaian OSCE

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Persiapan	Memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan	Tidak dilakukan	Kurang jelas	Cukup jelas	Sangat jelas & sistematis
2	Komunikasi	Bahasa mudah dipahami, kontak mata, empati	Tidak empatik	Kurang empatik	Cukup empatik	Sangat empatik & profesional
3	Analisis Masalah	Menggali persepsi risiko & hambatan	Tidak menggali	Terbatas	Cukup baik	Mendalam & sistematis
4	Penerapan Teori	Mengaitkan edukasi dengan persepsi/manfaat	Tidak tampak	Kurang tepat	Cukup sesuai	Sangat sesuai & terintegrasi
5	Pemilihan Media	Menggunakan leaflet/media pendukung	Tidak ada media	Media tidak sesuai	Media cukup sesuai	Media sangat tepat
6	Penutupan	Merangkum & memastikan pemahaman	Tidak merangkum	Kurang jelas	Cukup jelas	Jelas & memastikan komitmen

Skor Maksimal: 24

Interpretasi:

a. 21–24 = Sangat Kompeten

b. 17–20 = Kompeten

c. 13–16 = Cukup

d. ≤ 12 = Perlu Pembinaan

2. Rubrik DOPS

Observasi Langsung Keterampilan Edukasi di Lapangan

DOPS dilakukan saat mahasiswa melakukan penyuluhan di Posyandu atau kelas ibu hamil.

Rubrik Penilaian DOPS

No	Komponen	Indikator	Belum Kompeten	Cukup	Kompeten	Sangat Kompeten
1	Materi sesuai topik KIA	Tidak sesuai	Kurang lengkap	Sesuai	Sangat sistematis	
2	Struktur Penyampaian	Sistematis & runtut	Tidak runtut	Kurang runtut	Cukup runtut	Sangat runtut
3	Penggunaan Media	Media digunakan efektif	Tidak digunakan	Kurang efektif	Cukup efektif	Sangat efektif
4	Interaksi Peserta	Melibatkan peserta	Pasif	Kurang interaktif	Cukup interaktif	Sangat partisipatif
5	Sikap Profesional	Etika, empati, percaya diri	Kurang profesional	Cukup	Profesional	Sangat profesional
6	Evaluasi Edukasi	Mengukur pemahaman peserta	Tidak dilakukan	Terbatas	Cukup	Sistematis

Catatan Pembelajaran

OSCE dan DOPS tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi akhir, tetapi merupakan bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan untuk memastikan mahasiswa mencapai kompetensi secara nyata.

Checklist Kompetensi Mahasiswa

Setelah mempelajari bab ini, saya sudah mampu:

- a. Menjelaskan konsep promosi kesehatan KIA
- b. Menganalisis perilaku menggunakan teori
- c. Melakukan komunikasi terapeutik
- d. Memilih metode dan media yang tepat
- e. Melakukan konseling KIE secara sistematis
- f. Melibatkan keluarga dalam edukasi
- g. Mengevaluasi hasil intervensi

Jika terdapat kompetensi yang belum tercapai, mahasiswa diharapkan mengulang pembelajaran dan melakukan refleksi terhadap hambatan yang dihadapi.

L. Rangkuman Materi

Bab ini membahas secara komprehensif konsep, teori, metode, media, dan strategi perubahan perilaku dalam promosi kesehatan dan komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE) pada pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Promosi kesehatan dalam kebidanan komunitas tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi merupakan proses sistematis yang bertujuan membentuk perilaku kesehatan yang positif, berkelanjutan, dan berbasis keluarga.

Konsep promosi kesehatan dalam kebidanan komunitas berlandaskan pada prinsip *woman-centered care* dan *family-centered care*, yang menempatkan perempuan dan keluarga sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan kesehatan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kolektivistik, dukungan keluarga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan intervensi kesehatan.

Berbagai teori perubahan perilaku seperti Health Belief Model (HBM), Theory of Planned Behavior (TPB), Social Cognitive Theory (SCT), dan Pendekatan Ekologi Sosial menjadi landasan ilmiah dalam merancang strategi promosi kesehatan. Teori-teori tersebut membantu bidan menganalisis determinan perilaku, seperti persepsi risiko, norma sosial, self-efficacy, serta faktor lingkungan dan kebijakan.

Media promosi kesehatan meliputi media cetak, audiovisual, media massa, hingga media digital dan media sosial. Pemilihan media harus mempertimbangkan

karakteristik sasaran, tujuan edukasi, serta konteks sosial budaya. Media yang tepat akan memperkuat efektivitas metode promosi kesehatan.

Metode promosi kesehatan dalam kebidanan komunitas dapat berupa konseling individu, diskusi kelompok, demonstrasi, simulasi, kunjungan rumah, hingga penyuluhan massal. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan teori perubahan perilaku yang mendasari permasalahan.

Strategi perubahan perilaku dalam pelayanan KIA memerlukan tahapan sistematis, mulai dari identifikasi masalah, analisis determinan perilaku, pemilihan metode dan media, implementasi intervensi, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi promosi kesehatan tidak bersifat sporadis, tetapi terencana dan berbasis bukti.

Akhirnya, evaluasi kompetensi mahasiswa dilakukan melalui OSCE dan DOPS untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan komunikasi, penggunaan media, serta menunjukkan sikap profesional dan empatik dalam praktik kebidanan komunitas.

M. Glosarium

Promosi Kesehatan

Upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat dalam mengendalikan faktor penentu kesehatan guna mencapai derajat kesehatan optimal.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Proses penyampaian pesan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, dan mendorong perubahan perilaku.

Outcome-Based Education (OBE)

Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian kompetensi yang terukur dan aplikatif.

Health Belief Model (HBM)

Teori yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi risiko, keparahan, manfaat, dan hambatan.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan kontrol diri yang dirasakan.

Self-efficacy

Keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melakukan tindakan kesehatan.

Pendekatan Ekologi Sosial

Model yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, komunitas, dan kebijakan.

Primary Health Care (PHC)

Pendekatan pelayanan kesehatan dasar yang menekankan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan akses yang merata.

Respectful Maternity Care (RMC)

Pelayanan kebidanan yang menghormati martabat, hak, dan kebutuhan perempuan.

Media Promosi Kesehatan

Sarana untuk menyampaikan pesan kesehatan, seperti leaflet, video, dan media digital.

Metode Promosi Kesehatan

Cara penyampaian edukasi kesehatan, seperti konseling, diskusi, dan demonstrasi.

OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

Metode evaluasi keterampilan klinis melalui simulasi terstruktur.

DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)

Penilaian keterampilan melalui observasi langsung dalam praktik nyata.

Scaffolding

Pendekatan pembelajaran bertahap dari memahami hingga melakukan praktik.

Strategi Perubahan Perilaku

Rangkaian intervensi terencana untuk memodifikasi perilaku kesehatan berdasarkan teori dan konteks sosial.

N. Referensi

- Bambang, T. B. P. H., Pihahay, P. J., Soripet, M., Bahrah, B., Pongoh, A., & Isnaini, Y. S. (2023). Hubungan pengetahuan dengan sikap ibu hamil terhadap vaksin COVID-19 di Puskesmas SP IV Prafi Kabupaten Manokwari Tahun 2022. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 12(1), 9–16.
- Basch, C. H., Hillyer, G. C., & Jaime, C. (2022). COVID-19 on TikTok: Harnessing an emerging social media platform to convey important public health messages. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 34(2), 1–7.
- Dellayani, N. M. W., Immawati, I., & Sari, S. A. (2026). Implementasi pendidikan kesehatan dengan media booklet terhadap pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar anak bawah lima tahun (balita) di Puskesmas Ganjar Agung. *Jurnal Cendekia Muda*, 6(3), 476–483.
- Ikatan Bidan Indonesia. (2021). *Standar kompetensi bidan Indonesia*. IBI.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.
- International Confederation of Midwives. (2019). *International code of ethics for midwives*. ICM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi sistem kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan RI.
- Madathil, K. C., Rivera-Rodriguez, A. J., Greenstein, J. S., & Gramopadhye, A. K. (2015). Healthcare information on YouTube: A systematic review. *Health Informatics Journal*, 21(3), 173–194.
- Maryam, S. (2024). Efektivitas media promosi kesehatan dalam pelayanan kesehatan remaja: Literature review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4), 11372–11378.
- Moorhead, S. A., Hazlett, D. E., Harrison, L., Carroll, J. K., Irwin, A., & Hoving, C. (2013). A new dimension of health care: Systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. *Journal of Medical Internet Research*, 15(4), e85.
- Nahuway, E., Pihahay, P. J., & Iryani, D. (2024). The role of information media, healthcare provider support, and family in predicting tetanus toxoid immunization knowledge: A case study on pregnant women in Manokwari. In *Proceeding International Conference on Health Polytechnic Ministry of Health Surabaya*.

- Pihahey, P. J. (2025). Health Belief Model: Analysis of maternal perception on completeness of child immunization status in Manokwari, West Papua. *Journal of Maternal and Child Health*, 10(1), 29–41.
- Pihahey, P. J., Laelaem, F., & Padwa, A. E. (2024). Peningkatan ketrampilan edukasi imunisasi bagi kader Posyandu dengan lembar balik imunisasi dasar lengkap 0–9 bulan di Puskesmas Pasir Putih Manokwari Papua Barat. *Journal of Public Health and Community Service*, 3(2), 65–69.
- Qurrotul, S., Setyawan, M. H., & Pandu, M. (2023). Efektivitas edukasi melalui video terhadap pengetahuan dan sikap orang tua terhadap imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Bandarharjo. In *Prosiding Seminar Kesehatan Masyarakat* (Vol. 1, pp. 173–178).
- Randolph, W., & Viswanath, K. (2004). Lessons learned from public health mass media campaigns. *Annual Review of Public Health*, 25, 419–437.
- Safrudin, M. B., Bagaskara, R., Saputri, F. A., Hanani, A., Noor, S. I., & Moura, M. (2026). Literature review: Media promosi kesehatan. *Journal Sains Student Research*, 4(1), 193–203.
- Wakefield, M. A., Loken, B., & Hornik, R. C. (2010). Use of mass media campaigns to change health behaviour. *The Lancet*, 376(9748), 1261–1271.
- White Ribbon Alliance. (2011). *Respectful maternity care: The universal rights of childbearing women*. WRA.
- World Health Organization. (1978). *Declaration of Alma-Ata*. WHO.
- World Health Organization. (1986). *Ottawa charter for health promotion*. WHO.
- World Health Organization. (2018). *Declaration of Astana on primary health care*. WHO.

PROFIL PENULIS



Maria F. Nining Kosad, SST., M.Kes., Lahir di Kupang, 10 November 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan. Pendidik pada Program Studi Kedokteran, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjra Madah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2006. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun Pengalaman bekerja Sebagai Bidan PTT di Desa Seki Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Tahun 1995–1997, Bidan

PTT merangkap Kepala Puskesmas Pembantu di desa Kuanheum Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Propinsi NTT Tahun 1997-1998. Tahun 2001-sekarang Sebagai Dosen pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Gender dan PUG, Askeb Komunitas, Etikolegal dalam Praktik Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: 10niningkosad11@gmail.com



Bdn. Vepti Triana Mutmainah, M.Kes. Dosen Program Studi Kebidanan Program Profesi Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia. Penulis lahir di Magelang tanggal 18 Juli 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kebidanan Program Profesi, Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia. Menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang, D4 Kebidnaan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dan melanjutkan S2 Kesehatan UNDIP Tahun 2010. Saat ini penulis sedang menempuh

Pendidikan S3 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi, Evidence based pada Asuhan Kebidanan dan komunikasi kesehatan.

PROFIL PENULIS



Rizky Febriyanti Supriadi, S.ST., M.Keb., adalah dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mamuju. Lahir di Samarinda, penulis memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dengan catatan prestasi sebagai lulusan terbaik pada program D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kaltim, D4 Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung, serta Magister Kebidanan Universitas Brawijaya Malang. Bidang keahlian dan fokus riset yang ditekuninya saat ini adalah Asuhan Kebidanan Tumbuh Kembang Anak. Penulis secara konsisten menjalankan pilar Tridharma Perguruan

Tinggi melalui kontribusi aktif dalam penulisan buku teks, buku ajar, serta berbagai publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. Korespondensi dengan penulis dapat dilakukan melalui email: rizkyfebriyanti.s@gmail.com.

Sinopsis

Buku ajar “Kebidanan Komunitas: Posyandu, KIA, dan Pelayanan Berbasis Keluarga” disusun sebagai referensi pembelajaran yang membahas peran strategis bidan dalam pelayanan kesehatan primer, khususnya dalam meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga, dan masyarakat. Buku ini menekankan pentingnya pelayanan kebidanan yang tidak hanya berpusat pada individu, tetapi juga berbasis keluarga dan komunitas melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dasar, serta pemberdayaan masyarakat.

Materi dalam buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar kebidanan komunitas dan peran bidan di pelayanan primer. Pembaca diajak memahami ruang lingkup kebidanan komunitas, sasaran pelayanan, prinsip kerja bidan di masyarakat, serta tanggung jawab bidan dalam mendukung sistem kesehatan di tingkat Puskesmas, desa, dan keluarga.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pentingnya pemetaan masalah kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja. Pembahasan mencakup pemanfaatan data, surveilans, analisis situasi, serta penetapan prioritas masalah KIA sebagai dasar dalam menyusun rencana intervensi yang tepat, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Buku ini juga membahas secara komprehensif tentang Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), meliputi tata kelola, alur pelayanan, peran kader, serta strategi pembinaan kader. Posyandu diposisikan sebagai salah satu bentuk pelayanan berbasis masyarakat yang berperan penting dalam pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan ibu hamil, imunisasi, gizi, edukasi kesehatan, serta deteksi dini masalah kesehatan di masyarakat.

Pada bagian berikutnya, pembaca diperkenalkan dengan pelayanan KIA terpadu di Puskesmas dan desa, yang meliputi integrasi pelayanan antenatal care, persalinan, nifas, neonatus, serta rujukan bila ditemukan kondisi risiko. Pembahasan ini bertujuan agar calon bidan mampu memahami kesinambungan pelayanan KIA secara menyeluruh, mulai dari masa kehamilan hingga bayi baru lahir.

Aspek penting lain yang dibahas dalam buku ini adalah kunjungan rumah dan continuity of care. Materi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pencatatan, serta dokumentasi pelayanan kebidanan di keluarga. Melalui pendekatan ini, bidan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan, personal, dan responsif terhadap kebutuhan ibu, bayi, serta keluarga.

Selain itu, buku ini memuat pembahasan mengenai promosi kesehatan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KIA. Topik ini mencakup pemilihan metode, penggunaan media edukasi, teknik komunikasi, serta strategi perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam pelayanan kebidanan komunitas. Dengan penguasaan materi

ini, bidan diharapkan mampu menjadi edukator, motivator, sekaligus fasilitator perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.

Secara keseluruhan, buku ajar ini memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai kebidanan komunitas dengan fokus pada Posyandu, pelayanan KIA, dan pendekatan berbasis keluarga. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa kebidanan, dosen, praktisi, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kompetensi, memperkuat pelayanan primer, serta mendukung terwujudnya kesehatan ibu dan anak yang optimal di masyarakat.

Buku ajar “Kebidanan Komunitas: Posyandu, KIA, dan Pelayanan Berbasis Keluarga” disusun sebagai referensi pembelajaran yang membahas peran strategis bidan dalam pelayanan kesehatan primer, khususnya dalam meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga, dan masyarakat. Buku ini menekankan pentingnya pelayanan kebidanan yang tidak hanya berpusat pada individu, tetapi juga berbasis keluarga dan komunitas melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dasar, serta pemberdayaan masyarakat.

Materi dalam buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar kebidanan komunitas dan peran bidan di pelayanan primer. Pembaca diajak memahami ruang lingkup kebidanan komunitas, sasaran pelayanan, prinsip kerja bidan di masyarakat, serta tanggung jawab bidan dalam mendukung sistem kesehatan di tingkat Puskesmas, desa, dan keluarga. Selanjutnya, buku ini menguraikan pentingnya pemetaan masalah kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja. Pembahasan mencakup pemanfaatan data, surveilans, analisis situasi, serta penetapan prioritas masalah KIA sebagai dasar dalam menyusun rencana intervensi yang tepat, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Buku ini juga membahas secara komprehensif tentang Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), meliputi tata kelola, alur pelayanan, peran kader, serta strategi pembinaan kader. Posyandu diposisikan sebagai salah satu bentuk pelayanan berbasis masyarakat yang berperan penting dalam pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan ibu hamil, imunisasi, gizi, edukasi kesehatan, serta deteksi dini masalah kesehatan di masyarakat. Pada bagian berikutnya, pembaca diperkenalkan dengan pelayanan KIA terpadu di Puskesmas dan desa, yang meliputi integrasi pelayanan antenatal care, persalinan, nifas, neonatus, serta rujukan bila ditemukan kondisi risiko. Pembahasan ini bertujuan agar calon bidan mampu memahami kesinambungan pelayanan KIA secara menyeluruh, mulai dari masa kehamilan hingga bayi baru lahir.

Aspek penting lain yang dibahas dalam buku ini adalah kunjungan rumah dan continuity of care. Materi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pencatatan, serta dokumentasi pelayanan kebidanan di keluarga. Melalui pendekatan ini, bidan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan, personal, dan responsif terhadap kebutuhan ibu, bayi, serta keluarga.

Selain itu, buku ini memuat pembahasan mengenai promosi kesehatan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KIA. Topik ini mencakup pemilihan metode, penggunaan media edukasi, teknik komunikasi, serta strategi perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam pelayanan kebidanan komunitas. Dengan penguasaan materi ini, bidan diharapkan mampu menjadi edukator, motivator, sekaligus fasilitator perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.

Secara keseluruhan, buku ajar ini memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai kebidanan komunitas dengan fokus pada Posyandu, pelayanan KIA, dan pendekatan berbasis keluarga. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa kebidanan, dosen, praktisi, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kompetensi, memperkuat pelayanan primer, serta mendukung terwujudnya kesehatan ibu dan anak yang optimal di masyarakat.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-81-7 (PDF)



9

786347

756817